Módulo 12

Medicamentos isentos de prescrição

Conceito, enquadramento e lista vigente de MIP, atendimento e indicação farmacêutica no balcão, classes e posologia dos MIP mais dispensados e a prescrição farmacêutica regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013.

- Conceito e base legal dos MIP
- Consulta à lista de MIP e armadilhas
- Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica
- Sinais de alerta e encaminhamento
- Populações especiais no balcão
- Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013
- Documentação e ética no atendimento
- Analgésicos e antitérmicos
- Anti-inflamatórios isentos de prescrição
- Aparelho digestivo
- Tosse, gripe e resfriado
- Antialérgicos isentos de prescrição
- Pele e mucosas
- Antiparasitários intestinais
- Vitaminas, minerais e suplementos
- Olhos, ouvidos e boca
- Outros produtos de balcão

Conceito e base legal dos MIP

Medicamento isento de prescrição (MIP) é aquele que **pode ser dispensado sem exigência de prescrição**. A definição está na norma que hoje rege o tema, a RDC nº 882/2024 da Anvisa (art. 2º, I). No mercado, o MIP também é chamado de medicamento de venda livre ou OTC (do inglês *over the counter*). O termo "venda livre" engana: o MIP continua sendo medicamento, só pode ser comercializado em farmácia ou drogaria e exige orientação de quem o dispensa.

A categoria de venda pertence ao *produto registrado* e a cada uma das suas apresentações. A mesma substância pode ser MIP em uma forma farmacêutica e concentração e exigir receita em outra. Por isso, no balcão, a verificação se faz sobre a apresentação que está na mão do cliente e a indicação pretendida.

Arcabouço legal

O enquadramento do MIP se apoia em leis federais, que dão a moldura, e em normas da Anvisa, que detalham critérios, lista, exposição e propaganda. O estudante precisa saber o papel de cada uma, porque provas e fiscalizações cobram exatamente essa correspondência.

Norma	O que interessa para o MIP
Lei nº 5.991/1973	Define dispensação (art. 4º, XV) e drogaria (art. 4º, XI). O comércio de medicamentos é privativo das empresas e estabelecimentos definidos na lei (art. 5º) e a dispensação é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento, unidade volante e dispensário (art. 6º). Vale para o MIP.
Lei nº 13.021/2014	Farmácia é unidade de prestação de serviços de assistência farmacêutica e assistência à saúde (art. 3º). Exige farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (art. 6º, I) e impõe ao farmacêutico o dever de orientar sobre benefício e risco, conservação, uso e interações (art. 13, VI).
RDC nº 882/2024	Critérios e procedimentos para enquadrar um medicamento como MIP e para reenquadrá-lo como sob prescrição. Em vigor desde 1º/7/2024. Revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27).
IN nº 285/2024	Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), em vigor desde 1º/4/2024, com anexos atualizados pela IN nº 388/2025 (art. 1º e Anexo II) e pela IN nº 404/2025 (Anexo I).
RDC nº 44/2009	Boas práticas em farmácias e drogarias: MIP pode ficar ao alcance do usuário (art. 40, §2º), cartaz obrigatório (art. 41), venda remota (art. 52) e Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).
RDC nº 96/2008	Propaganda e publicidade de medicamentos. Só o MIP pode ser anunciado ao público leigo, com advertências obrigatórias (arts. 22 a 26).
Lei nº 6.437/1977	Tipifica as infrações sanitárias. A RDC nº 882/2024 remete a ela em caso de descumprimento (art. 21).

Até 2016 o enquadramento seguia a RDC nº 138/2003, que trabalhava com uma relação de grupos e indicações terapêuticas especificadas (a chamada lista GITE): era isento o medicamento cujo grupo e indicação apareciam na relação. A RDC nº 98/2016 trocou esse modelo por critérios técnicos explícitos e por uma lista de fármacos (a LMIP), publicada por Instrução Normativa: IN nº 11/2016, IN nº 86/2021, IN nº

120/2022 e, hoje, IN nº 285/2024. Em 2024 a RDC nº 98/2016 foi substituída pela RDC nº 882/2024, que manteve a lógica de critérios mais lista. Material didático antigo que ainda cita a RDC nº 98/2016 como vigente está desatualizado.

Critérios de enquadramento

A RDC nº 882/2024 exige que o medicamento comprove, ao mesmo tempo, todos os critérios do art. 4º. Eles explicam por que alguns fármacos são MIP e outros, muito usados, não são.

Critério (art. 4º)	O que significa na prática
I. Tempo de comercialização	10 anos de mercado, sendo pelo menos 5 no Brasil como medicamento sob prescrição; ou 5 anos no exterior como isento, em país com critérios compatíveis. Vale para as mesmas concentrações, posologia, indicações, população, via e restrições.
II. Segurança	Reações adversas conhecidas e reversíveis com a suspensão; baixo potencial de toxicidade (efeito grave só com grande quantidade, janela terapêutica segura); baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar clinicamente relevante.
III. Indicação	Doença não grave, de evolução inexistente ou muito lenta, com sinais e sintomas facilmente percebidos pelo paciente, pelo cuidador ou pelo farmacêutico, sem necessidade de exame laboratorial ou consulta com prescritor.
IV. Tempo de uso	Uso por curto período ou pelo tempo previsto em bula, exceto os de uso preventivo.
V. Manejo	Manejável pelo próprio paciente, pelo cuidador ou mediante orientação do farmacêutico.
VI. Baixo risco de mau uso, abuso e intoxicação	Pouco risco de uso para outra finalidade, de uso acima da dose ou do tempo recomendados e de intoxicação.
VII. Dependência	Não pode ter potencial de causar dependência.

O QUE DIZ A NORMA

"As formas farmacêuticas injetáveis e os produtos de terapia avançada não são passíveis de enquadramento como MIP." (RDC nº 882/2024, art. 5º). E ainda: o enquadramento de fármacos isolados como MIP "não garante que a associação em doses fixas ou razão fixa de doses seja enquadrada como MIP" (art. 10).

O art. 10 é uma das regras mais cobradas. Se o paracetamol e a cafeína são MIP isoladamente, a associação dos dois precisa cumprir de novo os critérios do art. 4º. A única facilidade é que o prazo de comercialização do inciso I é dispensado quando todos os componentes já fazem parte de um MIP.

Quem pede, quem decide e quanto tempo leva

O farmacêutico de balcão não pede enquadramento. Quem solicita é a empresa detentora do registro. Há dois caminhos:

- **Na petição de registro** de um medicamento novo, com os dados que sustentam o enquadramento (art. 6º). Esse caminho não se aplica a genéricos e similares (art. 6º, §2º).
- **Por petição de enquadramento** de um medicamento já registrado como sob prescrição, para todas as condições aprovadas ou só para parte delas, como uma concentração menor, uma indicação ou uma população (art. 7º).

A empresa apresenta relatório técnico e o Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (art. 9º). A decisão é da Diretoria Colegiada da Anvisa e se materializa na atualização da LMIP (art. 11). Depois da publicação, as empresas têm 180 dias para adequar o registro (art. 13) e, se o produto for excluído da lista por deixar de cumprir algum critério, outros 180 dias para voltar à categoria sob prescrição (art. 17). O enquadramento pode ser revisto a qualquer momento (art. 20).

Duas regras finais da RDC nº 882/2024 mudam a rotina de quem confere categoria de venda:

- Medicamentos registrados como MIP antes da lista e que não aparecem nela **continuam MIP** até que a Anvisa avalie a pertinência do enquadramento (art. 18). A ausência na LMIP não transforma, sozinha, um MIP antigo em medicamento tarjado.
- Um mesmo registro pode ter apresentações isentas e apresentações sob prescrição, desde que distinguíveis por rótulo, bula e complemento de nome (art. 14). O complemento de nome é dispensado nos genéricos (art. 14, §2º).

Exposição, autosserviço e venda a distância

A RDC nº 44/2009 manda manter os medicamentos em área de circulação restrita aos funcionários (art. 40, §1º). O MIP é a exceção: pode permanecer ao alcance dos usuários, em autosserviço (art. 40, §2º, com redação da RDC nº 41/2012). Para isso há três condições:

- MIP do mesmo princípio ativo, ou da mesma associação, ficam juntos e identificados de forma visível pela DCB (art. 41, §1º).
- MIP ficam separados dos demais produtos da área de autosserviço, como cosméticos e alimentos (art. 41, §2º).
- Na área de medicamentos deve haver cartaz legível com a frase "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41).

Um medicamento recém-enquadrado só pode ir para o autosserviço depois que a empresa adequar bula e rotulagem (RDC nº 882/2024, art. 19). Na venda por telefone ou internet, o MIP pode ser dispensado por farmácia ou drogaria aberta ao público, com farmacêutico presente durante todo o horário (RDC nº 44/2009, art. 52). Para medicamento sujeito a prescrição solicitado a distância, a receita precisa ser apresentada e avaliada pelo farmacêutico (art. 52, §1º); para controlados, a venda remota é vedada, salvo exceção prevista em norma específica (art. 52, §2º, redação da RDC nº 812/2023).

Propaganda, embalagem e bula

Pela RDC nº 96/2008, só o MIP pode ser anunciado ao público em geral. Medicamento sob prescrição tem propaganda restrita a meios dirigidos a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar (art. 27). A peça de MIP deve trazer nome comercial, DCB com pelo menos 50% do tamanho do nome comercial e número de registro (art. 22), além da advertência específica da substância ou, na falta dela, a frase padrão

"É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA" (art. 23).

São vedados, entre outros: estimular o uso indiscriminado, sugerir diagnóstico ao público, mostrar pessoas usando o medicamento (art. 8º), usar expressões como "comprovado cientificamente" e sugerir que o MIP dispensa hábitos saudáveis ou a consulta médica (art. 26). Programas de fidelidade da farmácia não podem usar medicamentos como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio (art. 10). Comparação de preços dirigida ao consumidor só pode ser feita entre medicamentos intercambiáveis (art. 11).

Na embalagem, o MIP não traz tarja; o medicamento sob prescrição traz a tarja vermelha com a frase de restrição. Quando coexistem apresentações isentas e tarjadas no mesmo registro, rótulo, bula e complemento de nome precisam permitir distinguir uma da outra (RDC nº 882/2024, art. 14, §1º). Na mudança de categoria, a única alteração permitida no texto de bula é a decorrente da própria mudança (art. 13, §2º).

O que o enquadramento como MIP não autoriza

ATENÇÃO

Isento de prescrição não significa isento de risco. Os critérios falam em risco *baixo* nas condições de uso da bula. Fora delas o perfil muda: paracetamol acima da dose máxima lesa o fígado, dipirona pode causar agranulocitose, AINE causa sangramento digestivo e lesão renal, anti-histamínico de primeira geração seda e provoca quedas no idoso, descongestionante sistêmico eleva a pressão arterial.

- Não autoriza venda fora de farmácia ou drogaria (Lei nº 5.991/1973, arts. 5º e 6º).
- Não dispensa a orientação: o dever de orientar é do farmacêutico, em qualquer dispensação (Lei nº 13.021/2014, art. 13, VI; RDC nº 44/2009, art. 42).
- Não torna o MIP adequado para qualquer pessoa: gestantes, crianças pequenas, idosos frágeis e pacientes com doença crônica exigem avaliação própria.
- Não autoriza uso prolongado: o critério IV pressupõe uso curto ou pelo tempo da bula. Sintoma que persiste além do prazo da bula é motivo de encaminhamento.
- Não libera a indicação por quem não é farmacêutico. Indicar um MIP para um problema de saúde relatado pelo cliente é ato do farmacêutico, que o documenta (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV; RDC nº 44/2009, art. 81, §2º, I, b).
- Não permite propaganda livre nem bonificação de balconista para "empurrar" marca.

NO BALCÃO

Quando o cliente pega um MIP na gôndola e vai direto ao caixa, a dispensação não acabou. Um contato curto resolve a maior parte dos riscos: "Para quem é? Já usou antes? Usa algum outro remédio? Tem pressão alta, problema de estômago, de rim ou está grávida?". Em seguida, reforce dose máxima, intervalo e por quantos dias usar antes de procurar atendimento.

CASO

Senhora de 68 anos leva da gôndola três caixas de um antigripal com paracetamol, fenilefrina e clorfeniramina e um frasco de dipirona. Na conversa, conta que é hipertensa e que "a gripe já dura cinco dias". O farmacêutico explica que a fenilefrina pode elevar a pressão, que a clorfeniramina é anti-histamínico de primeira geração (sedação e risco de queda), que a associação com outro analgésico duplica o efeito antitérmico sem necessidade e que a quantidade é excessiva. Orienta repouso, hidratação e soro fisiológico nasal, indica um analgésico isolado em dose correta e combina reavaliação: se a febre passar de três dias, deve procurar atendimento.

Consulta à lista de MIP e armadilhas

A Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) é publicada pela Instrução Normativa nº 285/2024 e atualizada por outras INs que alteram seus anexos. Saber ler a lista evita dois erros opostos: vender sem receita um produto tarjado e recusar sem motivo um MIP legítimo.

Estrutura da lista

A IN nº 285/2024 tem dois anexos. O Anexo I reúne medicamentos sintéticos, específicos e biológicos, em colunas: fármaco, subgrupo terapêutico ou farmacológico (código ATC), forma farmacêutica, concentração máxima e indicação terapêutica simplificada. O Anexo II reúne os fitoterápicos, em colunas: espécie, classe terapêutica, parte empregada, indicações e via de administração. A RDC nº 882/2024 (art. 12, §1º e §2º) fixa esse conteúdo mínimo e acrescenta as restrições de uso.

O QUE DIZ A NORMA

A caracterização como isento "ocorre para um produto com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêutica, indicação(ões) terapêutica(s) e com concentração igual ou inferior àqueles indicados em cada linha da LMIP". A coluna "concentração máxima" "refere-se à dose do insumo farmacêutico ativo presente na forma farmacêutica, não se referindo à dose posológica" (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, I e II).

Para fitoterápicos, a isenção vale para produto com a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha (art. 1º, §3º). As indicações da lista são simplificações das indicações da bula do profissional (art. 1º, §1º).

Como consultar no dia a dia

1. Abra o texto consolidado da IN nº 285/2024 no AnvisaLegis (sistema de legislação da Anvisa). O próprio texto mostra "redação dada por" em cada anexo, o que garante que a versão é a atual. Em outubro de 2026, o Anexo I estava com a redação da IN nº 404/2025 e o Anexo II com a da IN nº 388/2025.
2. Busque pela DCB do fármaco, inclusive o sal ("cloridrato de", "maleato de"), e leia todas as linhas: um fármaco costuma ter uma linha por forma farmacêutica.
3. Compare quatro elementos com o produto na mão: fármaco ou associação, forma farmacêutica, concentração por unidade e indicação pretendida.

4. Confirme na embalagem (ausência de tarja) e, se houver dúvida, na consulta de produtos registrados da Anvisa. Lembre que MIP antigos fora da lista mantêm a categoria até reavaliação (RDC nº 882/2024, art. 18).

PONTO-CHAVE

A categoria de venda depende do conjunto fármaco, forma farmacêutica, concentração, indicação e via. Mudou qualquer um desses elementos, mudou a análise.

Armadilhas mais comuns

Os exemplos abaixo foram conferidos no texto consolidado da LMIP (IN nº 285/2024, Anexo I, redação da IN nº 404/2025). Eles mostram como a mesma substância muda de categoria conforme apresentação, associação e via.

Situação	Na LMIP	Fora da LMIP (exige análise do registro, em geral tarjado)
Via de administração	Diclofenaco gel e solução dermatológica (dor musculoesquelética); nimesulida gel 20 mg/g; cetoconazol creme e xampu; metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea)	Diclofenaco, nimesulida e cetoconazol por via oral; metronidazol oral
Concentração e forma	Ibuprofeno 400 mg (comprimido, cápsula); liberação prolongada 600 mg (200 mg imediata + 400 mg prolongada); suspensão oral até 200 mg/mL	Ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata
População	Ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL tem indicação restrita a adultos	Uso dessa concentração em criança
Indicação específica	Omeprazol 20 mg cápsula, para alívio de azia e queimação frequentes (dois ou mais dias na semana), incluído pela IN nº 404/2025	Omeprazol 40 mg; outros inibidores da bomba de prótons; uso para outras indicações
Associação	Maleato de dexclorfeniramina isolado (comprimido, creme, solução oral); nafazolina em colírio associado à feniramina ou ao sulfato de zinco	Dexclorfeniramina associada a corticoide sistêmico (o corticoide não é MIP; RDC nº 882/2024, art. 10)
Antiparasitários	Mebendazol comprimido 500 mg e suspensão 20 mg/mL; permetrina emulsão ou suspensão dermatológica 10 mg/mL (pediculose) e 50 mg/mL (escabiose)	Albendazol e ivermectina não constam da lista
Antifúngicos	Clotrimazol creme dermatológico e vaginal, comprimido vaginal 500 mg; miconazol creme e creme vaginal; terbinafina creme e solução tópica; ciclopirox esmalte	Fluconazol, itraconazol e terbinafina por via oral não constam
Corticoide tópico	Acetato de hidrocortisona creme ou pomada 10 mg/g	Outros corticoides tópicos não constam: confira o registro

Outras linhas que costumam surpreender o estudante: fenazopiridina 200 mg (alívio de dor e ardor ao urinar, sem tratar a infecção); nicotina em adesivo de até 21 mg e em goma ou pastilha de até 4 mg; naproxeno 500 mg e naproxeno sódico 550 mg; butilbrometo de escopolamina 10 mg e suas associações com dipirona ou paracetamol; sulfato de neomicina pomada; penciclovir creme 10 mg/g para herpes labial; anti-histamínicos de segunda geração (loratadina, desloratadina, levocetirizina, fexofenadina 180 mg, ebastina).

ATENÇÃO

Estar na LMIP não torna o produto adequado para a queixa do cliente. A fenazopiridina alivia o ardor, mas pode mascarar uma infecção urinária que precisa de antibiótico; o omeprazol MIP é para azia frequente sem sinais de alarme e por curso curto, conforme a bula; o neomicina tópico não trata infecção de pele extensa. A lista informa a categoria de venda; a adequação ao paciente depende da avaliação do farmacêutico.

Fitoterápicos isentos

No Anexo II a análise é por espécie, parte da planta e indicação, e a via aparece na própria coluna de indicação. Exemplos: *Aesculus hippocastanum* (castanha-da-índia), sementes, uso oral, para sintomas de insuficiência venosa nas pernas; *Arnica montana*, capítulo floral, uso tópico, para equimoses e contusões; *Althaea officinalis*, raízes, uso oral, para irritação da garganta e tosse seca associada. Um produto de arnica para uso oral, por exemplo, não se apoia nessa linha.

Mudanças da lista

A LMIP muda com frequência. Em 2025, a IN nº 388/2025 alterou o Anexo II e o art. 1º, e a IN nº 404/2025 reescreveu o Anexo I, incluindo o omeprazol 20 mg. Novas inclusões costumam levar até 180 dias para chegar ao mercado, porque as empresas precisam adequar bula e rotulagem antes do autosserviço (RDC nº 882/2024, arts. 13 e 19). Nesse intervalo podem coexistir no estoque caixas antigas com tarja e caixas novas sem tarja do mesmo produto.

NO BALCÃO

Monte na farmácia um atalho para o texto consolidado da LMIP e consulte sempre que um cliente pedir "sem receita" um produto que você não tem certeza. Antes de responder, olhe a caixa: forma farmacêutica, concentração e tarja. Se a apresentação pedida é tarjada, ofereça a alternativa isenta quando ela existir e fizer sentido clinicamente, ou encaminhe.

CASO

Homem de 45 anos pede "diclofenaco em comprimido" para dor nas costas após carregar peso, sem outros sintomas. O comprimido oral é tarjado e não pode ser vendido sem receita. O farmacêutico confirma que não há sinais de alerta (sem febre, sem perda de força, sem alteração urinária, sem trauma grave), indica diclofenaco gel, que está na LMIP, orienta aplicação local, calor e retorno às atividades leves, e combina procurar atendimento se a dor não melhorar ou se surgir qualquer sinal de alerta.

Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica

No balcão, três atos diferentes costumam ser chamados pelo mesmo nome de "atendimento". Separá-los é o primeiro passo para agir dentro da lei e documentar corretamente.

- **Dispensação**: fornecimento do medicamento ao usuário, a título remunerado ou não (Lei nº 5.991/1973, art. 4º, XV), acompanhado de orientação. Pode partir de uma receita ou de um pedido de MIP pelo nome.
- **Indicação farmacêutica**: o cliente relata um sintoma e pede ajuda; o farmacêutico avalia, decide se o problema é autolimitado e pode ser manejado na farmácia e, se for, seleciona um MIP ou uma medida não farmacológica. Corresponde ao "manejo de problemas de saúde autolimitados" das atribuições clínicas (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV).
- **Prescrição farmacêutica**: ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º), com documento próprio e registro do processo. Sua situação jurídica está discutida no tópico sobre a Resolução nº 586/2013.

Aspecto	Dispensação	Indicação	Prescrição farmacêutica
Começa com	Receita ou pedido de produto	Queixa ou sintoma	Necessidade de saúde avaliada em consulta
Decisão clínica do farmacêutico	Avaliar a receita e orientar	Escolher se trata e com quê	Selecionar, documentar e acompanhar a terapia
Documento	Receita (quando houver) e registros sanitários	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição (Res. nº 586/2013, art. 9º)

Na prática, um mesmo atendimento pode passar por mais de um ato. O cliente pede um xarope pelo nome (pedido de MIP), conta que a tosse dura três semanas (dado de anamnese) e sai encaminhado ao médico (desfecho da avaliação). A qualidade do atendimento se mede pelo raciocínio aplicado e registrado.

Etapas do atendimento de uma queixa

Os guias de prática clínica do Conselho Federal de Farmácia (série do ProFar: espirro e congestão nasal, 2016; febre, 2018; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) organizam o atendimento em etapas fixas, as mesmas para qualquer sintoma:

1. **Acolhimento da demanda**: receber o cliente, ouvir o motivo da procura e levá-lo, se necessário, a um local reservado.
2. **Anamnese farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos**: coletar dados por entrevista e, quando útil, medir pressão arterial ou temperatura.
3. **Identificação da necessidade e dos alertas**: decidir se o problema parece autolimitado ou se há situação que exige encaminhamento.
4. **Plano de cuidado**: encaminhamento, terapia não farmacológica, terapia farmacológica com MIP e educação do paciente, combinados com ele.
5. **Avaliação dos resultados**: retorno ou contato combinado para saber se o problema se resolveu.

A Resolução CFF nº 585/2013 define anamnese farmacêutica como o "procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde" (glossário).

Roteiros de anamnese

Para não esquecer perguntas no ritmo do balcão, farmacêuticos de vários países usam roteiros mnemônicos. Eles vêm da prática britânica (difundidos em obras como *Symptoms in the Pharmacy*, de Blenkinsopp e Paxton, citada nas referências da Resolução CFF nº 586/2013) e funcionam bem como lembrete. Não substituem o raciocínio: o roteiro serve para coletar dados, e a decisão vem da comparação com os sinais de alerta.

Roteiro	Letras (em inglês)	Pergunta correspondente
WWHAM	Who; What; How long; Action; Medication	Para quem é? Quais os sintomas? Há quanto tempo? O que já fez ou usou? Que medicamentos usa?
ASMETHOD	Age/appearance; Self or someone else; Medication; Extra medicines; Time persisting; History; Other symptoms; Danger symptoms	Idade e aparência; é para a própria pessoa?; medicamentos de uso contínuo; outros produtos já tentados; duração; história clínica; outros sintomas; sintomas de perigo
SIT DOWN SIR	Site; Intensity; Type; Duration; Onset; With; aNnoyed by; Spread; Incidence; Relieved by	Local, intensidade, tipo, duração, início, sintomas associados, o que piora, irradiação, frequência e o que alivia. Útil para dor.
ENCORE	Explore; No medication; Care; Observe; Refer; Explain	Explorar o problema; considerar não usar medicamento; cuidado em populações especiais; observar o paciente; encaminhar quando preciso; explicar a conduta

Os guias do CFF não adotam um acrônimo, mas cobrem os mesmos domínios. Uma forma prática de lembrar em português:

- **Quem**: idade, peso (em criança), gestação, amamentação, se o paciente está presente.
- **O quê**: sintoma principal, local, intensidade, características.
- **Desde quando**: início, duração, evolução (melhorando, igual, piorando), episódios anteriores.
- **Com o quê**: sintomas associados, febre, sinais de gravidade.
- **O que já fez**: medicamentos e medidas já tentados, dose, resultado.
- **O que mais tem e usa**: doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo, alergias, álcool, tabaco.

NO BALCÃO

Comece com pergunta aberta ("Me conte o que está sentindo") e só depois feche com perguntas diretas. Quando o pedido é para outra pessoa, pergunte idade, peso e se ela pode vir ou falar ao telefone: sem esses dados, a avaliação fica incompleta e o mais seguro pode ser não indicar. Ao final, peça que o cliente repita como vai usar o medicamento; isso confirma que a orientação foi entendida.

Parâmetros clínicos e seus limites

A RDC nº 44/2009 permite aferir pressão arterial e temperatura corporal (art. 69, §1º) e executar exames de análises clínicas nos termos da legislação vigente (art. 61, §2º). Hoje essa legislação é a RDC nº 978/2025, que revogou a RDC nº 786/2023: a farmácia que faz exames é serviço tipo I, só com amostra por punção capilar (como a glicemia), coleta em cavidade oral ou swab de nasofaringe ou orofaringe (redação da RDC 986/2025), todas as etapas no próprio estabelecimento e controle de qualidade. Esses dados servem para assistência e orientação, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (art. 69). Se o valor estiver fora da referência, o usuário deve ser orientado a procurar assistência médica (art. 69, §3º) e não podem ser indicados ou alterados medicamentos de venda sob prescrição (art. 69, §4º). A Declaração de Serviço Farmacêutico, nesses casos, leva a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (art. 81, §2º, I, d).

Plano de cuidado e orientação

Quando não há alerta, o plano costuma combinar medida não farmacológica e um MIP. A escolha leva em conta eficácia, segurança para aquele paciente, custo e conveniência, que são os mesmos critérios da Resolução nº 586/2013 (art. 7º, III). A orientação mínima inclui:

- nome do medicamento pela DCB, dose, intervalo e dose máxima diária;
- como usar (com ou sem alimento, como medir, como aplicar);
- por quanto tempo usar e quando parar;
- efeitos esperados e reações que exigem suspensão;
- o que evitar (álcool, outro produto com o mesmo fármaco, atividades de risco se houver sedação);
- quando procurar atendimento: piora, sinais de alerta ou ausência de melhora no prazo combinado.

A Lei nº 13.021/2014 (art. 13, VI) e a RDC nº 44/2009 (art. 42, §2º) listam como elementos da orientação a posologia, a influência dos alimentos, as interações, as reações adversas e a conservação.

Registro, consultório e retorno

Atendimento clínico sem registro não pode ser avaliado nem defendido. A RDC nº 44/2009 exige que as atividades de atenção farmacêutica sejam documentadas "de forma sistemática e contínua, com o consentimento expresso do usuário" (art. 64, §1º). O registro deve conter, no mínimo, nome, endereço e telefone do usuário, as orientações e intervenções realizadas, os resultados e a identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (art. 64, §2º). O serviço deve ter protocolos com referências e indicadores (art. 64) e o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).

O consultório farmacêutico é o "lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica", e pode funcionar como dependência de farmácia comunitária (Resolução CFF nº 585/2013, glossário). Do ponto de vista sanitário, o serviço precisa constar do licenciamento do estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 61, §3º e §4º). Do ponto de vista profissional, o registro de clínicas e consultórios farmacêuticos no CRF tem regulamentação própria do CFF; consulte o seu Conselho Regional.

O retorno completa o atendimento. Combine com o paciente quando ele deve estar melhor e o que fazer se não estiver. Em farmácia comunitária, isso pode ser um telefonema no terceiro dia ou o pedido para voltar se a febre persistir. O resultado vai para o registro.

CASO

Mulher de 29 anos chega pedindo "algo para dor de cabeça". Na anamnese: dor em pressão nos dois lados, iniciada no fim da tarde, sem febre, sem vômitos, sem alteração visual, padrão igual ao de outras vezes; não está grávida; usa apenas anticoncepcional oral. Não há sinais de alerta. O farmacêutico indica paracetamol em dose de adulto conforme a bula, orienta hidratação, pausa de telas e sono regular, explica que dor de cabeça frequente com uso de analgésico em muitos dias do mês precisa de avaliação médica, entrega a Declaração de Serviço Farmacêutico e registra o atendimento.

Sinais de alerta e encaminhamento

Sinal de alerta (em inglês, *red flag*) é qualquer dado da anamnese que sugere doença grave, não autolimitada ou fora do alcance do MIP. A presença de um único alerta basta para encaminhar. O objetivo da triagem é reconhecer que o caso foge do manejo na farmácia; o diagnóstico fica com o serviço que recebe o encaminhamento.

Os guias de prática clínica do CFF repetem uma regra geral que vale para qualquer queixa: encaminhar quando os sinais e sintomas forem persistentes, intensos ou recorrentes, quando não houver alívio com o tratamento prévio e sempre que houver dúvida sobre a necessidade de saúde do paciente. A RDC nº 44/2009 determina que o farmacêutico oriente o usuário a buscar outros profissionais quando julgar necessário (art. 66) e que a farmácia mantenha lista atualizada dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos, com endereço e telefone (art. 62).

Três níveis de resposta

Situação	Conduta	Exemplos
Problema autolimitado, sem alerta	Medidas não farmacológicas, MIP se necessário, orientação, prazo de reavaliação, registro	Resfriado comum, azia ocasional após refeição pesada, dor muscular por esforço
Alerta sem sinal de gravidade imediata	Encaminhar a consulta (unidade básica ou médico assistente), por escrito quando possível; evitar tratamento que mascare o quadro	Tosse há mais de três semanas, azia com perda de peso, disúria com febre baixa

Situação	Conduta	Exemplos
Sinal de gravidade	Encaminhar imediatamente a pronto atendimento ou acionar o SAMU (192); não oferecer MIP como substituto	Dor no peito com suor frio e falta de ar, rigidez de nuca com febre, desmaio, sangramento digestivo, bebê com menos de 2 meses com febre

ATENÇÃO

Tratar um sintoma de alerta com MIP pode atrasar o diagnóstico. O guia de febre do CFF lembra que, na suspeita de doença grave, o antitérmico pode "descaracterizar os sinais e sintomas e prejudicar o processo diagnóstico". Em suspeita de dengue e outras arboviroses, o mesmo guia orienta evitar ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroides.

Sinais de alerta por queixa

O quadro a seguir reúne as queixas mais comuns do balcão. Os prazos vêm dos guias de prática clínica do CFF (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) e do Caderno de Atenção Básica nº 28, volume II, do Ministério da Saúde (acolhimento à demanda espontânea). Quando a bula do MIP fixar prazo menor, vale o da bula.

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Dor de cabeça	Início súbito e muito forte; mudança do padrão habitual ou piora progressiva em semanas; febre com rigidez de nuca; convulsão; alteração neurológica (fraqueza, fala, visão); primeira crise após os 50 anos; após trauma na cabeça	Dor persistente por cerca de 15 dias ou uso de analgésico em muitos dias do mês
Febre	Criança com menos de 2 meses (avaliação hospitalar); menor de 6 meses com 38 °C retal ou mais; acima de 6 meses com 40 °C ou mais; suspeita de dengue, chikungunya ou zika; exantema, falta de ar, convulsão, confusão, dor intensa, criança muito sonolenta ou que não aceita líquidos; gestante com febre persistente; puérpera; imunossuprimido	Febre por mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico
Dor de garganta	Dificuldade de engolir a própria saliva ou de respirar; placas com febre alta e gânglios dolorosos no pescoço, sem tosse ou coriza (sugere faringite estreptocócica, que pede avaliação para antibiótico); placas com disfagia	Sem melhora em poucos dias ou piora após melhora inicial
Tosse	Menor de 2 anos; maior de 75 anos; falta de ar, chiado ou dor no peito; escarro purulento ou com sangue; perda de peso; febre acima de 38,5 °C por 2 dias ou mais; tosse noturna recorrente em criança; doença cardíaca; gestante ou lactante	Tosse por 3 semanas ou mais; sem melhora após 7 dias de tratamento
Espirro e congestão nasal	Obstrução de um lado só (corpo estranho); febre acima de 38 °C por mais de 24 horas mesmo com tratamento; dor facial e secreção purulenta; uso contínuo de descongestionante tópico com sangramento ou lesão nasal	Sintomas por mais de 10 a 14 dias sem tratamento ou sem melhora após 7 dias de tratamento

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Diarreia	Sangue ou muco nas fezes; febre; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina); vômitos que impedem a hidratação oral; lactente, idoso frágil ou imunossuprimido	Diarreia aguda dura menos de 14 dias; acima disso é persistente e precisa de avaliação
Azia e dispepsia	Dificuldade ou dor para engolir; perda de peso; vômitos persistentes; sangue no vômito ou fezes escuras; anemia; idade acima de 50 anos com sintoma novo; dor no peito irradiada com suor e falta de ar (urgência); criança até 12 anos; doença renal	Sintomas por mais de 7 dias apesar do antiácido; azia noturna por mais de 3 meses
Constipação	Sangue nas fezes; perda de peso; mudança recente do hábito intestinal após os 50 anos; dor abdominal intensa, vômitos ou distensão (suspeita de obstrução); início após medicamento novo	Sem resposta às medidas de dieta, líquidos e laxante no prazo da bula
Dor lombar	Idade abaixo de 20 ou acima de 50 anos; dor que piora à noite; história de câncer; emagrecimento; febre; trauma importante; osteoporose em tratamento; imunossupressão; fraqueza nas pernas; alteração urinária ou intestinal; anestesia na região da sela	Dor refratária ao tratamento
Lesões de pele	Pinta que cresce, muda de cor ou sangra; vermelhidão quente que se espalha; bolhas extensas; lesões com febre; dor em faixa de um lado do corpo com bolhas (suspeita de herpes-zóster); inchaço de lábios ou falta de ar com urticária (urgência)	Sem melhora no prazo da bula do produto tópico
Sintomas urinários	Febre, calafrio, dor lombar ou no flanco (suspeita de pielonefrite); homem; gestante; criança; idoso; diabético ou imunossuprimido; sangue na urina; corrimento ou lesão genital; episódios repetidos	Qualquer suspeita de infecção urinária precisa de avaliação: a fenazopiridina só alivia o ardor
Olho vermelho	Dor ocular forte; baixa da visão; sensibilidade intensa à luz; pupila diferente ou fixa; dor ocular com vômitos; trauma, corpo estranho ou produto químico; secreção purulenta abundante; usuário de lente de contato com dor	Irritação simples que não melhora com lubrificante e afastamento do irritante

Fontes do quadro: CFF, guias de prática clínica (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021); Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II (cefaleia, diarreia, disúria, dor de garganta, dor lombar, dispepsia e olho vermelho). Os itens de constipação, lesões de pele, lente de contato e dificuldade para engolir saliva ou respirar seguem a prática clínica geral e devem ser confirmados no protocolo do serviço.

Azia frequente depois da IN nº 404/2025

O guia do CFF de 2020 lista "azia frequente (2 ou mais vezes por semana)" como motivo de encaminhamento. Em 2025, a IN nº 404/2025 incluiu o omeprazol 20 mg na LMIP justamente para o alívio de azia e queimação frequentes, que ocorrem em dois ou mais dias na semana. As duas regras convivem assim: azia frequente, sem nenhum dos sinais de alarme da tabela, pode receber um curso curto de omeprazol MIP no prazo da bula; azia que persiste ou volta logo após o curso, ou que vem com qualquer

sinal de alarme, continua sendo caso de encaminhamento. O uso prolongado de inibidor da bomba de prótons sem acompanhamento também é motivo de encaminhamento no guia do CFF.

Como encaminhar

- Explique ao paciente, sem alarmismo, por que o caso precisa de avaliação e para onde ir (unidade básica, pronto atendimento, especialista).
- Entregue por escrito um resumo: queixa, duração, sinais observados, medidas já usadas, medicamentos em uso, parâmetros aferidos e identificação do farmacêutico. Os guias do CFF chamam esse documento de redação do encaminhamento.
- Não ofereça MIP para "segurar" até a consulta quando isso puder mascarar o quadro.
- Em urgência, oriente a ligar para o SAMU (192) ou ligue junto com o paciente.
- Registre o atendimento e o encaminhamento.

NO BALCÃO

Uma pergunta final evita a maioria dos erros de triagem: "Tem mais alguma coisa diferente que o senhor notou?". Sintomas que o paciente acha sem importância, como fezes escuras junto com azia ou falta de ar junto com tosse, costumam aparecer só nesse momento.

CASO

Mãe pede "um remédio para febre" para o filho de 7 semanas, que está com 38,2 °C desde a manhã. Pelo guia de febre do CFF, criança com menos de 2 meses e febre deve sempre ser avaliada em hospital. O farmacêutico não indica antitérmico, explica a urgência, informa o endereço do pronto atendimento pediátrico mais próximo, orienta a não agasalhar demais o bebê no trajeto e registra o encaminhamento.

Populações especiais no balcão

Os critérios de enquadramento do MIP foram pensados para o adulto sem doenças relevantes. Em gestantes, lactantes, crianças, idosos e pessoas com doença crônica ou em uso de anticoagulante, o mesmo produto pode ter risco muito maior. A primeira tarefa é identificar essas pessoas na anamnese, porque elas raramente se apresentam assim.

Gestante

Pergunte sempre a mulheres em idade fértil se há possibilidade de gravidez. Na gestação, priorize medidas não farmacológicas e use medicamento só quando o benefício for claro, na menor dose e pelo menor tempo.

- **Analgésico e antitérmico**: o paracetamol segue como opção de escolha na gestação. Em setembro de 2025, após a declaração do governo dos Estados Unidos sobre uma suposta relação entre paracetamol na gravidez e autismo, a Anvisa informou não haver registros de notificação que relacionem o uso ao autismo, e a Febrasgo afirmou não haver evidência conclusiva de causa e efeito, reforçando o uso responsável e orientado.

- **Anti-inflamatórios não esteroides**: a FDA recomendou, em outubro de 2020, evitar AINE a partir de cerca de 20 semanas de gestação, pelo risco de lesão renal fetal com redução do líquido amniótico; após cerca de 30 semanas, o risco de fechamento precoce do canal arterial já constava das bulas. A recomendação não se aplica ao ácido acetilsalicílico em baixa dose prescrito pelo médico.
- **Encaminhar**: gestante com febre persistente (guia de febre do CFF), com tosse (guia de tosse do CFF), com azia que não melhora com medidas não farmacológicas (guia de azia do CFF) e com sintomas nasais persistentes após lavagem nasal (guia de congestão do CFF).

Lactante

Na amamentação, avalie dois riscos: o efeito no lactente (passagem para o leite) e o efeito na produção de leite. Prefira fármacos com longa experiência de uso e meia-vida curta, use a menor dose eficaz e evite associações em dose fixa, que somam fármacos sem necessidade. Anti-histamínicos sedativos podem deixar o bebê sonolento. O guia de tosse do CFF orienta encaminhar lactantes com tosse, porque os dados de segurança de antitussígenos e expectorantes na amamentação são escassos. Para casos específicos, consulte bases de dados sobre medicamentos e lactação.

Criança

Na criança, a dose é calculada pelo peso, e o erro mais frequente no balcão está na conversão de miligramas para mililitros ou gotas.

- Pergunte sempre o peso atual. Idade é aproximação ruim.
- Para o paracetamol, a dose usual é de 10 a 15 mg/kg por dose (Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II), respeitando o intervalo e o número máximo de doses por dia da bula do produto.
- Verifique a apresentação. O mesmo fármaco existe em concentrações muito diferentes: dipirona em gotas 500 mg/mL e em solução oral 50 mg/mL (dez vezes menos concentrada); ibuprofeno em suspensão de 100 mg/mL e de 200 mg/mL, sendo esta última indicada na LMIP apenas para adultos.
- Gota não é unidade padronizada: o número de gotas por mililitro depende do produto e do conta-gotas. Use sempre o dosador da embalagem e confira na bula a equivalência.
- Escreva na caixa a dose em mL ou em gotas, o intervalo e a dose máxima diária.

CASO

Criança de 12 kg, com febre de 38,5 °C desde ontem, ativa, aceitando líquidos, sem outros sinais de alerta. Paracetamol 10 a 15 mg/kg por dose resulta em 120 a 180 mg. Com a solução de 200 mg/mL, isso corresponde a 0,6 a 0,9 mL por dose. O farmacêutico converte para gotas usando a equivalência da bula do produto escolhido, mostra o conta-gotas da embalagem, escreve a dose e o intervalo na caixa e orienta voltar ou procurar atendimento se a febre passar de 3 dias ou surgir qualquer sinal de alerta.

- Pelos guias do CFF, encaminhe menores de 2 anos com tosse, crianças até 12 anos com azia e menores de 2 meses com febre.
- A bula do ácido acetilsalicílico adverte contra seu uso em crianças e adolescentes com doença viral, como gripe e catapora, pelo risco de síndrome de Reye.

- Associações antigripais com descongestionante e anti-histamínico têm restrição de idade na bula; confira antes de indicar.

> **ATENÇÃO**
>
> Confundir "gotas" com "mL" multiplica a dose. "Dar 20" em um frasco de gotas e "dar 20" em um frasco de solução em mL são coisas muito diferentes. Toda orientação pediátrica deve informar a unidade por extenso e o dosador correto.

Idoso

No idoso, a função renal costuma estar reduzida, o efeito sedativo é maior e o risco de queda, sangramento e confusão aumenta. Os Critérios de Beers, da Sociedade Americana de Geriatria (atualização de 2023), listam medicamentos potencialmente inapropriados para pessoas de 65 anos ou mais. Vários estão entre os MIP ou nas associações vendidas sem receita.

Item dos Critérios de Beers 2023	Recomendação	Onde aparece no balcão
Anti-histamínicos de primeira geração	Evitar (altamente anticolinérgicos)	Dexclorfeniramina, clorfeniramina e prometazina, inclusive em antigripais
AINE oral não seletivo	Evitar uso crônico; evitar até o uso curto regular junto com corticoide, anticoagulante ou antiagregante	Ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico em dose analgésica
AINE na insuficiência cardíaca	Evitar na insuficiência cardíaca sintomática	Qualquer AINE oral
AINE na doença renal	Evitar com função renal abaixo de 30 mL/min	Qualquer AINE oral
Inibidor da bomba de prótons	Evitar uso regular por mais de 8 semanas sem indicação que justifique	Omeprazol 20 mg MIP usado por conta própria por meses
Óleo mineral por via oral	Evitar (risco de aspiração)	Laxantes com óleo mineral
Antiespasmódicos anticolinérgicos	Evitar (a lista cita escopolamina e atropina)	Produtos com escopolamina ou beladona
Ácido acetilsalicílico para prevenção primária	Não iniciar; considerar retirada	Idoso que decide "tomar AAS para o coração" por conta própria

Os Critérios de Beers expressam o limite renal em depuração de creatinina. No Brasil, o resultado de exame do paciente costuma vir como taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI 2021; use esse valor como referência e encaminhe quando houver dúvida. O guia de tosse do CFF recomenda encaminhar pessoas com mais de 75 anos com tosse.

Doenças crônicas e anticoagulação

Condição	Cuidado com MIP	Alternativa ou conduta
Hipertensão	Descongestionantes sistêmicos (fenilefrina e similares em antigripais) elevam a pressão; AINE retém sódio, eleva a pressão e reduz o efeito de anti-hipertensivos; comprimidos efervescentes trazem sódio	Soro fisiológico nasal, analgésico sem AINE, aferir a pressão; o guia de febre do CFF manda encaminhar alteração de pressão em uso de anti-hipertensivo
Diabetes	Xaropes e pastilhas com açúcar; sintomas atípicos de infecção; feridas nos pés	Preferir versões sem açúcar; lesão em pé de diabético é sempre encaminhamento
Doença renal crônica	AINE pode precipitar lesão renal aguda; antiácidos com magnésio e alumínio acumulam	Evitar AINE; o guia de azia do CFF manda encaminhar paciente com doença renal que precise de antiácido
Doença hepática	Paracetamol em dose alta ou com álcool aumenta o risco de lesão hepática	Dose e duração definidas com o médico que acompanha o paciente
Anticoagulante ou antiagregante	AINE e ácido acetilsalicílico aumentam o risco de sangramento; uso regular de paracetamol em dose alta por vários dias pode elevar o RNI de quem usa varfarina; omeprazol reduz a ativação do clopidogrel	Analgésico sem AINE em dose habitual e por pouco tempo; avisar o médico se o uso se prolongar; encaminhar se houver fezes escuras, urina com sangue, vômito com sangue ou sangramento nasal

NO BALCÃO

Peça para ver a caixa ou a receita dos medicamentos de uso contínuo. Muitos pacientes não se lembram do nome, mas sabem que tomam "um remédio para afinar o sangue" ou "um para pressão". Esse detalhe muda a escolha entre um AINE e um analgésico simples.

CASO

Homem de 72 anos em uso de varfarina pede ibuprofeno para dor no joelho. O farmacêutico explica o risco de sangramento da associação, indica paracetamol em dose habitual de adulto por poucos dias, orienta calor local e repouso relativo, avisa que o uso regular por vários dias deve ser comunicado ao médico que controla o RNI e lista os sinais de sangramento que exigem atendimento imediato.

Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013

A Resolução CFF nº 586, de 29 de agosto de 2013, "regula a prescrição farmacêutica". Tem a mesma data da Resolução CFF nº 585/2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. As duas formam um par: a 585 diz o que o farmacêutico faz no cuidado ao paciente, e a 586 detalha um desses atos, a prescrição. É conteúdo obrigatório de concursos, residências e provas de conselho, e precisa ser estudada junto com a sua situação jurídica atual.

Preâmbulo e considerandos

O preâmbulo apresenta a prescrição como prática multiprofissional, adotada em vários sistemas de saúde para ampliar acesso e resolutividade, com modos específicos para cada profissão e limites definidos pelas responsabilidades de cada uma. Os considerandos citam, entre outros:

- a Lei nº 3.820/1960 (criação dos conselhos de farmácia, art. 6º, alíneas "g" e "m") e o Decreto nº 85.878/1981 (atribuições profissionais do farmacêutico);
- o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Declaração de Alma-Ata (1978);
- a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução CNS nº 338/2004) e o Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria MS/GM nº 529/2013);
- resoluções do CFF sobre boas práticas, indicação de plantas medicinais e fitoterápicos isentos (nº 546/2011), registro de informações clínicas (nº 555/2011) e atribuições clínicas (nº 585/2013);
- normas da Anvisa então vigentes sobre categoria de venda (RDC nº 138/2003), medicamentos dinamizados, manipulação e boas práticas em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009).

Desde então, a norma da Anvisa sobre categoria de venda mudou duas vezes (RDC nº 98/2016 e, hoje, RDC nº 882/2024). A remissão do art. 5º a "categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal" acompanha essas mudanças.

Definição e natureza do ato

O QUE DIZ A NORMA

"Para os propósitos desta resolução, define-se a prescrição farmacêutica como ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde." (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º)

- É prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no CRF de sua jurisdição (art. 2º).
- É atribuição clínica, realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores evidências, em princípios éticos e conforme as políticas de saúde vigentes (art. 3º, parágrafo único).
- Pode ocorrer em estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e níveis de atenção diversos, desde que respeitadas a confidencialidade e a privacidade (art. 4º).

Repare que "prescrever" na resolução é mais amplo que escolher um medicamento. Inclui terapia não farmacológica (dieta, lavagem nasal, compressa, repouso) e outras intervenções, como o encaminhamento.

O que pode ser prescrito

A resolução separa dois grupos, com exigências muito diferentes.

Grupo	Base	Condições
Medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica	Art. 5º	Inclui industrializados e preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias aprovadas pelo órgão sanitário federal. Exige conhecimento de boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação, farmacologia clínica e terapêutica (§1º). Para dinamizados e práticas integrativas, conhecimento específico (§2º).
Medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica	Art. 6º	Somente com diagnóstico prévio e apenas quando previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para uso em instituições de saúde, ou quando houver acordo de colaboração formalizado com outros prescritores ou instituições. Exige título de especialista ou especialista profissional na área clínica reconhecido pelo CRF (§1º). Para dinamizados, título em homeopatia ou antroposofia (§2º).

O QUE DIZ A NORMA

"O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde." (art. 6º)

O glossário define acordo de colaboração como a "parceria formal entre o farmacêutico e o prescritor ou a instituição, com explícito acordo entre quem está delegando (prescritor ou instituição) e quem está recebendo a autorização (farmacêutico) para prescrever". No balcão de uma drogaria, sem protocolo institucional nem acordo formal, a resolução não autoriza prescrever tarjado em hipótese alguma.

ATENÇÃO

"É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração", caso em que a modificação, com justificativa, deve ser comunicada ao outro prescritor (art. 6º, §3º). Trocar dose, fármaco ou duração de uma receita médica por conta própria é infração.

Etapas do processo de prescrição

O art. 7º descreve o processo em sete etapas. Elas coincidem com o atendimento de queixas descrito nos guias do CFF.

1. Identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde.
2. Definição do objetivo terapêutico.
3. Seleção da terapia ou das intervenções, com base em segurança, eficácia, custo e conveniência, dentro do plano de cuidado.
4. Redação da prescrição.
5. Orientação ao paciente.

6. Avaliação dos resultados.
7. Documentação do processo de prescrição.

O art. 8º acrescenta medidas de segurança do paciente: basear-se nas melhores evidências; decidir de forma compartilhada e centrada no paciente; considerar outras condições clínicas, outros medicamentos, hábitos e contexto; atentar para os aspectos legais e éticos dos documentos entregues; comunicar as decisões de modo que paciente, responsável ou cuidador compreendam por completo; e garantir que os resultados sejam acompanhados e avaliados.

Documento de prescrição

O art. 9º exige prescrição "redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras", com os componentes mínimos:

1. identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado;
2. nome completo e contato do paciente;
3. descrição da terapia farmacológica, quando houver: nome do medicamento ou formulação, concentração ou dinamização, forma farmacêutica e via; dose, frequência e duração do tratamento; instruções adicionais, quando necessário;
4. descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção, quando houver;
5. nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no CRF;
6. local e data.

No SUS, a prescrição deve usar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na falta dela, a Denominação Comum Internacional (art. 10). No setor privado, preferencialmente a DCB (art. 11). É vedado prescrever sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e assinar receituário em branco (art. 12).

Sigilo, autonomia, propaganda e registro

- Sigilo dos dados obtidos na prescrição, vedado o uso para fim que não seja de interesse sanitário ou de fiscalização profissional (art. 13).
- Autonomia profissional e científica em relação a empresas e pessoas com interesse comercial na prescrição (art. 14).
- Proibição de usar a prescrição como meio de propaganda ou publicidade de qualquer natureza (art. 15). Prescrição com logotipo de laboratório ou cupom de desconto de marca fere esse artigo.
- Registro de todo o processo de prescrição na forma da lei (art. 16).

Relação com outras normas

Norma	Ponto de contato com a Resolução nº 586/2013
Resolução CFF nº 585/2013	Lista entre as atribuições clínicas "prescrever, conforme legislação específica" (art. 7º, XXVI), o manejo de problemas de saúde autolimitados (XXV), a consulta farmacêutica em consultório (VII), a anamnese (VIII) e o plano de cuidado (XVII).
Lei nº 13.021/2014	Define a farmácia como unidade de prestação de serviços de saúde (art. 3º) e impõe ao farmacêutico orientação, acompanhamento farmacoterapêutico e farmacovigilância (art. 13). A lei não trata expressamente de prescrição farmacêutica.
RDC nº 44/2009	A Declaração de Serviço Farmacêutico registra a "indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia" (art. 81, §2º, I, b) e não pode ser usada para indicar medicamento que exige prescrição nem para propaganda (art. 81, §3º).
Resolução CFF nº 724/2022 (Código de Ética)	Entre os direitos do farmacêutico, prescrever medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica, "desde que devidamente documentada" (art. 12, VII), e prescrever conforme protocolos institucionais ou acordos de colaboração (art. 12, VIII).

Situação jurídica em outubro de 2026

A prescrição farmacêutica é objeto de disputa judicial entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o CFF desde 2013. O estudante precisa conhecer os fatos, porque eles mudam o que se pode fazer com segurança jurídica.

Norma	O que dispõe	Situação conferida
Resolução CFF nº 586/2013	Prescrição farmacêutica (MIP e, com condições, tarjados)	Sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF, na ação civil pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 movida pelo CFM, julgou o pedido procedente, declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução, proibiu sua aplicação em todo o território nacional e determinou sua suspensão imediata. A sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório e o CFF recorreu ao TRF da 1ª Região.
Resolução CFF nº 5/2025	Nova regulamentação da prescrição, incluindo tarjados por farmacêutico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em farmácia clínica (RQE criado pela Resolução CFF nº 4/2025)	Datada de 20/02/2025 e publicada em 17/03/2025; suspensa por decisão liminar da 17ª Vara Federal Cível do DF em 31/03/2025, em ação do CFM.
Resolução CFF nº 12/2024	Prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêutico, conforme protocolo do CFF	Suspensa pela 13ª Turma do TRF da 1ª Região em agravo do CFM; em 2026 a sentença de primeira instância declarou sua nulidade e o CFF anunciou recurso (notícia do CFF de 20/05/2026).

O fundamento das decisões contrárias é que conselho profissional não pode ampliar, por resolução, atribuições que dependem de lei federal, e que diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica são atos privativos do médico pela Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico). O CFF sustenta o contrário e recorre.

Não foi localizada, até outubro de 2026, decisão de segundo grau restabelecendo a Resolução nº 586/2013.

PONTO-CHAVE

O conteúdo da Resolução nº 586/2013 continua sendo cobrado em provas e organiza a boa prática de documentação. Na rotina, enquanto a disputa não se resolve, o caminho com base sanitária vigente para o MIP é a indicação farmacêutica com orientação e registro na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Prescrição de medicamento tarjado por farmacêutico de drogaria, fora de protocolo institucional, não tem respaldo. Acompanhe as orientações do seu CRF.

NO BALCÃO

Se o cliente pedir "uma receita do farmacêutico" para apresentar em outro lugar ou para comprar um tarjado, explique que o farmacêutico não emite receita de medicamento tarjado e que o documento que você entrega registra a orientação e o MIP indicado. Nunca assine documento em branco nem inclua marca comercial como forma de propaganda.

Documentação e ética no atendimento

Documentar o atendimento protege o paciente, porque permite continuidade e comunicação com outros profissionais, e protege o farmacêutico, porque registra o que foi avaliado, decidido e orientado. No balcão, boa parte dos conflitos éticos nasce da pressão comercial por volume de vendas.

Declaração de Serviço Farmacêutico

Após a prestação de serviço farmacêutico, o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Ela é emitida em duas vias: a primeira vai para o usuário e a segunda fica arquivada no estabelecimento (art. 81, §4º).

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Cabeçalho	Papel com identificação do estabelecimento: nome, endereço, telefone e CNPJ (§1º)
Usuário	Identificação do usuário ou do responsável legal (§1º)
Prescrição apresentada	Medicamento prescrito e dados do prescritor (nome e inscrição no conselho), quando houver (§2º, I, a)
Indicação de MIP	Medicamento isento indicado e posologia, quando houver (§2º, I, b)
Parâmetros e exames	Valores aferidos ou resultados com os valores de referência, quando houver, e a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (§2º, I, c e d)
Medicamento administrado	Nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração e forma, via, lote e registro na Anvisa, quando houver (§2º, I, e)

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Orientação e plano	Orientação farmacêutica e plano de intervenção, quando houver (§2º, I, f e g)
Responsável	Data, assinatura e carimbo com inscrição no CRF do farmacêutico (§2º, I, h)

O QUE DIZ A NORMA

"É proibido utilizar a Declaração de Serviço Farmacêutico com finalidade de propaganda ou publicidade ou para indicar o uso de medicamentos para os quais é exigida prescrição médica ou de outro profissional legalmente habilitado." (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º)

A Declaração e o documento de prescrição da Resolução nº 586/2013 têm finalidades parecidas, mas bases diferentes. A Declaração é exigência sanitária da Anvisa, vigente, e registra o serviço prestado. O documento de prescrição é norma profissional do CFF, hoje discutida judicialmente, e tem o formato de uma receita. Quando se indica um MIP, a Declaração já contém os elementos essenciais: produto, posologia, orientação e identificação do farmacêutico.

Registro interno e privacidade

Além da via entregue, a farmácia mantém o registro do atendimento: dados de contato do usuário, orientações e intervenções, resultados e identificação do profissional, com consentimento expresso do usuário (RDC nº 44/2009, art. 64). Os dados obtidos nos serviços farmacêuticos recebem tratamento sigiloso e não podem ser usados para outra finalidade (art. 82).

Dado referente à saúde é dado pessoal sensível na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II). Na prática, isso significa:

- atender queixas íntimas (sintomas urinários, corrimento, contracepção de emergência, hemorroidas) em local reservado, e não no meio da fila;
- não comentar o caso com outros clientes ou colegas sem necessidade assistencial;
- não usar o registro clínico para oferta comercial;
- guardar fichas e arquivos com acesso restrito.

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 724/2022) inclui entre os deveres de todos os inscritos guardar sigilo de fatos e informações conhecidos no exercício da profissão, salvo quando a lei exige comunicação (art. 15, VI), e proíbe fornecer a terceiros dados que identifiquem o paciente, inclusive os de receitas e registros, em desacordo com a LGPD (art. 18, XLIII).

Recusa de venda e de dispensação

O farmacêutico tem o direito de "decidir, justificadamente, sobre a dispensação ou não de qualquer prescrição", em favor da segurança e da eficácia da terapêutica (Resolução CFF nº 724/2022, art. 12, XIV), e de "negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica" (art. 12, IV). O raciocínio vale para o MIP.

- Recusa justificada: grande quantidade de paracetamol com relato de tristeza intensa ou ideação suicida; pedido de MIP para criança de idade incompatível com a bula; pedido de antigripal com descongestionante por hipertenso com pressão muito elevada aferida na hora.
- Como recusar: explicar o motivo técnico em linguagem simples, oferecer alternativa segura ou encaminhamento, registrar o atendimento. Recusa sem explicação gera conflito e não protege ninguém.
- Em situação de risco à vida, a recusa vem acompanhada de encaminhamento ativo: acionar o SAMU (192) ou serviço de saúde mental, sem deixar a pessoa sair sozinha se houver risco imediato.

Condutas proibidas ou antiéticas

Conduta	Por que é proibida
Indicar ou vender sem receita medicamento tarjado	Venda sem a prescrição exigida é infração sanitária. A RDC nº 44/2009 veda indicar ou alterar tarjado mesmo diante de parâmetro alterado (art. 69, §4º) e veda usar a Declaração para isso (art. 81, §3º). A Resolução nº 586/2013 só admitia tarjado em protocolo institucional ou acordo de colaboração (art. 6º).
"Empurroterapia": indicar o produto que dá comissão ou bonificação	O Código de Ética proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia diante de interesses comerciais (art. 14).
Venda casada ou "leve três" de medicamento	Estimula uso indiscriminado (RDC nº 96/2008, art. 8º, I) e programas de fidelidade não podem usar medicamento como objeto de pontuação ou prêmio (art. 10).
Substituir medicamento sem regra de intercambialidade	A troca só é permitida nos limites legais: medicamento de referência pelo genérico correspondente (Lei nº 9.787/1999) ou pelo similar declarado intercambiável pela Anvisa. O Código de Ética garante o direito de realizar a intercambialidade "respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato" (art. 12, IX).
Dispensar para uso diferente da indicação registrada	Proibido, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento com o prescritor formalizado por escrito (Código de Ética, art. 17, IX).
Modificar a receita de outro prescritor	Vedado, salvo em acordo de colaboração (Resolução nº 586/2013, art. 6º, §3º).
Deixar o balconista indicar medicamento	Indicação é avaliação clínica do farmacêutico; delegar ato privativo é proibido (Código de Ética, art. 17, VIII).
Usar documento de atendimento como propaganda	Vedado na Declaração (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º) e na prescrição (Resolução nº 586/2013, art. 15).

Farmacovigilância

Reação adversa, intoxicação ou suspeita de falha relatada no balcão é informação de interesse sanitário. O farmacêutico deve notificar efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência às autoridades sanitárias, aos profissionais e ao fabricante (Lei nº 13.021/2014, art. 13, I) e contribuir para a

farmacovigilância notificando eventos adversos e queixas técnicas (RDC nº 44/2009, art. 67). A notificação à Anvisa é feita pelo sistema VigiMed.

NO BALCÃO

Quando o representante comercial oferecer premiação por venda de uma marca de MIP, lembre que a escolha do produto no atendimento é técnica. A marca pode estar no estoque, mas a indicação segue os critérios clínicos do atendimento.

CASO

Jovem de 19 anos pede quatro caixas de paracetamol 750 mg e, na conversa, diz que "não aguenta mais nada". O farmacêutico recusa a venda daquela quantidade, conversa em local reservado, pergunta diretamente sobre intenção de se machucar e, diante da resposta afirmativa, aciona o serviço de urgência e permanece com a jovem até a chegada da equipe. Registra o atendimento sem expor o caso a outros clientes.

Analgésicos e antitérmicos

Dor leve a moderada e febre respondem pela maior parte dos pedidos de balcão. Três fármacos resolvem quase todos esses casos: **paracetamol**, dipirona e ácido acetilsalicílico (AAS). Os três constam da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), Anexo I da IN 285/2024, republicado na íntegra pela IN 404/2025. A lista fixa a concentração máxima do insumo em cada forma farmacêutica e não estabelece dose diária: um produto é MIP quando tem o mesmo insumo, a mesma forma farmacêutica e a mesma indicação da linha da lista, com concentração igual ou menor (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).

O paracetamol aparece também na Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN), estabelecida pela IN 106/2021 e atualizada pela IN 430/2026. Produtos notificados são, por definição, de venda isenta de prescrição (RDC 576/2021, definições), e a LMN já traz o texto de posologia e de advertência que o fabricante deve usar.

Enquadramento

Fármaco	Apresentações isentas (concentração máxima)	Observação de balcão
Paracetamol	LMIP: comprimido revestido 750 mg; efervescente 500 mg; mastigável 160 mg; liberação prolongada 650 mg; pó 100 mg/g. LMN: comprimido 500 e 750 mg; solução oral 200 mg/mL; suspensão 32, 100 e 140 mg/mL	Associações com cafeína, fenilefrina, anti-histamínicos, orfenadrina e carisoprodol também constam da LMIP
Dipirona	Comprimido e efervescente até 1000 mg; solução oral até 500 mg/mL; supositório 300 mg	Forma injetável nunca é MIP (RDC 882/2024, art. 5º)
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg; comprimido de liberação prolongada 500 mg; associações com vitamina C, cafeína e paracetamol	A linha da LMIP cobre febre e dor; o uso antiagregante em dose baixa é decisão do médico

Paracetamol

Analgésico e antipirético de ação predominantemente central, com efeito anti-inflamatório periférico desprezível. Não irrita a mucosa gástrica nem interfere na agregação plaquetária, o que o torna a primeira opção em dengue suspeita, em pessoas com úlcera ou em uso de anticoagulante (com a ressalva da varfarina, abaixo).

Item	Conduta
Indicação de balcão	Febre; dor leve a moderada (cefaleia, dor de dente, dor muscular, cólica menstrual, dor de garganta)
Adulto e maior de 12 anos	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 horas; no máximo 1000 mg por dose e 4000 mg em 24 horas (LMN, IN 106/2021)
Criança	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas, no máximo 5 administrações em 24 horas (cerca de 50 a 75 mg/kg/dia). Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: avaliação médica antes do uso (LMN)
Gotas 200 mg/mL	Na bula do Tylenol® gotas: 1 gota/kg, até 35 gotas por dose em menores de 12 anos; adulto 40 a 70 gotas por dose, até 280 gotas por dia
Contraindicações	Alergia ao paracetamol; doença hepática grave; cautela em etilista e em desnutrido
Interações	Varfarina (uso regular pode elevar o INR: a bula pede consulta médica); outros produtos com paracetamol (antigripais); álcool
Encaminhar	Ingestão acima da dose máxima, mesmo sem sintomas; icterícia, urina escura ou dor no lado direito do abdome

ATENÇÃO

O texto obrigatório da LMN avisa que adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda com mais de 4 g em 24 horas, com uso simultâneo de outros produtos contendo paracetamol ou com 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. O erro mais comum é a duplicidade: o cliente toma paracetamol de 750 mg e um antigripal que também contém paracetamol. Leia o rótulo de tudo o que ele já usa.

Intoxicação por paracetamol tem antídoto (acetilcisteína) e janela de tempo. Quem ingeriu dose excessiva deve ir ao pronto-socorro imediatamente, ainda que esteja assintomático.

O número de gotas por mililitro depende do gotejador. O manual de dengue do Ministério da Saúde considera 20 gotas por mL para o paracetamol 200 mg/mL, enquanto na bula do Tylenol® 70 gotas correspondem a 1000 mg (cerca de 14 gotas por mL). Por isso a orientação em gotas vale para o produto entregue: confira a bula daquele frasco e nunca transfira a regra de uma marca para outra. A IN 430/2026 ajustou a posologia pediátrica e incluiu advertência sobre tempo de uso no texto da LMN, de modo que a bula do lote em mãos é a referência final.

Dipirona

Pró-fármaco cujos metabólitos inibem a síntese de prostaglandinas, com efeito analgésico, antipirético e leve ação espasmolítica. É o antitérmico mais vendido do país e, ao lado do paracetamol, o recomendado pelo Ministério da Saúde para dor e febre na dengue.

Item	Conduta (bula da Novalgina®)
Adulto e maior de 15 anos	500 a 1000 mg até 4 vezes ao dia. Gotas 500 mg/mL (1 mL = 20 gotas): 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia. Máximo 4 g/dia
5 a 8 kg (3 a 11 meses)	2 a 5 gotas por dose; máximo 20 gotas/dia
9 a 15 kg (1 a 3 anos)	3 a 10 gotas por dose; máximo 40 gotas/dia
16 a 23 kg (4 a 6 anos)	5 a 15 gotas por dose; máximo 60 gotas/dia
24 a 30 kg (7 a 9 anos)	8 a 20 gotas por dose; máximo 80 gotas/dia
31 a 45 kg (10 a 12 anos)	10 a 30 gotas por dose; máximo 120 gotas/dia
46 a 53 kg (13 a 14 anos)	15 a 35 gotas por dose; máximo 140 gotas/dia

Contraindicações listadas em bula: alergia a pirazolonas, agranulocitose prévia com essas substâncias, função de medula óssea prejudicada, broncoespasmo ou reação anafilactoide após analgésicos, porfiria hepática aguda intermitente, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, menores de 3 meses ou com menos de 5 kg. A bula da Novalgina® inclui gravidez e amamentação entre as contraindicações.

Interações relevantes: metotrexato (a associação deve ser evitada, aumenta a toxicidade hematológica), ciclosporina (níveis reduzidos), AAS em dose baixa para cardioproteção (a dipirona reduz o efeito antiplaquetário) e bupropiona (concentração reduzida). Em insuficiência renal ou hepática e em idosos, evitar doses altas.

ATENÇÃO

A **agranulocitose** por dipirona é rara e imprevisível, não depende da dose e pode ocorrer em qualquer momento do uso. Oriente o cliente: febre que volta ou persiste, calafrios, dor de garganta e feridas na boca durante o tratamento exigem suspender o medicamento e procurar atendimento no mesmo dia. Hipotensão e reação alérgica grave também são descritas, sobretudo em doses altas.

Ácido acetilsalicílico

Inibe de forma irreversível as ciclo-oxigenases 1 e 2, com efeito analgésico, antitérmico, anti-inflamatório e antiplaquetário que dura a vida da plaqueta. No balcão de hoje, perdeu espaço como antitérmico

justamente por esse efeito sobre a coagulação.

Item	Conduta (bula da Aspirina® 500 mg)
Adulto	500 a 1000 mg; repetir a cada 4 a 8 horas se necessário; no máximo 8 comprimidos (4 g) por dia; após as refeições
A partir de 12 anos	500 mg a cada 4 a 8 horas; no máximo 3 comprimidos por dia
Duração	Não usar por mais de 3 a 5 dias sem consulta
Contraindicações	Alergia a salicilatos; asma induzida por AINE; úlcera ativa; tendência a sangramento; dengue suspeita
Interações	Anticoagulantes e antiplaquetários; outros AINE; metotrexato; corticoides (sangramento digestivo)

ATENÇÃO

Síndrome de Reye: doença rara e grave, com lesão hepática e encefalopatia, associada ao AAS em crianças com infecção viral. A bula determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta médica. No balcão, a regra prática é simples: antitérmico para criança ou adolescente é paracetamol ou dipirona.

Associações analgésicas

A LMIP inclui várias associações. A cafeína (30 a 65 mg por comprimido) potencializa o analgésico e pode causar insônia, palpitação e piora da gastrite. A orfenadrina (relaxante muscular com ação anticolinérgica) pede cautela em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática e idosos. O carisoprodol causa sonolência. O isometepteno é vasoconstritor e não deve ser usado por hipertenso. Antes de dispensar uma associação, confirme se o cliente precisa de cada componente.

Dengue suspeita

Na época de transmissão, toda febre aguda com dor no corpo, dor atrás dos olhos, cefaleia ou manchas na pele deve ser tratada como dengue até prova em contrário. O guia *Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança* (Ministério da Saúde, 6ª edição, 2024) orienta prescrever paracetamol e/ou dipirona e não utilizar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides nem corticoides. AAS e AINE aumentam o risco de sangramento, inclusive digestivo, em pessoa que pode estar com plaquetas baixas.

Fármaco	Adulto	Criança
Dipirona	20 gotas ou 1 comprimido (500 mg) até de 6/6 horas	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas, respeitando a dose máxima por peso e idade

Fármaco	Adulto	Criança
Paracetamol	40 gotas ou 1 comprimido (500 mg) de 4/4 horas, ou 60 gotas ou 2 comprimidos até de 6/6 horas; não exceder 4 g/24 h	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas; doses maiores são hepatotóxicas

Fonte das doses: Apêndice H do guia do Ministério da Saúde (2024). O mesmo guia lista os **sinais de alarme**: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotimia, aumento do fígado, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Qualquer um deles indica atendimento médico imediato. Mesmo sem sinal de alarme, a pessoa com suspeita de dengue deve ser encaminhada para avaliação e notificação, com orientação de hidratação oral até lá.

PONTO-CHAVE

Em dengue suspeita: paracetamol ou dipirona, hidratação e encaminhamento. Nada de AAS, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida ou corticoide. Cliente cardiopata em uso contínuo de AAS não deve suspender por conta própria: encaminhe para avaliação médica no mesmo dia.

Alternância de antitérmicos

Alternar paracetamol, dipirona e ibuprofeno em horários intercalados é hábito comum de pais. O documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre febre aguda (2025) trata o uso intercalado como mito a ser combatido, por favorecer polimedicação e intoxicação. Estudo publicado no Jornal de Pediatria (2013) encontrou evidência escassa de benefício e mostrou que cerca de 70% das doses usadas pelas famílias estavam abaixo da dose mínima recomendada. A conduta correta é escolher um antitérmico, calcular a dose pelo peso e respeitar o intervalo. O antitérmico serve para o conforto da criança, e a temperatura não precisa voltar ao normal a cada dose.

NO BALCÃO

Pergunte idade e peso (para criança, sempre o peso), temperatura medida e há quanto tempo, outros sintomas (manchas, vômitos, dor abdominal, sangramento), doenças de fígado, rim, estômago ou asma, gestação ou amamentação, uso de anticoagulante e de outros remédios para gripe ou dor, e consumo de álcool.

Encaminhe: febre em menor de 3 meses; febre por mais de 72 horas; febre com manchas, rigidez de nuca, sonolência excessiva ou dificuldade para respirar; cefaleia súbita e intensa ou diferente das habituais; dor que exige dose máxima por vários dias; qualquer sinal de alarme de dengue.

CASO

Mãe pede algo para a febre do filho de 2 anos e 12 kg, com 38,6 °C desde ontem, em bairro com casos de dengue. Sem manchas, vômitos ou sonolência. Conduta: paracetamol 200 mg/mL, 1 gota/kg (12 gotas no frasco do Tylenol®, conferindo o gotejador do produto entregue), a cada 6 horas se febre ou dor, sem alternar com outro antitérmico; oferecer líquidos; nada de AAS ou ibuprofeno; levar à unidade de saúde para avaliação ainda hoje e voltar com urgência se surgir dor abdominal, vômitos repetidos, sangramento ou sonolência.

Anti-inflamatórios isentos de prescrição

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINE) inibem as ciclo-oxigenases e reduzem a síntese de prostaglandinas. Têm efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, mas pagam o preço em três órgãos: estômago, rim e sistema cardiovascular. Por isso a LMIP libera poucos AINE orais, em concentrações limitadas, e um número maior de formas tópicas.

Anti-inflamatórios na LMIP

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Ibuprofeno	Cápsula mole ou comprimido 400 mg; comprimido revestido 400 mg; liberação prolongada 600 mg; suspensão oral 100 e 200 mg/mL	Febre; dor leve a moderada
Ibuprofeno arginina	Comprimido revestido ou granulado 770 mg	Febre; dor leve a moderada; traumatismos
Ibuprofeno + paracetamol	Comprimido revestido 200 + 500 mg	Febre; dor leve a moderada, cefaleia, cólica abdominal
Naproxeno	Comprimido 500 mg	Dor aguda inflamatória, dor e febre, dor muscular e articular, dor pós-trauma
Naproxeno sódico	Comprimido revestido 550 mg	Mesma indicação do naproxeno
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	Inflamação da garganta
Diclofenaco dietilamônio	Gel 23,2 mg/g; solução dermatológica 11,6 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Diclofenaco sódico	Gel 10 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Aceclofenaco	Creme 15 mg/g	Dor musculoesquelética
Nimesulida	Gel 20 mg/g	Dor musculoesquelética
Loxoprofeno sódico	Adesivo transdérmico 100 mg	Dor musculoesquelética

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Salicilato de metila (associações)	Pomadas, géis, soluções e adesivos com cânfora e mentol	Dor muscular e articular

ATENÇÃO

Não constam da LMIP vigente: **nimesulida oral**, diclofenaco oral (sódico, potássico ou resinato), cetoprofeno, meloxicam, piroxicam, tenoxicam, etoricoxibe e celecoxibe. São medicamentos de venda sob prescrição. A nimesulida é MIP apenas em gel. Vender nimesulida comprimido sem receita, mesmo a pedido insistente, é dispensação irregular.

Ibuprofeno

Derivado do ácido propiônico, é o AINE oral de melhor perfil de segurança gastrintestinal em dose baixa. A dose de automedicação é menor que a dose anti-inflamatória que o médico prescreve.

Item	Conduta
Adulto (produto MIP, bula do Advil® 400 mg)	400 mg; repetir com intervalo mínimo de 4 a 6 horas; máximo 1200 mg em 24 horas; durante ou após as refeições
Doses acima de 1200 mg/dia	Somente com prescrição (bulas de ibuprofeno de venda sob prescrição admitem até 3200 mg/dia)
Criança a partir de 6 meses	5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas, no máximo 4 vezes ao dia; acima de 30 kg, até 200 mg por dose e 800 mg por dia (bula do Alivium® gotas)
Gotas 100 mg/mL	1 gota/kg por dose (bula do Alivium®)
Gotas 200 mg/mL	1 gota a cada 2 kg por dose (bula do Alivium®)
Contraindicações	Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo atual ou prévio; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; dengue suspeita

Naproxeno

AINE de meia-vida longa, útil em cólica menstrual e dor musculoesquelética. Na bula do Flanax® (naproxeno sódico): comprimido de 275 mg, 1 comprimido 1 a 2 vezes ao dia; comprimido de 550 mg, 1 comprimido 1 vez ao dia. A dose de 550 mg em 24 horas não deve ser excedida sem prescrição, o uso não deve passar de 10 dias consecutivos e o produto não é indicado para menores de 12 anos. Idosos e pessoas com doença renal, hepática ou cardíaca precisam de dose menor e avaliação médica.

Riscos sistêmicos dos AINE

Sistema	Risco	Quem tem mais risco
Gastrintestinal	Dispepsia, úlcera, sangramento e perfuração	Idoso, úlcera prévia, uso de anticoagulante, antiplaquetário, corticoide ou inibidor seletivo da recaptação de serotonina, álcool
Renal	Queda da filtração, retenção de sódio, hipercalemia, lesão renal aguda	Desidratação (diarreia, vômitos, calor), doença renal, uso de diurético com IECA ou BRA, idoso
Cardiovascular	Aumento da pressão, piora de insuficiência cardíaca, eventos trombóticos com uso prolongado	Hipertenso, cardiopata, pós-infarto ou AVC
Respiratório	Broncoespasmo em asma induzida por AINE	Asmático com pólipos nasais ou crise prévia com analgésico
Hematológico	Sangramento	Dengue suspeita, anticoagulados, plaquetopenia

PONTO-CHAVE

A combinação de AINE com diurético e com IECA ou BRA é a tríade clássica de lesão renal aguda em idosos. Se o cliente usa losartana e hidroclorotiazida e pede ibuprofeno para dor no joelho, prefira paracetamol ou um AINE tópico.

Gestação e amamentação

AINE orais devem ser evitados na gestação sem prescrição. No terceiro trimestre há risco de fechamento precoce do canal arterial do feto e de redução do líquido amniótico, e agências reguladoras estenderam o alerta de oligoidrâmnio ao uso a partir de cerca de 20 semanas. No balcão, gestante com dor recebe paracetamol e orientação para falar com o pré-natal. Na amamentação, o ibuprofeno é considerado compatível em doses usuais, mas a decisão de uso regular deve passar pelo médico ou pelo farmacêutico com fonte de lactação atualizada.

Formas tópicas

AINE tópicos atingem concentração local suficiente para dor de partes moles superficiais (entorse, contusão, tendinite, dor lombar mecânica) com exposição sistêmica muito menor. São boa escolha para idoso, hipertenso e quem tem risco gástrico. Orientações: aplicar em pele íntegra, 3 a 4 vezes ao dia ou conforme a bula do produto, massageando até absorver; lavar as mãos depois (exceto se as mãos forem a área tratada); não cobrir com curativo oclusivo; não aplicar em mucosas, olhos ou feridas; evitar sol direto na área tratada. A bula do Cataflampro® aerossol indica o uso para adultos e adolescentes acima de 14 anos. Produtos com salicilato de metila são contraindicados para quem tem alergia a AAS e não devem ser usados em grandes áreas ou em crianças pequenas.

Os fitoterápicos tópicos da LMIP com indicação semelhante incluem *Arnica montana* (equimoses e contusões), *Cordia verbenacea* (processos inflamatórios localizados), *Symphytum officinale* (entorses e

contusões) e *Solidago chilensis* (contusões e dores musculares).

NO BALCÃO

Antes de qualquer AINE oral, pergunte: tem ou teve úlcera, gastrite com sangramento ou fezes escuras? Usa anticoagulante, AAS, corticoide ou antidepressivo? Tem pressão alta, doença do coração ou do rim? É asmático? Está grávida? Pode ser dengue? Uma resposta positiva desloca a escolha para paracetamol, dipirona ou forma tópica.

Encaminhe: dor articular com calor, vermelhidão e febre; trauma com deformidade, incapacidade de apoiar o membro ou dor óssea localizada; dor lombar com perda de força, alteração urinária ou febre; dor que persiste após 7 a 10 dias de uso.

CASO

Homem de 68 anos, hipertenso em uso de losartana e hidroclorotiazida, pede ibuprofeno para dor no ombro após pintar a casa. Conduta: explicar o risco renal e de descompensar a pressão, indicar diclofenaco gel no ombro 3 a 4 vezes ao dia por até 7 dias, paracetamol 750 mg se necessário (máximo 4 g/dia) e encaminhar se a dor limitar o movimento ou persistir além de uma semana.

Aparelho digestivo

Azia, gases, diarreia, prisão de ventre e cólica formam o segundo grande bloco do balcão. A maior parte dos produtos é MIP, mas vários fármacos que o cliente chama pelo nome comercial (Dramin®, Plasil®, Imosec®, Tiorfan®) não são. O raciocínio começa pelo sintoma, passa pelos sinais de alarme e só então chega ao produto.

Antiácidos e alginatos

Neutralizam o ácido já secretado e aliviam a azia em minutos, com efeito curto. Os alginatos formam uma camada que flutua sobre o conteúdo gástrico e reduz o refluxo. Constam da LMIP: hidróxido de alumínio (até 230 mg por comprimido), associações de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio (comprimido mastigável, pó e suspensão), as mesmas com simeticona ou oxetacaína, magaldrato 80 mg/mL (isolado ou com simeticona), alginato de sódio com bicarbonato e carbonato de cálcio (concentração ampliada pela IN 388/2025) e os sais efervescentes com bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico.

Componente	Efeito adverso típico	Cuidado
Hidróxido de alumínio	Constipação	Acúmulo de alumínio em doença renal crônica; uso prolongado reduz fósforo
Hidróxido de magnésio	Diarreia	Acúmulo de magnésio em doença renal
Carbonato de cálcio	Constipação, eructação	Hipercalcemia com uso crônico em dose alta

Componente	Efeito adverso típico	Cuidado
Bicarbonato de sódio	Distensão, eructação	Carga de sódio: evitar em hipertenso, cardiopata, gestante e dieta hipossódica

Posologia de referência (bula do Mylanta Plus®, alumínio + magnésio + simeticona): adultos e maiores de 12 anos, 10 a 20 mL entre as refeições e ao deitar, no máximo 12 colheres-medida em 24 horas e sem usar a dose máxima por mais de 2 semanas sem supervisão médica.

ATENÇÃO

Antiácidos com alumínio, magnésio ou cálcio formam complexos com quinolonas, tetraciclinas, sais de ferro, levotiroxina e bisfosfonatos, reduzindo a absorção. Oriente intervalo de pelo menos 2 horas, ou o intervalo que constar na bula do outro medicamento. Na bula do Dulcolax®, os antiácidos aparecem também como causa de dissolução precoce do revestimento entérico do bisacodil.

Omeprazol isento de prescrição

A IN 404/2025 incluiu na LMIP o **omeprazol 20 mg** em cápsula dura e cápsula dura de liberação retardada, com a indicação simplificada de alívio de sintomas frequentes (que ocorrem em dois ou mais dias na semana) de azia e queimação. O voto da Diretoria Colegiada que aprovou a inclusão (processo 25351.918052/2023-80) define as condições: apresentações com 7 a 14 unidades, rotulagem própria sem tarja vermelha, uso por até 14 dias e intervalo mínimo de 4 meses entre ciclos, como recomendou o parecer de farmacovigilância citado no voto. As apresentações de omeprazol 20 mg com 28 ou 56 cápsulas continuam sob prescrição: o mesmo registro pode ter apresentações tarjadas e isentas (RDC 882/2024, art. 14).

Item	Omeprazol 20 mg MIP
Mecanismo	Inibe a bomba de prótons da célula parietal; efeito pleno em 1 a 4 dias
Indicação	Azia ou queimação em 2 ou mais dias por semana, sem sinal de alarme
Posologia	1 cápsula ao dia, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, por até 14 dias
Repetição	Novo ciclo só após 4 meses; sintomas que voltam antes disso pedem avaliação médica
Interações	Clopidogrel (reduz a ativação), metotrexato, varfarina, fármacos que dependem de acidez para absorver (cetoconazol oral, sais de ferro)
Não indicado	Azia ocasional que precisa de alívio imediato (antiácido age antes); dor epigástrica com sinal de alarme

PONTO-CHAVE

Nenhum antagonista H2 consta da LMIP vigente. A famotidina tem venda sob prescrição (bula do Famox®). No balcão, a escalada é antiácido ou alginato para sintoma ocasional e omeprazol 20 mg por até 14 dias para azia frequente, com encaminhamento se não resolver.

Antiflatulentos

A **simeticona** reduz a tensão superficial das bolhas de gás e facilita sua eliminação. É medicamento de notificação simplificada (LMN, IN 106/2021; a IN 430/2026 incluiu a cápsula de 250 mg). Doses do texto da LMN: emulsão 75 mg/mL ou 150 mg/mL, adultos 40 a 125 mg por dose, repetir a cada 6 horas se necessário, máximo 500 mg/dia; crianças de 2 a 12 anos, 15 a 30 mg por dose; até 2 anos, até 15 mg por dose; nas duas faixas pediátricas, máximo 180 mg/dia. Comprimido de 40 mg: adultos 1 a 3 comprimidos a cada 6 horas (máximo 12 por dia). Contraindicada em distensão abdominal grave, cólica grave, dor persistente por mais de 36 horas, massa palpável no abdome e obstrução ou perfuração suspeita. O fitoterápico *Cinnamomum verum* + *Syzygium aromaticum* (canela e cravo) consta do Anexo II da LMIP como antiflatulento.

Náusea, vômito e enjoo de movimento

Aqui está uma das maiores armadilhas do balcão. **Dimenidrinato** não consta da LMIP: as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem "Venda sob prescrição médica". Metoclopramida (Plasil®), bromoprida, domperidona e ondansetrona (Vonau®) também são tarjados. Para cinetose, a LMIP inclui a **meclozina** 50 mg (profilaxia e tratamento da cinetose) e o fitoterápico *Zingiber officinale* (gengibre, profilaxia de náuseas por movimento e pós-cirúrgicas). Mesmo assim, verifique a embalagem: um produto só é MIP se o registro dele foi adequado à lista (a bula do Meclin® consultada ainda traz venda sob prescrição).

ATENÇÃO

Vômitos em criança pequena, idoso ou gestante, vômitos com sangue ou aspecto de borra de café, vômitos que impedem a ingestão de líquidos, dor abdominal intensa, rigidez de nuca ou sonolência exigem avaliação médica. Antiemético não é produto de autocuidado no Brasil, e o papel do farmacêutico é hidratar com sais de reidratação oral e encaminhar.

Diarreia aguda

A prioridade é prevenir e tratar a desidratação. Os **sais de reidratação oral** são medicamentos de notificação simplificada (LMN): o envelope é dissolvido em 1 litro de água filtrada ou fervida, e a solução preparada é descartada após 24 horas. Para reposição de perdas, o texto da LMN indica 75 mL/kg em 4 a 6 horas, até o limite de 4 litros; crianças amamentadas continuam no peito. O farmacêutico deve diferenciar a solução de reidratação de bebidas isotônicas e refrigerantes, que têm açúcar demais e sódio de menos.

Produto	Status	Uso
Sais de reidratação oral (pó, solução)	LMN e LMIP (formulações com zinco)	Prevenção e tratamento da desidratação, todas as idades
Saccharomyces boulardii	LMIP, até 250 mg	Coadjuvante; bula do Floratil® 200 mg: 1 cápsula 2 vezes ao dia na diarreia aguda; 2 a 3 dias costumam bastar; procurar médico se persistir após 5 dias
Bacillus cereus (suspensão)	LMIP	Coadjuvante no tratamento da diarreia e de enterocolites
Policarbofila cálcica 625 mg	LMIP	Regularização do hábito intestinal em síndrome do intestino irritável e diverticulose
Subsalicilato de bismuto 35 mg/mL	LMN (incluído pela IN 430/2026)	Conferir bula; contém salicilato: mesmas restrições do AAS (criança com virose, dengue, anticoagulado)
Loperamida	Fora da LMIP (bula do Imosec®: venda sob prescrição)	Não indicar
Racecadotrila	Fora da LMIP (bula do Tiorfan®: venda sob prescrição)	Não indicar

NO BALCÃO

Pergunte: idade, há quanto tempo, quantas evacuações por dia, se há sangue, muco ou febre, se urina pouco, se há vômitos, viagem recente, uso recente de antibiótico e se outras pessoas da casa estão com o mesmo quadro.

Encaminhe: sangue nas fezes; febre alta; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina, sonolência); lactente; idoso frágil; gestante; diarreia por mais de 3 dias em adulto; diarreia após uso de antibiótico; imunossupressão.

Constipação

Antes do laxante vêm fibras, água e atividade física. A escolha segue a lógica do mecanismo: formadores de massa para uso contínuo, osmóticos para casos mais persistentes e estimulantes para uso ocasional.

Classe	Exemplos MIP	Posologia de referência	Cuidados
Formadores de massa	*Plantago ovata* (psílio), policarbofila cálcica	Conforme bula, com bastante água	Sem água suficiente podem obstruir; efeito em 1 a 3 dias
Osmóticos	Lactulose 667 mg/mL; macrogol 3350 (LMN); macrogol com eletrólitos	Lactulose (bula da Lactulona®): adulto 15 a 30 mL/dia; 6 a 12 anos 10 a 15 mL; 1 a 5 anos 5 a 10 mL; lactentes 5 mL	Flatulência e cólica no início; macrogol: não exceder 100 g/dia (LMN)

Classe	Exemplos MIP	Posologia de referência	Cuidados
Estimulantes	Bisacodil 5 mg; picossulfato de sódio 7,5 mg/mL; sene, cáscara-sagrada (*Frangula purshiana*)	Bisacodil (bula do Dulcolax®): adulto e maior de 10 anos 5 a 10 mg à noite; 4 a 10 anos 5 mg	Cólica; uso crônico só com orientação; não tomar bisacodil com leite, antiácido ou omeprazol
Lubrificante	Óleo mineral (LMN)	Adulto 15 mL à noite; maiores de 6 anos 1 a 2 mL/kg (LMN)	Risco de pneumonia lipoídica em acamado, disfágico, idoso e bebê; reduz absorção de vitaminas lipossolúveis; não usar por mais de 1 semana
Retais	Supositório de glicerina (LMN); sorbitol + laurilsulfato de sódio	Glicerina: ação em 15 a 30 minutos	Úteis em fecaloma leve e em crianças, por curto período

ATENÇÃO

Constipação recente em adulto sem causa evidente, sangue nas fezes, afinamento das fezes, perda de peso, anemia ou dor abdominal intensa pedem avaliação médica. O texto da LMN do óleo mineral orienta consultar o médico antes de usar laxante quando o hábito intestinal muda de repente por duas semanas.

Cólicas e antiespasmódicos

O **butilbrometo de escopolamina** é um antimuscarínico de amônio quaternário que relaxa a musculatura lisa digestiva, biliar e urinária com pouca passagem ao sistema nervoso central. Constam da LMIP o comprimido de 10 mg, a solução oral de 10 mg/mL e as associações com dipirona (10 + 250 mg) e com paracetamol (10 + 500 mg).

Produto	Posologia (bulas Buscopan® e Buscopan Composto®)	Cuidados
Escopolamina 10 mg	Adultos e maiores de 6 anos: 10 a 20 mg, 3 a 5 vezes ao dia	Boca seca, taquicardia, retenção urinária; evitar em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática com retenção, miastenia e megacólon
Escopolamina gotas 10 mg/mL	Adultos e maiores de 6 anos: 20 a 40 gotas, 3 a 5 vezes ao dia; 1 a 6 anos: 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia	Lactente com cólica: encaminhar ao pediatra antes de qualquer antiespasmódico
Escopolamina + dipirona 10 + 250 mg	1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia	Todas as restrições da dipirona; uso prolongado exige hemograma

Não use antiespasmódico para mascarar dor abdominal sem diagnóstico. Dor que começa no centro do abdome e migra para o lado direito inferior, dor com febre, dor com vômitos persistentes, abdome rígido ou dor em gestante são situações de pronto atendimento.

Outros produtos digestivos da LMIP

Associações de racemetionina, citrato de colina e betaína, o *Silybum marianum*, o boldo (*Peumus boldus*), a alcachofra (*Cynara scolymus*), a espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*) e o alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra*) são MIP com indicação de dispepsia e auxílio em distúrbios hepáticos ou biliares. Servem para desconforto pós-prandial leve. Não tratam doença hepática e não substituem investigação de dor persistente. O alcaçuz em uso prolongado retém sódio e eleva a pressão.

CASO

Mulher de 42 anos relata queimação retroesternal 3 a 4 vezes por semana há um mês, piora ao deitar, sem dificuldade para engolir, perda de peso, vômitos ou fezes escuras. Usa apenas anticoncepcional oral. Conduta: omeprazol 20 mg MIP, 1 cápsula em jejum por 14 dias, orientação sobre refeições menores, evitar deitar até 2 a 3 horas após comer e elevar a cabeceira; registrar a intervenção e orientar consulta médica se os sintomas não cederem ou voltarem antes de 4 meses.

Tosse, gripe e resfriado

Resfriado e gripe são infecções virais autolimitadas. Nenhum MIP encurta a doença: todos tratam sintomas. O trabalho do farmacêutico é escolher o produto que cobre o sintoma principal do cliente, evitar componentes desnecessários e reconhecer quando a "gripe" é pneumonia, sinusite bacteriana, crise de asma ou dengue.

Antigripais em associação

A LMIP inclui dezenas de associações que combinam um analgésico (paracetamol, dipirona ou AAS), um descongestionante oral (cloridrato de fenilefrina), um anti-histamínico de primeira geração (clorfeniramina, dexclorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina) e, às vezes, cafeína ou vitamina C. Exemplos de linhas da lista: paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina 400 + 4 + 4 mg; paracetamol + fenilefrina 800 + 20 mg; dipirona + clorfeniramina + cafeína 500 + 2 + 30 mg.

Componente	Para que serve	Quem deve evitar
Paracetamol, dipirona ou AAS	Febre, dor no corpo, cefaleia	Ver tópico de analgésicos; AAS nunca em criança com gripe nem em dengue suspeita
Fenilefrina oral	Congestão nasal	Hipertenso não controlado, cardiopata, hipertireoidismo, glaucoma, uso de IMAO
Anti-H1 de primeira geração	Coriza e espirros (efeito anticolinérgico seca secreção)	Idoso, motorista, quem opera máquinas, glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática
Cafeína	Contrabalança a sonolência	Insônia, arritmia, ansiedade, gestante

Exemplo de bula: Resfenol® (paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina) indica, para adultos de 18 a 60 anos, 1 cápsula a cada 4 horas, no máximo 5 cápsulas por dia e por no máximo 3 dias, e é contraindicado para menores de 18 anos. Cada associação tem limites próprios: leia a bula do produto entregue e some o paracetamol de todas as fontes.

ATENÇÃO

Antigripal mais paracetamol isolado mais "remédio para dor de cabeça" é a receita da intoxicação hepática não intencional. Antigripal com fenilefrina para hipertenso descompensado e antigripal com anti-H1 sedativo para quem vai dirigir são erros de dispensação, mesmo quando o cliente insiste no produto.

Descongestionantes nasais e solução salina

Os vasoconstritores nasais tópicos (nafazolina, oximetazolina, fenoxazolina) **não constam da LMIP**. As bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem "Venda sob prescrição médica". São de tarja vermelha sem retenção de receita, o que não autoriza vendê-los sem prescrição. Além do aspecto legal, o uso por mais de poucos dias causa rinite medicamentosa (congestão rebote que leva ao uso crônico), e a ingestão acidental por crianças pequenas pode provocar sonolência, bradicardia e hipotermia.

Produto nasal	Status	Uso
Cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico nasal)	LMN	Lavagem e umidificação; qualquer idade, quantas vezes precisar
Cloreto de sódio até 30 mg/mL (hipertônico 3%) e gel nasal	LMIP; a IN 430/2026 incluiu na LMN a solução de 20 mg/mL	Congestão e mucosa ressecada; pode arder
Acetilcisteína solução nasal 11,5 mg/mL	LMIP	Congestão com secreção espessa
Azelastina solução nasal 1 mg/mL	LMIP	Rinite alérgica (anti-H1 tópico)
Levomentol + cânfora (óleo, pomada)	LMIP	Sensação de desobstrução; não aplicar dentro do nariz de bebês
Nafazolina, oximetazolina	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Descongestionante oral isento: bronfeniramina + fenilefrina (comprimido de liberação prolongada 12 + 15 mg e soluções orais), além das associações antigripais com fenilefrina.

Antitussígenos para tosse seca

Antitussígeno só tem lugar na tosse seca, irritativa, que atrapalha o sono. Na tosse produtiva, suprimir o reflexo retém secreção. Também não faz sentido associar antitussígeno com expectorante.

Fármaco	Forma MIP	Posologia (bula)	Cuidados
Dextrometorfano	Solução oral até 3 mg/mL	Adultos e maiores de 12 anos: 10 a 20 mg a cada 4 horas ou 30 mg a cada 6 a 8 horas; máximo 120 mg/dia	Contraindicado com IMAO (até 2 semanas antes), asma, DPOC, pneumonia, insuficiência respiratória; cautela com antidepressivos serotoninérgicos; potencial de abuso

Fármaco	Forma MIP	Posologia (bula)	Cuidados
Dropropizina	Solução oral até 30 mg/mL	Gotas (bula do Vibral®): adultos 30 gotas 4 vezes ao dia; maiores de 3 anos 15 gotas; 2 a 3 anos 4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia	Sonolência; evitar em asmático e na tosse produtiva
Cloperastina	Suspensão 35,4 mg/mL; solução 3,54 mg/mL	Xarope (bula do Seki®): adultos 10 mL 3 vezes ao dia; crianças 0,5 a 1 mL/kg/dia em 3 tomadas	Sonolência leve
Clobutinol	Solução oral até 4 mg/mL	Conforme bula do produto	Tosse seca apenas
Difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio	Solução oral e pastilha	Conforme bula	Sedação (anti-H1 de primeira geração)

Expectorantes e mucolíticos

Mucolíticos reduzem a viscosidade do muco; expectorantes aumentam o volume da secreção e facilitam a eliminação. A evidência de benefício em resfriado comum é modesta, e a hidratação faz parte do tratamento.

Fármaco	Forma MIP	Adulto	Criança
Acetilcisteína	Granulado/efervescente até 600 mg; solução oral até 40 mg/mL	600 mg 1 vez ao dia, de preferência à noite, por 5 a 10 dias (bula do Fluimucil®)	Xarope 20 mg/mL: 2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes ao dia
Ambroxol	Cápsula LP 75 mg; solução 7,5 mg/mL; xarope até 6 mg/mL	Xarope adulto 5 mL 3 vezes ao dia ou cápsula de 75 mg 1 vez ao dia (bula do Mucosolvan®)	Xarope pediátrico: 2 a 5 anos 2,5 mL 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 5 mL 3 vezes ao dia (0,5 mg/kg por dose)
Bromexina	Solução 2 mg/mL; xarope até 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes ao dia (bula do Bisolvon®)	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes ao dia (0,1 mg/kg por dose)
Carbocisteína	Solução oral até 50 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula
Guaifenesina	Solução oral até 16 mg/mL; com dextrometorfano 13,3 + 1,3 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula
Fitoterápicos	*Hedera helix* (hera), *Mikania glomerata* (guaco), *Thymus*, *Pelargonium sidoides*	Conforme bula	Guaco contém cumarina: cautela em anticoagulado

ATENÇÃO

Abaixo de 2 anos, mucolíticos não são produto de automedicação: a bula do Mucosolvan® restringe o uso nessa faixa à prescrição médica e o Fluimucil® pediátrico é indicado a partir de 2 anos. Lactente com tosse e secreção precisa de avaliação, lavagem nasal com soro e hidratação.

Dor de garganta

Pastilhas e soluções da LMIP: cloreto de cetilpiridínio (antisséptico), benzocaína (anestésico local), benzidamina (anti-inflamatório local, pastilha 3,15 mg e colutório 1,5 mg/mL), cloreto de dequalínio, tirotricina com hidroxiquinolina e o **flurbiprofeno** 8,75 mg. Na bula do Strepsils® com flurbiprofeno: adultos e maiores de 12 anos, 1 pastilha a cada 3 a 6 horas, no máximo 5 em 24 horas e por até 3 dias, movimentando a pastilha na boca; não indicado abaixo de 12 anos. Como é AINE, valem as restrições de úlcera, asma por AINE, anticoagulante e dengue.

NO BALCÃO

Pergunte idade, sintoma principal (nariz, tosse seca, tosse com catarro, garganta, febre), há quantos dias, se há falta de ar, chiado ou dor no peito, doenças crônicas (hipertensão, asma, DPOC, cardiopatia, diabetes, glaucoma, próstata), gestação e medicamentos em uso, em especial antidepressivos e IMAO.

Encaminhe: falta de ar, chiado, dor torácica, febre alta por mais de 3 dias ou que volta depois de melhorar, dor facial intensa com secreção purulenta por mais de 10 dias, placas na garganta com febre alta e sem tosse, dificuldade para engolir a saliva, tosse há 3 semanas ou mais (investigar tuberculose), sintomas gripais em pessoa de grupo de risco para complicação (idoso, gestante, criança pequena, imunossuprimido, doença crônica), que pode precisar de antiviral precoce.

CASO

Homem de 55 anos, hipertenso em uso de anlodipino, pede "o antigripal mais forte" para coriza, espirros e dor no corpo há 2 dias, sem febre alta nem falta de ar. Vai dirigir para o trabalho. Conduta: evitar associação com fenilefrina e com anti-H1 sedativo; paracetamol 750 mg até 4 vezes ao dia para dor, soro fisiológico nasal várias vezes ao dia, hidratação; se a coriza incomodar à noite, considerar anti-H1 não sedativo isento. Orientar retorno se surgir febre alta ou falta de ar.

Antialérgicos isentos de prescrição

Os anti-histamínicos H1 bloqueiam o receptor H1 da histamina (agem como agonistas inversos) e aliviam coriza, espirros, prurido nasal e ocular e urticária. Os de **primeira geração** atravessam a barreira hematoencefálica e têm ação anticolinérgica: sedam, prejudicam reflexos e secam mucosas. Os de **segunda geração** quase não entram no sistema nervoso central e são tomados uma vez ao dia. A congestão nasal responde pouco a qualquer anti-H1 oral.

Enquadramento dos anti-H1

Conferência feita, fármaco a fármaco, no Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025):

Fármaco	Na LMIP?	Formas e concentração máxima
Loratadina	Sim	Comprimido e cápsula mole 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Desloratadina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 1,25 mg/mL
Fexofenadina	Sim	Comprimido revestido 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL
Levocetirizina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 5 mg/mL
Ebastina	Sim	Comprimido revestido 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Epinastina	Sim	Comprimido revestido 20 mg; solução oral 2 mg/mL
Dexclorfeniramina	Sim	Comprimido 2 mg; liberação prolongada 6 mg; solução oral 2,8 mg/mL; creme 10 mg/g
Meclozina	Sim	Comprimido 50 mg, só para cinetose
Azelastina	Sim	Solução nasal 1 mg/mL
Cetirizina	**Não**	A bula do Zyrtec® traz venda sob prescrição médica (a levocetirizina, seu enantiômero, é MIP)
Prometazina	Só tópica	Creme 20 mg/g; a forma oral é tarjada
Hidroxizina, bilastina, rupatadina	Não	Venda sob prescrição
Clorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina, feniramina	Só em associações	Antigripais, descongestionantes orais e colírio com nafazolina

PONTO-CHAVE

Status de MIP é por linha da lista, e não por classe. A levocetirizina é MIP e a cetirizina não é. A dexclorfeniramina comprimido é MIP e a prometazina comprimido não é. Na dúvida, abra a LMIP e confira fármaco, forma e concentração.

Posologia dos anti-H1 de segunda geração

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Loratadina	10 mg 1 vez ao dia; não exceder 10 mg em 24 horas	Maiores de 12 anos ou acima de 30 kg: 10 mg; 2 a 12 anos com menos de 30 kg: 5 mg (5 mL do xarope 1 mg/mL) 1 vez ao dia	Bula do Claritin®

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Desloratadina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 11 meses: 1 mg (2 mL); 1 a 5 anos: 1,25 mg (2,5 mL); 6 a 11 anos: 2,5 mg (5 mL), 1 vez ao dia	Bula do Desalex®; aumentar a dose não aumenta o efeito e pode dar sono
Fexofenadina	Rinite: 120 ou 180 mg 1 vez ao dia, ou 60 mg 12/12 h; urticária: 180 mg 1 vez ao dia ou 60 mg 12/12 h	2 a 11 anos (acima de 10,5 kg): 30 mg (5 mL) 12/12 h	Bula do Allegra®; tomar com água; antiácidos com alumínio e magnésio e sucos de fruta reduzem a absorção
Levocetirizina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez ao dia (máximo diário)	Bula do Zyxem®; ajustar em doença renal
Ebastina	10 mg 1 vez ao dia; 20 mg em rinite intensa	Comprimido para maiores de 12 anos; xarope contraindicado abaixo de 2 anos	Bula do Ebastel®; doença hepática leve a moderada: máximo 10 mg
Epinastina	Rinite: 10 a 20 mg 1 vez ao dia; dermatoses: 20 mg; máximo 40 mg/dia	6 a 12 anos: 5 a 10 mg (xarope); contraindicado abaixo de 6 anos	Bula do Talerc®

Dexclorfeniramina e a sedação

A dexclorfeniramina é o anti-H1 de primeira geração MIP mais usado, inclusive para prurido de picadas e urticária aguda. Bula do Polaramine®: adultos e maiores de 12 anos, 2 mg 3 a 4 vezes ao dia (máximo 12 mg/dia); solução 2 mg/5 mL: 6 a 12 anos, 2,5 mL 3 vezes ao dia (máximo 6 mg/dia); 2 a 6 anos, 1,25 mL 3 vezes ao dia (máximo 3 mg/dia); gotas: 2 a 6 anos, 1 gota a cada 2 kg ou 5 gotas, 3 vezes ao dia. Contraindicada em menores de 2 anos.

Efeitos esperados: sonolência, redução da atenção, boca seca, visão borrada, constipação e retenção urinária. Somam-se a álcool, benzodiazepínicos, opioides e outros depressores. Em criança pode ocorrer excitação paradoxal.

ATENÇÃO

No **idoso**, anti-H1 de primeira geração causa confusão, quedas, retenção urinária e constipação; os Critérios de Beers da Sociedade Americana de Geriatria recomendam evitá-los. Prefira loratadina, desloratadina ou fexofenadina. Para quem dirige, opera máquinas ou trabalha em altura, a regra é a mesma.

Gestação, amamentação e crianças

Na gestação, nenhum anti-H1 deve ser iniciado por automedicação: o cliente deve falar com o pré-natal, que costuma optar por fármacos com mais dados de uso, como a loratadina. Na amamentação, anti-H1 sedativos podem causar sonolência e irritabilidade no lactente e reduzir a produção de leite; os de segunda geração são preferidos, com orientação. Em crianças, respeite a idade mínima de cada bula, sempre com dose por idade ou peso e seringa dosadora.

Limites do anti-H1

Rinite persistente com obstrução nasal importante responde melhor a corticoide nasal, que exige prescrição. Rinite com tosse noturna, chiado ou falta de ar sugere asma associada. Urticária que dura mais de 6 semanas é crônica e precisa de investigação. Prurido generalizado sem lesão de pele pode ser sinal de doença hepática, renal ou hematológica.

ATENÇÃO

Inchaço de lábios, língua ou pálpebras, rouquidão, dificuldade para respirar ou engolir, tontura ou desmaio após alimento, picada de inseto ou medicamento indicam **anafilaxia** ou angioedema. Anti-H1 oral não trata anafilaxia: ligue para o SAMU (192) e não ofereça comprimido como solução.

NO BALCÃO

Pergunte: os sintomas são sazonais ou o ano todo? Há obstrução nasal, chiado ou falta de ar? Já usou anti-H1 antes? Precisa dirigir ou trabalhar em atenção? Idade, gestação, amamentação, glaucoma, próstata, doença renal ou hepática? Usa sedativos ou bebe álcool?

Para rinite intermitente leve em adulto ativo: anti-H1 de segunda geração 1 vez ao dia, lavagem nasal com soro e controle de alérgenos (poeira, ácaros, mofo). Reavalie em 7 a 14 dias e encaminhe se não houver melhora.

CASO

Motorista de aplicativo, 38 anos, com espirros e coriza clara toda manhã há 2 semanas, sem febre ou chiado, pede "Polaramine". Conduta: explicar a sedação da dexclorfeniramina e indicar loratadina 10 mg ou fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia, soro fisiológico nasal e medidas contra ácaros; encaminhar se houver obstrução persistente, chiado ou piora.

Pele e mucosas

A pele concentra o maior número de linhas da LMIP: antifúngicos, antissépticos, antibióticos tópicos, cicatrizantes, corticoide de baixa potência, antiviral labial, escabicidas e produtos para acne. A regra de ouro é identificar a lesão antes de escolher o produto. Corticoide em micose, antifúngico em eczema e antibiótico em lesão viral são erros comuns que pioram o quadro.

Antifúngicos tópicos

Indicados em micoses superficiais: frieira (tinha dos pés), micose de virilha, tinha do corpo (lesão arredondada com borda ativa e centro mais claro), pitiríase versicolor ("pano branco") e candidíase de dobras. O tratamento é longo: deve continuar por cerca de 2 semanas após o desaparecimento dos sintomas, para evitar recidiva (bula do Canesten®).

Fármaco (LMIP)	Formas e concentração máxima	Posologia de referência
Clotrimazol	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	2 a 3 vezes ao dia; pés e dobras: 3 a 4 semanas (bula do Canesten®)
Miconazol	Creme e pó 20 mg/g; emulsão 20 mg/mL	Conforme bula; a emulsão tem indicação também para dermatite de fraldas
Cetoconazol	Creme 20 mg/g; xampu 20 mg/mL	Creme 1 vez ao dia por cerca de 4 semanas (bula do Nizoral®); xampu para dermatite seborreica
Terbinafina	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	Conforme bula; alilamina de ação fungicida, costuma exigir ciclos mais curtos
Tioconazol, oxiconazol, flutrimazol, butenafina	Creme (e solução) 10 mg/g	Conforme bula
Amorolfina	Creme 2,5 mg/g; esmalte 50 mg/mL	Esmalte para onicomicose leve, uso semanal prolongado conforme bula
Ciclopirox	Esmalte 80 mg/mL; creme e spray 10 mg/mL (incluídos pela IN 388/2025)	Conforme bula
Nistatina + óxido de zinco	Pomada	Assaduras com componente de candidíase
Sulfeto de selênio	Xampu 25 mg/mL	Caspa, dermatite seborreica do couro cabeludo

Onicomicose em uma ou poucas unhas, sem atingir a base (matriz), pode ser tratada com esmalte por muitos meses. Comprometimento de várias unhas, da matriz, diabético com lesão no pé ou imunossuprimido precisam de avaliação médica, porque o antifúngico oral (terbinafina comprimido, itraconazol, fluconazol) exige prescrição.

Candidíase vaginal

Produto MIP	Esquema (bula do Gino-Canesten®)
Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal	1 aplicação à noite, dose única
Clotrimazol creme vaginal 20 mg/g	1 aplicador (cerca de 5 g) à noite por 3 noites seguidas
Clotrimazol creme vaginal 10 mg/g	1 aplicador à noite por 6 noites seguidas
Miconazol creme vaginal 20 mg/g	Conforme o número de noites indicado na bula do produto

ATENÇÃO

Só trate candidíase vaginal no balcão quando a mulher já teve diagnóstico médico prévio e reconhece o mesmo quadro: prurido intenso e corrimento branco grumoso, sem odor. Encaminhe: primeiro episódio; gestante; menor de idade; corrimento com odor forte, amarelado ou esverdeado; dor pélvica, febre ou dor ao urinar; episódios repetidos ao longo do ano; diabetes descompensado; risco de infecção sexualmente transmissível. O fluconazol oral não consta da LMIP.

Antissépticos e antibióticos tópicos

Ferida superficial é limpa primeiro com água corrente e sabão neutro. Depois, se necessário, antisséptico. São MIP: iodopovidona (pomada 10% e sabonete; também na LMN), clorexidina em solução de 0,5% a 4% (LMN), álcool 70% (LMN, só em pele íntegra) e peróxido de hidrogênio 3% (LMN), este último pouco indicado em feridas porque lesa tecido de granulação. A neomicina pomada 5 mg/g e a associação neomicina + bacitracina constam da LMIP para impetigo, furúnculo e prevenção de infecção em ferimento cortante. A neomicina é causa frequente de dermatite de contato alérgica. A sulfadiazina de prata não consta da lista.

Cicatrizantes e protetores

Dexpantenol pomada 50 mg/g, óxido de zinco (pasta e pomada, LMN), associação de vitaminas A e D com óxido de zinco ou alantoína (assaduras), colagenase pomada (desbridamento enzimático de ferimentos leves, escoriações e escaras) e ureia creme 200 mg/g (pele seca, calosidades) são MIP. Entre os fitoterápicos do Anexo II, *Aloe vera*, *Calendula officinalis* e *Matricaria recutita* têm indicação de cicatrizante em queimaduras térmicas leves.

Queimadura leve

Primeiro grau (vermelhidão e dor, sem bolha) e pequenas queimaduras de segundo grau superficial podem ser conduzidas no balcão. Orientação: resfriar com água corrente fria por vários minutos (sem gelo), retirar anéis e relógios, não furar bolhas, não aplicar pasta de dente, manteiga, café ou clara de ovo, cobrir com curativo limpo não aderente e usar analgésico oral. Para eritema solar e queimadura de primeiro grau, o acetato de hidrocortisona 1% é MIP.

ATENÇÃO

Encaminhe para atendimento: queimadura em face, mãos, pés, genitais ou sobre articulações; bolhas extensas (área maior que a palma da mão do paciente, que equivale a cerca de 1% da superfície corporal); queimadura química ou elétrica; queimadura em criança pequena ou idoso; lesão branca, acinzentada ou indolor (profunda); sinais de infecção.

Hidrocortisona tópica

O acetato de hidrocortisona creme ou pomada até 10 mg/g (1%) é o único corticoide tópico da LMIP. Indicação simplificada: dermatites, eczemas, eritema solar, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. Bula do Berlison®: camada fina 2 a 3 vezes ao dia e, após melhora, 1 vez ao dia; em bebês e

crianças de até 4 anos, não ultrapassar 3 semanas, especialmente sob fralda. Não usar em micose, herpes, acne, rosácea ou ferida infectada. Betametasona, dexametasona, mometasona, clobetasol e associações com antifúngico ou antibiótico são de venda sob prescrição.

Herpes labial

O **penciclovir** creme 10 mg/g é o antiviral tópico da LMIP. Bula do Penvir Lábia®: aplicar a cada 2 horas enquanto acordado, por 4 dias, começando aos primeiros sinais (formigamento, ardor); não recomendado abaixo de 12 anos. O **aciclovir creme não consta da LMIP**: a bula do Zovirax® traz venda sob prescrição médica. Encaminhe herpes em criança pequena, imunossuprimido, lesão perto do olho, crises muito frequentes ou lesão que não cicatriza em 10 a 14 dias.

Piolho e sarna

Produto	Status	Como usar (bula)
Permetrina 1% (10 mg/mL)	LMIP, pediculose	Xampu ou loção no cabelo molhado, deixar 10 minutos, enxaguar e passar pente fino; repetir após 7 a 14 dias se ainda houver piolhos (bula do Nedax®)
Permetrina 5% (50 mg/mL)	LMIP, escabiose	Pele limpa, seca e fria, do pescoço aos pés (incluir couro cabeludo em criança e idoso), remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação; 6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g; segunda aplicação em 7 a 10 dias se surgirem lesões novas
Deltametrina 0,2 mg/mL	LMIP, pediculose, ftiríase, escabiose	Aplicar no banho, deixar 5 minutos, enxaguar, por 4 dias seguidos; repetir o esquema 7 dias após a última aplicação (bula do Deltacid®)
Benzoato de benzila (emulsão, sabonete)	LMN	Diluir conforme bula (o Sanasar® orienta 1:1 em adultos e 1:3 em crianças); irrita a pele
Tiabendazol tópico 5%	LMN, larva migrans e escabiose	Larva migrans: 3 vezes ao dia por 5 dias; não usar em gestante e lactante
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Coceira pode persistir por até algumas semanas após o tratamento correto da escabiose e, segundo a bula da permetrina 5%, raramente indica falha. Todos os contatos da casa são tratados ao mesmo tempo, e roupas de cama, toalhas e roupas usadas nos últimos dias são lavadas com água quente ou guardadas fechadas em saco plástico por alguns dias.

Acne e rosácea

O **peróxido de benzoíla** é medicamento de notificação simplificada (LMN) em sabonete 2,5% e 5%, loção 5% e gel 10%. Texto da LMN para o gel 10%: aplicar à noite; na primeira semana, manter por 1 hora e enxaguar; sem irritação, passar a manter a noite inteira; usar fotoprotetor durante o dia; uso a partir de 12 anos. Descolore cabelo, tecidos e toalhas. Constam ainda da LMIP o ácido azelaico (creme 200 mg/g e gel

150 mg/g, acne e rosácea papulopustulosa), o metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea) e o ácido salicílico gel 270 mg/g, indicado para verrugas comuns. Adapaleno, tretinoína, clindamicina e eritromicina tópicas e isotretinoína oral exigem prescrição. Encaminhe acne com nódulos, cistos, cicatrizes, piora emocional importante ou sem resposta após algumas semanas de uso correto.

Fotoprotetores

Protetores solares são regularizados na Anvisa como cosméticos, mesmo quando vendidos em farmácia. A orientação farmacêutica continua necessária: fator de proteção alto e proteção UVA indicada no rótulo, quantidade suficiente, reaplicação a cada 2 horas e após suor ou banho de mar, barreiras físicas (chapéu, roupa, sombra) e cuidado com bebês, que devem ficar longe do sol direto. Quem usa peróxido de benzoíla, ácido azelaico ou retinoide precisa de fotoproteção rigorosa.

NO BALCÃO

Peça para ver a lesão quando o ambiente permitir privacidade. Pergunte há quanto tempo existe, se coça ou dói, se tem secreção, se já usou algum creme (corticoide mascara micose), se há pessoas na casa com o mesmo quadro, se é diabético ou imunossuprimido.

Encaminhe: lesão extensa, febre, celulite (vermelhidão quente que se espalha), lesão em face próxima ao olho, ferida que não cicatriza em 2 semanas, pinta que muda de forma, cor ou tamanho, lesão em mucosa genital sem diagnóstico.

CASO

Rapaz de 20 anos, jogador de futebol, com descamação e coceira entre o quarto e o quinto dedo dos pés há 3 semanas, sem dor, secreção ou vermelhidão subindo pelo pé. Já usou pomada de corticoide com antibiótico que "melhorou e voltou". Conduta: suspender o corticoide, terbinafina creme ou clotrimazol creme conforme bula, mantendo por 2 semanas após a cura aparente; secar bem entre os dedos, trocar meias diariamente, chinelo em vestiário. Encaminhar se não melhorar em 2 a 4 semanas.

Antiparasitários intestinais

Verminoses intestinais continuam frequentes no Brasil, sobretudo em crianças e em áreas com saneamento precário. A automedicação com "vermífugo" é antiga e, em parte, culturalmente aceita. O farmacêutico precisa saber que apenas dois antiparasitários orais constam da LMIP.

Enquadramento

Fármaco	Status	Forma e concentração
Mebendazol	LMIP	Comprimido 500 mg; suspensão oral 20 mg/mL
Levamisol	LMIP, apenas ascaridíase	Comprimido até 150 mg

Fármaco	Status	Forma e concentração
Albendazol	Fora da LMIP	A bula do Zentel® traz venda sob prescrição médica
Ivermectina, nitazoxanida, secnidazol, metronidazol oral, tinidazol, praziquantel	Fora da LMIP	Venda sob prescrição

PONTO-CHAVE

Albendazol é provavelmente o vermífugo mais pedido pelo nome, e não é MIP. Pedido de albendazol sem receita deve ser redirecionado: avalie se cabe mebendazol e, se o quadro sugerir outra parasitose (giardíase, amebíase, estrongiloidíase, teníase), encaminhe.

Mebendazol

Benzimidazol que inibe a polimerização da tubulina do parasita e bloqueia a captação de glicose. Pouco absorvido, age na luz intestinal. Indicações da bula do Pantelmin®: *Enterobius vermicularis* (oxiúro), *Trichuris trichiura*, *Ascaris lumbricoides*, ancilostomídeos e, na suspensão, também tênias.

Apresentação	Esquema (bula do Pantelmin®)
Comprimido 500 mg	Adultos e crianças acima de 1 ano: 1 comprimido em dose única, com um pouco de líquido, sem jejum ou dieta
Suspensão 20 mg/mL, nematódeos	5 mL (100 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias seguidos, independentemente de peso e idade
Suspensão 20 mg/mL, cestódeos	Adultos: 10 mL (200 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias; crianças: 5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias

Contraindicado abaixo de 1 ano pelo risco de convulsão; entre 1 e 2 anos, só se o benefício justificar, o que no balcão significa encaminhar ao pediatra. Na gestação, não usar sem orientação médica. Efeitos adversos: dor abdominal, diarreia, náusea; raramente reação de hipersensibilidade. A bula orienta evitar o uso junto com metronidazol (relato de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) e avisar o médico se o paciente usa cimetidina.

Levamisol

Agonista nicotínico que paralisa o áscaris, eliminado em até 24 horas. Dose única ao deitar, sem laxante ou dieta (bula do Ascaridil®): lactentes até 1 ano, 40 mg; 1 a 7 anos, 80 mg; acima de 7 anos e adultos, 150 mg. Serve apenas para ascaridíase. É tratamento de dose única.

Repetição de dose e medidas gerais

Na **oxiuríase** há autoinfecção (ovos na região perianal levados à boca pelas mãos) e reinfecção entre moradores. Por isso, protocolos internacionais (como o do CDC norte-americano) recomendam repetir a

dose após 2 semanas e tratar todos da casa ao mesmo tempo. A bula do mebendazol no Brasil não traz esquema de repetição, de modo que a segunda dose deve ser combinada com o prescritor ou registrada como orientação farmacêutica fundamentada. Medidas que valem para qualquer verminose: lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, manter unhas curtas, trocar e lavar roupas íntimas e de cama, lavar bem frutas e verduras, beber água tratada ou fervida, andar calçado.

"Vermífugo de seis em seis meses" para toda a família sem sintomas não é indicação de balcão. A bula do Pantelmin® cita o tratamento repetido 3 a 4 vezes ao ano em áreas altamente endêmicas, estratégia de saúde pública organizada pelo SUS que não se transfere para a rotina individual.

ATENÇÃO

Encaminhe: criança menor de 2 anos; gestante; diarreia com sangue ou muco; diarreia prolongada, perda de peso ou anemia; eliminação de "pedaços brancos e achatados" (proglotes de tênia), porque a teníase pelo *Taenia solium* se relaciona à cisticercose; prurido anal que persiste após o tratamento correto; sintomas após viagem ou contato com água de rio e lagoa (esquistossomose).

NO BALCÃO

Pergunte: quem tem os sintomas e qual a idade e o peso; qual o sintoma (coceira anal noturna sugere oxiúro; eliminação de verme longo e cilíndrico sugere áscaris); há outras pessoas na casa com o mesmo quadro; houve diarreia com sangue, febre ou perda de peso; gestação.

CASO

Mãe relata que a filha de 6 anos acorda à noite com coceira anal e que viu "vermezinhos brancos e finos" nas fezes. O irmão de 9 anos tem o mesmo sintoma. Conduta: mebendazol 500 mg em dose única para as duas crianças e para os adultos da casa, higiene de mãos e unhas, troca diária de roupa íntima e de cama, orientação de repetir em 2 semanas conforme combinado com o pediatra; encaminhar se persistir.

Vitaminas, minerais e suplementos

Vitaminas e minerais chegam à prateleira por três caminhos regulatórios diferentes, e o cliente raramente percebe a diferença. O farmacêutico precisa reconhecer em qual categoria está o produto, porque isso define se é MIP, se exige receita e o que o rótulo pode prometer.

Categorias regulatórias

Categoria	Base normativa	Como reconhecer	Exemplos
Medicamento registrado	Registro na Anvisa; categoria de venda definida no registro (RDC 882/2024 para MIP)	Número de registro do Ministério da Saúde, bula, indicação terapêutica; pode ter tarja	Vitamina D em gotas de alta concentração, ferro polimaltosado, complexo B injetável ou em alta dose

Categoria	Base normativa	Como reconhecer	Exemplos
Medicamento de notificação simplificada	RDC 576/2021; lista na IN 106/2021 com atualizações (IN 430/2026)	Venda isenta de prescrição por definição; texto de rótulo padronizado pela LMN	Sulfato ferroso, ácido fólico 0,2 mg/mL, carbonato de cálcio + colecalciferol
Suplemento alimentar	RDC 243/2018 e IN 28/2018 (listas de constituintes, limites mínimos e máximos, alegações)	É alimento; não pode alegar tratar, curar ou prevenir doença; limites por faixa etária	Polivitamínicos, vitamina D e magnésio em cápsulas

Na conferência feita para este material, bulas de vários medicamentos vitamínicos e minerais muito procurados trazem "Venda sob prescrição médica": Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum® gotas, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva® e Endofolin® (ácido fólico 5 mg). Portanto, ser vitamina não torna o produto MIP. O suplemento alimentar, por sua vez, dispensa receita, mas também não pode ser indicado para tratar deficiência diagnosticada como se fosse medicamento.

PONTO-CHAVE

Para saber se um produto vitamínico é MIP, olhe a embalagem: medicamento registrado traz a categoria de venda (com ou sem tarja); produto notificado segue a LMN; suplemento alimentar traz a designação de suplemento e não tem bula. A IN 28/2018 limita as doses diárias dos suplementos por grupo populacional, e esses limites são revistos periodicamente por novas INs.

Ferro

O sulfato ferroso consta da LMN em comprimido de 40 mg e de 60 mg de ferro elementar e em solução oral de 25 mg/mL de ferro elementar, com indicação de auxiliar nas anemias carenciais.

Apresentação (LMN)	Posologia do texto padronizado
Comprimido 40 ou 60 mg de ferro elementar	Adulto: 1 comprimido ao dia, por via oral, em jejum
Solução 25 mg/mL de ferro elementar	Maiores de 12 anos e adultos: 4 mL 1 vez ao dia; 6 a 18 meses: 1 mL 1 vez por semana; 18 meses a 6 anos: 1 mL 1 vez ao dia; 6 a 12 anos: 2 mL 1 vez ao dia

Advertências da LMN: cautela em doença hepática, úlcera péptica, alcoolismo e insuficiência renal; evitar uso por mais de 6 meses; não usar em anemia hemolítica. Efeitos adversos: constipação ou diarreia, náusea, dor abdominal, fezes escuras (esperado, deve ser avisado), escurecimento dos dentes com a solução (usar canudo ou escovar após).

Interações de absorção: antiácidos, omeprazol, cálcio, leite e derivados, chá e café reduzem a absorção; vitamina C aumenta. O ferro reduz a absorção de levotiroxina, quinolonas, tetraciclinas e bisfosfonatos: separar por pelo menos 2 horas, ou conforme a bula do outro fármaco.

ATENÇÃO

Ferro é causa importante de intoxicação grave em crianças pequenas. Oriente guardar fora do alcance e da vista, nunca chamar de "balinha" e procurar pronto-socorro imediatamente em ingestão acidental. Anemia em homem adulto ou em mulher após a menopausa pode significar sangramento digestivo oculto: encaminhe para investigação em vez de apenas vender ferro.

Ácido fólico

A LMN inclui a solução de ácido fólico 0,2 mg/mL, com duas indicações: redução da ocorrência de malformações fetais (adulto, 2 mL ao dia, ou seja, 0,4 mg) e tratamento da carência de folatos (até 5 mL ao dia, 1 mg). O texto padronizado alerta que doses acima de 0,1 mg/dia podem mascarar anemia perniciosa (o sangue normaliza enquanto o dano neurológico progride) e que doses muito altas podem precipitar convulsões em quem usa fenitoína. O ácido fólico 5 mg (Endofolin®) é de venda sob prescrição.

Mulher que planeja engravidar deve iniciar ácido fólico antes da concepção e manter no início da gestação, de preferência com acompanhamento do pré-natal. É um ótimo momento para o farmacêutico perguntar sobre planejamento reprodutivo e encaminhar à unidade de saúde.

Vitamina D e cálcio

A LMN inclui carbonato de cálcio 1250 mg (500 mg de cálcio elementar) com colecalciferol 200 UI ou 400 UI, para prevenção do raquitismo e auxílio na desmineralização óssea. Posologia padronizada: adultos, 1 a 3 comprimidos ao dia (200 UI) ou 1 a 2 comprimidos ao dia (400 UI), após as refeições; uso pediátrico, 1 comprimido ao dia. Contraindicações: hipercalcemia, hipervitaminose D, hipersensibilidade.

Medicamentos de vitamina D em alta concentração (gotas, comprimidos ou cápsulas de doses semanais ou mensais) são, nos produtos conferidos, de venda sob prescrição. Doses altas sem dosagem prévia e sem acompanhamento podem causar hipercalcemia: sede, aumento da urina, náusea, vômitos, constipação, confusão, cálculo renal e arritmia. Cálcio isolado causa constipação, interage com ferro, levotiroxina, quinolonas e tetraciclinas e deve ser usado com cautela por quem tem cálculo renal.

Complexo B e polivitamínicos

Produtos com vitaminas B1, B6 e B12 em doses altas (Citoneurin®, Benerva®) são de venda sob prescrição. Vitamina B6 em dose alta e uso prolongado causa neuropatia periférica. Polivitamínicos de uso diário costumam ser suplementos alimentares. Para o cliente que pede "algo para cansaço", a vitamina raramente é a resposta: cansaço persistente pode ser anemia, hipotireoidismo, depressão, apneia do sono ou diabetes, e merece avaliação médica. O Anexo II da LMIP inclui fitoterápicos com indicação de cansaço físico e mental (*Panax ginseng*, *Paullinia cupana*), que estimulam e podem elevar a pressão e causar insônia.

NO BALCÃO

Pergunte: para que o cliente quer a vitamina, se tem exame com deficiência diagnosticada, se está grávida ou planejando, que medicamentos usa (levotiroxina, anticonvulsivantes, anticoagulantes), se já toma outros suplementos (a soma das doses importa) e se tem doença renal ou cálculo.

Ao entregar ferro: em jejum ou longe de leite, café e antiácido, fezes escuras são esperadas, guardar longe de crianças, retornar ao médico para controle. Ao entregar vitamina D: não somar com outro produto que já contenha vitamina D sem orientação.

CASO

Mulher de 28 anos diz que vai "tentar engravidar" e pede um polivitamínico "para gestante". Conduta: explicar a importância do ácido fólico antes da concepção, indicar ácido fólico 0,4 mg ao dia (2 mL da solução 0,2 mg/mL, conforme a LMN), orientar consulta pré-concepcional na unidade de saúde, revisar medicamentos em uso (anticonvulsivantes, isotretinoína, varfarina) e registrar a orientação.

Olhos, ouvidos e boca

Olhos, ouvidos e boca têm MIP úteis e também os sintomas de alarme mais traiçoeiros do balcão. Dor ocular, baixa de visão e dor de ouvido com febre não são casos de automedicação.

Lubrificantes oculares (lágrimas artificiais)

Constam da LMIP, com indicação de lubrificante oftálmico: carmelose sódica 10 mg/mL (isolada ou com glicerol), hialuronato de sódio 2 mg/mL, hipromelose 5 mg/mL, dextrana com hipromelose (com ou sem glicerol), álcool polivinílico 14 mg/mL, carbômer gel (com ou sem sorbitol) e macrogol com propilenoglicol (com ou sem hidroxipropil guar). Indicação de balcão: olho seco por tela, ar-condicionado, vento, leitura prolongada. Uso: 1 a 2 gotas várias vezes ao dia, conforme bula; o gel é melhor à noite porque embaça a visão.

- Usuário de lente de contato: escolher produto compatível com lente ou sem conservante (o cloreto de benzalcônio adere às lentes gelatinosas); na dúvida, retirar a lente e aguardar o tempo da bula.
- Frascos multidose têm validade curta após abertos, definida na bula. Flaconetes de dose única sem conservante são descartados após o uso.
- Não encostar a ponta do frasco no olho ou nos cílios.
- Mais de um colírio: intervalo de cerca de 5 minutos entre eles.

Vasoconstritores oculares

Constam da LMIP: nafazolina + feniramina (0,25 + 3 mg/mL), nafazolina + sulfato de zinco (0,15 + 0,3 mg/mL) e cloreto de benzalcônio + ácido bórico (irritação e higiene ocular). Bula do Colírio Moura Brasil®: 1 a 2 gotas no olho afetado até 4 vezes ao dia; procurar o médico se a irritação persistir, se houver dor ou alteração da visão. Contraindicações de vasoconstritores: glaucoma de ângulo fechado e uso de IMAO.

ATENÇÃO

O vasoconstritor clareia o olho por algumas horas, mas o uso contínuo causa **hiperemia de rebote** e dependência do colírio. Indique por poucos dias, para irritação leve, e nunca para olho vermelho com dor, secreção purulenta, fotofobia ou baixa da visão. Colírios com antibiótico, corticoide, anti-inflamatório ou anti-glaucomatoso exigem prescrição.

Sinal de alarme ocular	Possível causa	Conduta
Dor ocular intensa, visão embaçada, halos, náusea	Glaucoma agudo	Emergência oftalmológica
Olho vermelho em usuário de lente de contato	Ceratite	Retirar a lente e procurar oftalmologista no mesmo dia
Respingo de produto químico	Queimadura química	Lavar com água corrente abundante por vários minutos e ir ao pronto-socorro
Corpo estranho que não sai, trauma	Lesão de córnea	Não esfregar; encaminhar
Secreção purulenta, pálpebras coladas	Conjuntivite bacteriana	Avaliação médica

Ouvidos

A LMIP inclui duas soluções otológicas com indicação simplificada de dor de ouvido e remoção de cerume: hidroxiquinolina + trolamina (0,4 + 140 mg/mL) e fenol + mentol (18,6 + 1,3 mg/mL). Bula do Cerumin®: 5 gotas no ouvido afetado, 3 vezes ao dia, com intervalo de cerca de 8 horas, aplicadas com a pessoa deitada e o ouvido para cima, mantendo a posição por 5 minutos; o refluxo da solução é normal.

ATENÇÃO

Não pingue nada no ouvido se houver suspeita de perfuração do tímpano (saída de secreção ou sangue, dor que melhorou de repente após muita dor), tubo de ventilação, cirurgia prévia no ouvido, febre ou dor intensa. Dor de ouvido em criança com febre é otite média até prova em contrário e precisa de avaliação. Antibióticos e corticoides otológicos não são MIP. Cotonete empurra o cerume e pode ferir o canal.

Boca e garganta

MIP de uso bucal: cloridrato de benzidamina colutório 1,5 mg/mL (inflamação da boca e garganta), cetilpiridínio em solução, associações para aftas com camomila (*Matricaria chamomilla*), lidocaína e polidocanol em gel ou solução, tirotricina com hidroxiquinolina e fluoreto (gel), neomicina com bismuto e procaína (suspensão para aftas) e procaína com timol, mentol e cânfora. Enxaguantes de uso diário sem indicação terapêutica costumam ser produtos de higiene bucal regularizados como cosméticos.

- Afta comum: pequena, dolorosa, com halo vermelho, cicatriza em 7 a 14 dias. Anestésico tópico alivia a dor para comer.

- Encaminhe ao dentista ou médico: lesão que não cicatriza em 2 a 3 semanas, mancha branca ou vermelha que não sai ao raspar, lesão endurecida, especialmente em fumante e etilista (risco de câncer de boca); múltiplas lesões com febre em criança; aftas muito frequentes.
- Dor de dente: analgésico como ponte até o dentista; abscesso com inchaço no rosto, febre ou dificuldade para abrir a boca é urgência.
- Gengivas que sangram ao escovar indicam doença periodontal; o antisséptico não substitui o tratamento odontológico.

NO BALCÃO

Olho: pergunte se há dor, alteração da visão, secreção, trauma, uso de lente de contato, glaucoma. Ouvido: dor, febre, secreção, sensação de ouvido tapado após banho ou piscina, cirurgia prévia. Boca: há quanto tempo a lesão existe, se dói, se é recorrente, se fuma.

Ao entregar colírio, ensine a técnica: lavar as mãos, inclinar a cabeça, puxar a pálpebra inferior, pingar sem encostar, fechar o olho por 1 a 2 minutos comprimindo o canto interno.

CASO

Analista de sistemas de 30 anos, usuária de lente de contato gelatinosa, pede colírio "para tirar a vermelhidão" de olhos ardidos no fim do expediente, sem dor, secreção ou baixa da visão. Conduta: não indicar vasoconstritor de uso contínuo; lágrima artificial sem conservante ou compatível com lentes, pausas de tela, reduzir horas de uso da lente; encaminhar ao oftalmologista se surgir dor, secreção ou fotofobia.

Outros produtos de balcão

Alguns MIP não cabem nas classes anteriores, mas aparecem todos os dias no balcão: a terapia de reposição de nicotina, os fitoterápicos, o analgésico urinário, os produtos para hemorroidas e a solução capilar para calvície. Ao lado deles, dois itens que o cliente costuma achar que são de venda livre: o contraceptivo de emergência e certos testes.

Terapia de reposição de nicotina

A nicotina do adesivo, da goma ou da pastilha alivia a síndrome de abstinência (irritabilidade, ansiedade, fissura, insônia, aumento do apetite) sem o monóxido de carbono e as substâncias cancerígenas da fumaça. A LMIP inclui o adesivo transdérmico até 21 mg e a goma de mascar e a pastilha até 4 mg, com indicação de dependência do tabaco. Funciona melhor quando associada a aconselhamento comportamental, oferecido gratuitamente no SUS.

Forma	Esquema (bulas)	Como usar
Adesivo 24 horas (NiQuitin®, Nicotinell®)	Mais de 10 cigarros/dia: 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas. Até 10 cigarros/dia: 14 mg por 6 semanas, 7 mg por 2 semanas	1 adesivo por dia, pela manhã, em pele limpa, seca e sem pelos; trocar o local a cada dia e não repetir o mesmo local por 7 dias; não cortar

Forma	Esquema (bulas)	Como usar
Goma (Nicorette®)	Iniciar com 2 mg; quem fuma mais de 20 cigarros/dia inicia com 4 mg; máximo 30 gomas de 2 mg ou 24 de 4 mg por dia	Mascar devagar até sentir sabor forte ou formigamento, "estacionar" entre bochecha e gengiva, voltar a mascar; cerca de 30 minutos por goma
Pastilha (NiQuitin®)	2 mg se o primeiro cigarro é após 30 minutos do despertar; 4 mg se é nos primeiros 30 minutos. Semanas 1 a 6: 1 a cada 1 a 2 horas (mínimo 9 por dia); 7 a 9: a cada 2 a 4 horas; 10 a 12: a cada 4 a 8 horas; máximo 20 por dia; até 24 semanas	Deixar dissolver movendo na boca (20 a 30 minutos); não mastigar nem engolir; não comer ou beber durante o uso

Idade mínima conforme o produto: a bula do NiQuitin® contraindica abaixo de 12 anos e a do Nicorette® abaixo de 18 anos. Efeitos adversos: irritação no local do adesivo, sonhos vívidos e insônia (adesivo de 24 horas pode ser retirado ao deitar), soluço, irritação da boca e dor na mandíbula com a goma, náusea. Sinais de excesso de nicotina (náusea, salivação, palpitação, tontura) indicam que a pessoa continua fumando junto ou que a dose está alta.

ATENÇÃO

Precisam de avaliação médica antes da reposição: infarto ou AVC recentes, arritmia grave, angina instável, gestação e amamentação. Ainda assim, para quase todos os cardiopatas a nicotina medicinal é muito menos perigosa do que continuar fumando; a decisão cabe ao médico, e o papel do farmacêutico é encaminhar. Bupropiona e vareniclina exigem prescrição.

Fitoterápicos MIP

O Anexo II da LMIP (IN 285/2024) lista 57 espécies ou associações de fitoterápicos isentos de prescrição. Para ser MIP, o produto precisa ter a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha da lista (IN 285/2024, art. 1º, § 3º), e ser registrado ou notificado como medicamento na Anvisa. Chá vendido como alimento não tem indicação terapêutica.

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Varizes, peso e inchaço nas pernas	*Aesculus hippocastanum* (castanha-da-índia), *Centella asiatica*, *Vitis vinifera*	Edema de uma perna só, quente e dolorosa: suspeitar de trombose e encaminhar
Dispepsia, azia, digestão lenta	*Peumus boldus* (boldo), *Cynara scolymus* (alcachofra), *Monteverdia ilicifolia* (espinheira-santa), *Glycyrrhiza glabra* (alcaçuz), *Silybum marianum*	Alcaçuz eleva pressão e baixa potássio; boldo não é para gestante; obstrução biliar contraindica coleréticos
Tosse e gripe	*Hedera helix* (hera), *Mikania glomerata* (guaco), *Thymus vulgaris*, *Pelargonium sidoides*, *Eucalyptus globulus*	Guaco tem cumarina: cautela com varfarina

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Ansiedade leve e insônia	*Passiflora incarnata*, associações com *Valeriana officinalis*, *Crataegus*, *Salix alba*; *Melissa officinalis*	Somam sedação com álcool e benzodiazepínicos; ansiedade intensa precisa de avaliação
Cansaço físico e mental	*Panax ginseng*, *Paullinia cupana* (guaraná), *Rhodiola rosea*	Insônia, palpitação, aumento da pressão
Constipação ocasional	*Senna alexandrina*, *Cassia fistula*, *Frangula purshiana*, *Plantago ovata*	Estimulantes só por curto período
Cinetose e náusea	*Zingiber officinale* (gengibre)	Cautela com anticoagulantes em doses altas
Trato urinário	*Vaccinium macrocarpon* (cranberry): prevenção de infecção urinária; *Serenoa repens*: sintomas de hiperplasia prostática depois que um médico excluiu doenças mais sérias	Cranberry não trata infecção instalada
Climatério	*Glycine max* (soja, isoflavonas)	Ondas de calor intensas ou sangramento pós-menopausa: médico
Dor articular e lombar leve	*Harpagophytum* (garra-do-diabo), *Salix alba*, *Uncaria tomentosa*	*Salix* contém salicilatos: mesmas restrições do AAS

Ginkgo biloba e *Hypericum perforatum* (erva-de-são-joão) não constam do Anexo II. A erva-de-são-joão é potente indutora enzimática e reduz o efeito de anticoncepcionais, varfarina, ciclosporina e antirretrovirais, razão a mais para perguntar sobre "chás e remédios naturais" em toda anamnese.

Contraceptivo de emergência

O levonorgestrel 1,5 mg em dose única (Postinor Uno® e similares) **não consta da LMIP**, e a bula traz "Venda sob prescrição médica". É de tarja vermelha sem retenção de receita. Por não ser MIP, não pode ser objeto da prescrição farmacêutica de medicamentos isentos regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013, e sua dispensação depende de prescrição. Também é oferecido gratuitamente nas unidades de saúde do SUS.

- Uso (bula do Postinor Uno®): 1 comprimido o mais cedo possível após a relação desprotegida, sem ultrapassar 72 horas; a eficácia cai com a demora.
- Vômito em até 4 horas após a dose: repetir a dose.
- Age principalmente impedindo ou retardando a ovulação; não interrompe gravidez já implantada.
- Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis; orientar testagem e preservativo.
- A menstruação pode adiantar ou atrasar; atraso importante pede teste de gravidez.
- Indutores enzimáticos (carbamazepina, fenitoína, rifampicina, efavirenz, erva-de-são-joão) reduzem a eficácia; a mulher deve procurar o serviço de saúde.
- Não é método de uso regular: oriente planejamento reprodutivo na unidade de saúde.

NO BALCÃO

Atenda em local reservado, sem julgamento. Diante de pedido sem receita, explique que o medicamento exige prescrição, informe que a unidade básica de saúde, a UPA e os serviços de referência fornecem o contraceptivo de emergência e que o tempo importa. Se houver relato de violência sexual, oriente atendimento imediato no serviço de referência, que oferece contracepção de emergência, profilaxias e acolhimento.

Fenazopiridina

Analgésico local das vias urinárias, consta da LMIP em comprimido de 200 mg para dor, ardor e desconforto ao urinar. Bula do Pyridium®: 200 mg a cada 8 horas, após as refeições. Colore a urina de laranja ou vermelho e pode manchar roupas e lentes de contato. Se os sintomas persistirem por mais de 2 dias, o médico deve ser consultado; pele ou olhos amarelados indicam acúmulo do fármaco (função renal reduzida) e exigem suspensão.

ATENÇÃO

A fenazopiridina alivia o sintoma e não trata a infecção urinária. Ela pode mascarar a evolução para pielonefrite. Encaminhe sempre: homem, gestante, criança, idoso frágil, febre, dor lombar, sangue na urina, sintomas recorrentes, diabetes descompensado. Mulher adulta sem esses sinais precisa de avaliação para antibiótico, e a fenazopiridina é apenas ponte de até 2 dias.

Hemorroidas

MIP para hemorroidas e fissuras: policresuleno + cinchocaína (pomada retal 50 + 10 mg/g e supositório), tribenosídeo + lidocaína (creme retal e supositório) e o fitoterápico *Hamamelis virginiana*. Para hematomas e flebite superficial, o polissulfato de mucopolissacarídeo e a heparina sódica em gel. Orientação: fibras, água, não forçar a evacuação, banho de assento morno. Sangramento retal sem diagnóstico, sobretudo após os 45 a 50 anos ou com mudança do hábito intestinal, deve ser investigado.

MIP pouco lembrados

- Alfaestradiol solução capilar 0,25 mg/mL: alopecia androgenética. O minoxidil tópico não consta da LMIP.
- Menaeptenona (vitamina K2) 180 mcg: auxiliar na mineralização óssea.
- Acetato de hidrocortisona 1%, penciclovir e colagenase: tópicos já vistos, que muitos alunos imaginam ser tarjados.
- Nistatina oral, aciclovir creme, cetoconazol comprimido, fluconazol, albendazol e dimenidrinato: o inverso, tarjados que o cliente imagina serem de venda livre.

Testes rápidos e autotestes

Os exames de análises clínicas feitos na farmácia seguem a RDC 978/2025, que revogou a RDC 786/2023. A farmácia que executa exames é **serviço tipo I** (art. 8º): só usa amostra obtida por punção capilar

(glicemia, testes rápidos em sangue), coleta em cavidade oral ou swab de nasofaringe ou orofaringe (redação da RDC 986/2025) e faz todas as etapas no próprio estabelecimento, com controle interno e externo da qualidade (art. 10). A atividade precisa constar da licença sanitária (art. 63), o exame é feito por profissional legalmente habilitado (art. 11) e tem finalidade de triagem, nunca confirmatória (art. 60). O resultado vai na Declaração de Serviço Farmacêutico, com o valor de referência e a frase de que o procedimento não tem finalidade de diagnóstico, e os registros são guardados por no mínimo 5 anos. O Ministério da Saúde publicou nota técnica sobre testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais em farmácias habilitadas, com exigência de confirmação laboratorial dos resultados reagentes.

Autotestes vendidos para uso em casa (gravidez, HIV, covid-19, entre outros) são produtos para diagnóstico in vitro registrados na Anvisa, fora da categoria de medicamentos. A RDC 978/2025 não se aplica à venda de autotestes regularizados. Ao vender, oriente sobre janela imunológica, leitura correta, necessidade de confirmação e onde buscar atendimento em caso de resultado reagente.

CASO

Homem de 45 anos, fumante de 25 cigarros por dia que acende o primeiro logo ao acordar, quer parar de fumar. Sem infarto, AVC ou arritmia. Conduta: adesivo de 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas e 7 mg por 2 semanas; marcar data para parar; encaminhar ao programa de cessação do SUS para apoio comportamental; orientar sobre irritação da pele e insônia; agendar retorno na farmácia em 2 semanas para acompanhar sintomas de abstinência.

Fontes consultadas

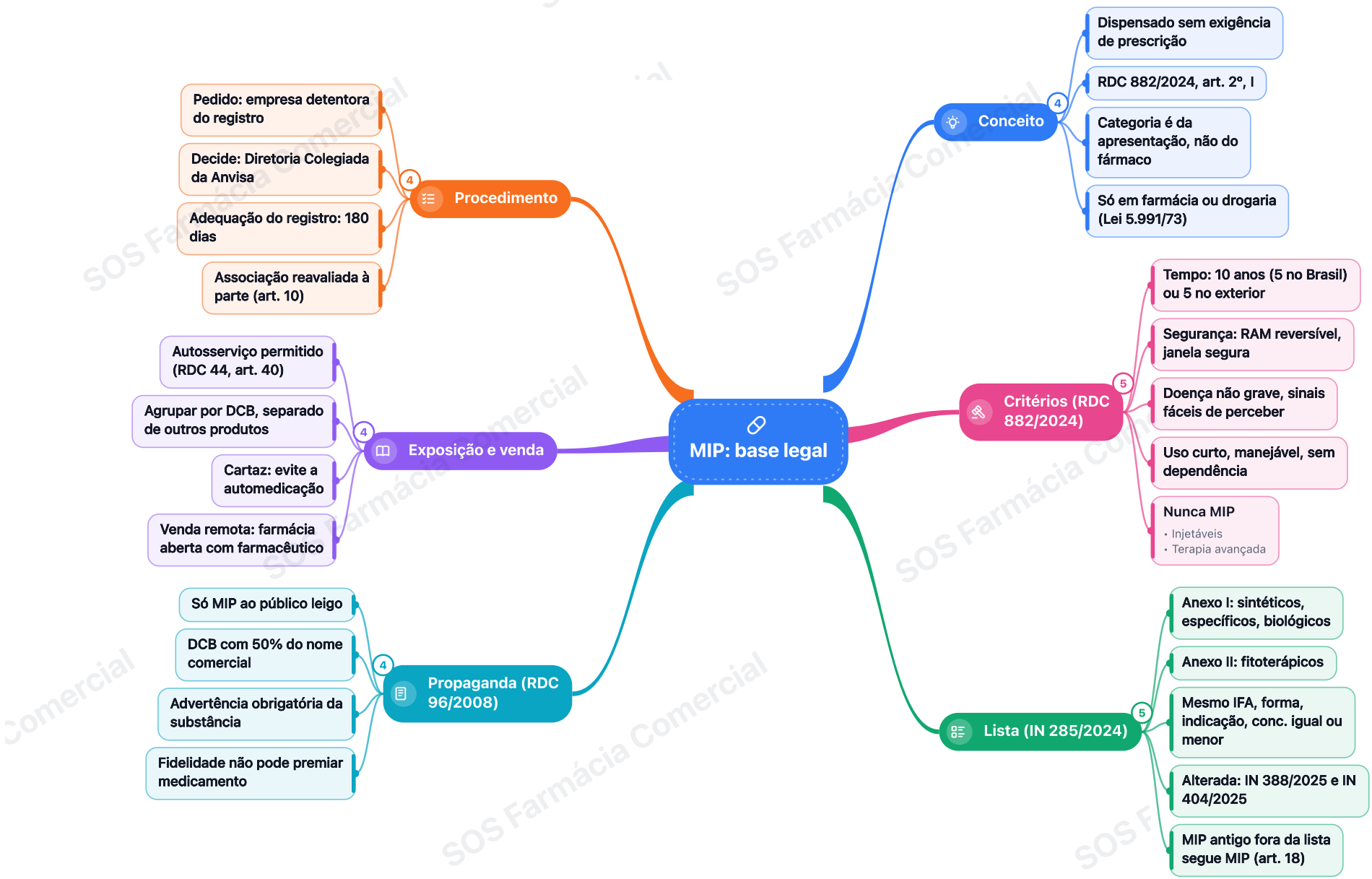
1. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
2. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como sob prescrição (vigência em 1º/7/2024; revoga a RDC nº 98/2016). Texto consolidado no AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
4. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 285, de 7 de março de 2024. Define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. Texto consolidado com as alterações da IN nº 388, de 29/07/2025, e da IN nº 404, de 10/11/2025. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
5. Anvisa. Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) e Legislação vigente de MIP. Portal gov.br/anvisa, consultado em 08/10/2026.
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Texto consolidado com alterações das RDC nº 41/2012, nº 786/2023 e nº 812/2023. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
7. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Diário Oficial da União, 10/06/2025.
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Propaganda, publicidade e informação de medicamentos. Texto consolidado com alterações da RDC nº 23/2009 e da RDC nº 576/2021. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
9. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/586.pdf

10. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf
11. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 724, de 29 de abril de 2022. Código de Ética, Código de Processo Ético e infrações e sanções ético-disciplinares. Diário Oficial da União, 24/05/2022, Seção 1, p. 180.
12. Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 17ª Vara Federal Cível. Ação Civil Pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 (CFM x CFF). Sentença de 18/11/2024. Cópia publicada pelo CFM em portal.cfm.org.br.
13. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a Resolução nº 586/2013. Notícia de 22/11/2024. site.cff.org.br
14. Conselho Federal de Farmácia. Conselho Federal de Farmácia (CFF) se manifesta sobre a Resolução nº 5/2025. Notícia de 20/03/2025; e CFF recorre e Justiça analisa direito à prescrição de medicamentos por farmacêuticos, notícia de 02/05/2025. site.cff.org.br
15. Demarest Advogados. CFF autoriza a prescrição de medicamentos tarjados por farmacêuticos e institui o Registro de Qualificação de Especialista (Resoluções CFF nº 4/2025 e nº 5/2025; suspensão liminar em 31/03/2025). demarest.com.br, 2025.
16. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer de decisão que suspende prescrição de contraceptivos por farmacêuticos (Resolução CFF nº 12/2024). Notícia de 20/05/2026. site.cff.org.br
17. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: espirro e congestão nasal. Brasília: CFF, 2016 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 1).
18. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas não específicos: febre. Brasília: CFF, 2018 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 3).
19. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas do trato gastrintestinal: azia (acidez/pirose) e dispepsia. Brasília: CFF, 2020 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 4).
20. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: tosse. Brasília: CFF, 2021 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 5).
21. Brasil. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, nº 28, volume II. Brasília: Ministério da Saúde, 2012 (1ª reimpressão, 2013).
22. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2023.
23. U.S. Food and Drug Administration. FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. Drug Safety Communication, outubro de 2020.
24. Anvisa. Nota sobre paracetamol na gestação, 24/09/2025; Febrasgo, nota de 22/09/2025 (conforme noticiado pela imprensa; textos originais não consultados).
25. Pharmacy mnemonics (WWHAM, ASMETHOD, SIT DOWN SIR, ENCORE). ResourcePharm e material de formação Numark (Counter Excellence), consultados em 08/10/2026.
26. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024. Institui as Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (Anexo I e Anexo II). Diário Oficial da União, 12 mar. 2024.
27. Anvisa. Instrução Normativa nº 388, de 29 de julho de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão de ciclopirox e ampliação de concentração de alginato com bicarbonato e carbonato de cálcio). Diário Oficial da União, 2025.
28. Anvisa. Instrução Normativa nº 404, de 10 de novembro de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão do omeprazol 20 mg) e republica o Anexo I. Diário Oficial da União, 13 nov. 2025.
29. Anvisa. Diretoria Colegiada. Voto nº 261/2025, processo 25351.918052/2023-80: inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP. ROP 18/2025.
30. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Requisitos e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição. Diário Oficial da União, 21 jun. 2024.
31. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 576, de 11 de novembro de 2021. Notificação de medicamentos de baixo risco. Diário Oficial da União, 2021.

32. Anvisa. Instrução Normativa nº 106, de 11 de novembro de 2021. Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN). Diário Oficial da União, 2021.
33. Anvisa. Instrução Normativa nº 430, de 24 de março de 2026. Atualiza a Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação. Diário Oficial da União, 26 mar. 2026.
34. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 243, de 26 de julho de 2018, e Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, com atualizações. Suplementos alimentares.
35. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Serviços que executam exames de análises clínicas. Revogada pela RDC nº 978/2025.
36. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica.
37. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (Apêndice H, uso de medicamentos para dengue).
38. Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento científico: Abordagem da febre aguda em pediatria e reflexões sobre a febre nas arboviroses. 2025.
39. Jornal de Pediatria. Estudo sobre uso alternado de antitérmicos em crianças no Sul do Brasil. 2013.
40. Bulas consultadas (texto reproduzido no portal Consulta Remédios, outubro de 2026): Novalgina®, Dipirona Iquego, Tylenol®, Aspirina®, Advil® 400 mg, Alivium®, Flanax®, Cataflampro®, Mylanta Plus®, Buscopan®, Buscopan Composto®, Floratil®, Dulcolax®, Lactulona®, Fluimucil®, Mucosolvan®, Bisolvon®, Vibral®, Seki®, Bromidrato de Dextrometorfano, Strepsils®, Resfenol®, Benegrip®, Claritin®, Desalex®, Allegra®, Zyxem®, Polaramine®, Ebastel®, Talerc®, Canesten®, Gino-Canesten®, Nizoral®, Berlison®, Penvir Lábia®, Nedax®, Permetrina 5%, Deltacid®, Sanasar®, Pantelmin®, Ascaridil®, Pyridium®, Colírio Moura Brasil®, Lacrima Plus®, Cerumin®, NiQuitin® adesivo e pastilha, Nicotinell®, Nicorette®, Postinor Uno®.
41. Bulas consultadas para categoria de venda (venda sob prescrição médica): Dramin®, Dramin B6®, Plasil®, Vonau®, Imosec®, Tiorfan®, Famox®, Neosoro®, Sorine®, Afrin®, Zyrtec®, Zovirax®, Zentel®, Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum®, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva®, Endofolin®, Meclin®.

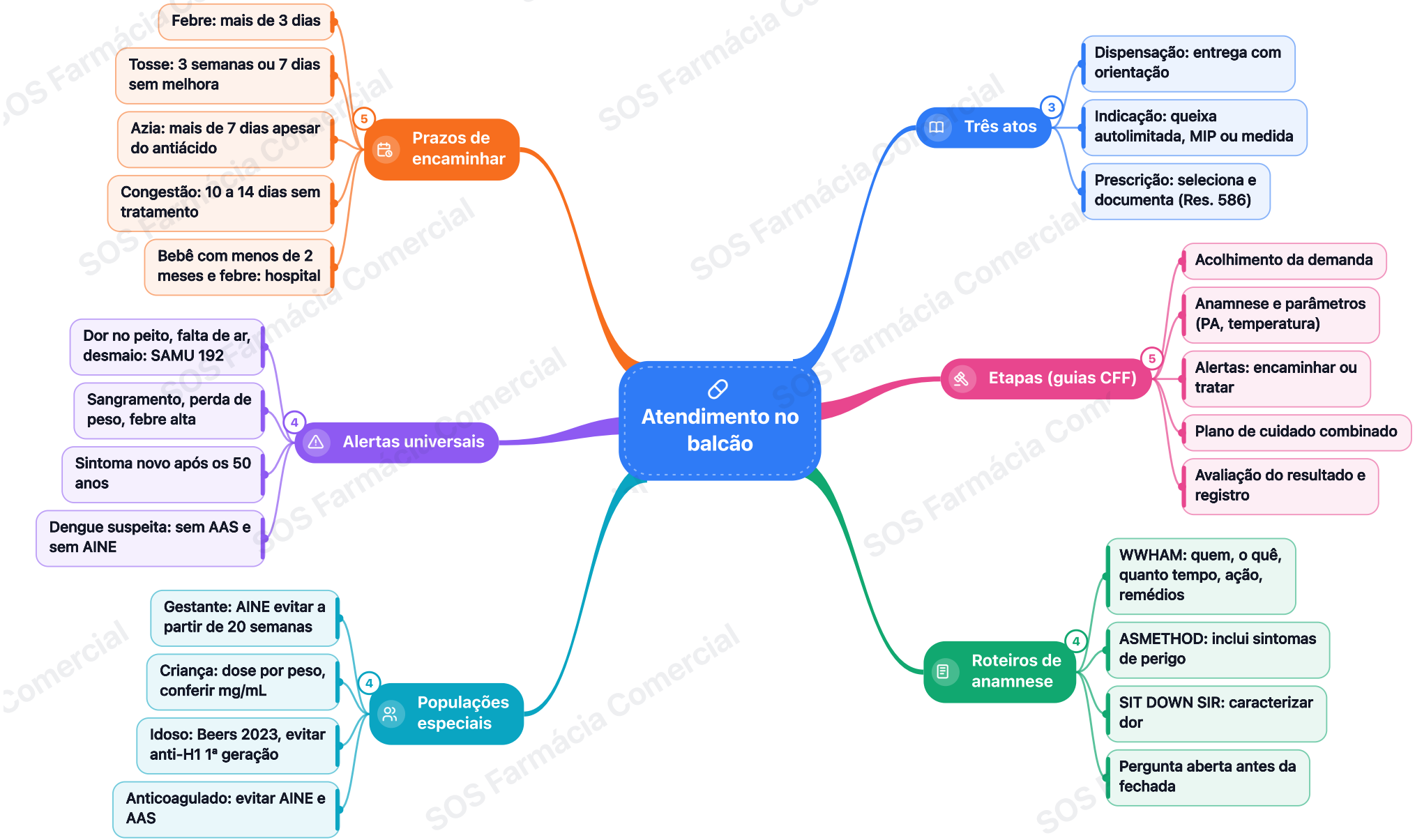
MIP: base legal

6 ramos · 26 itens · mapa mental do módulo 12



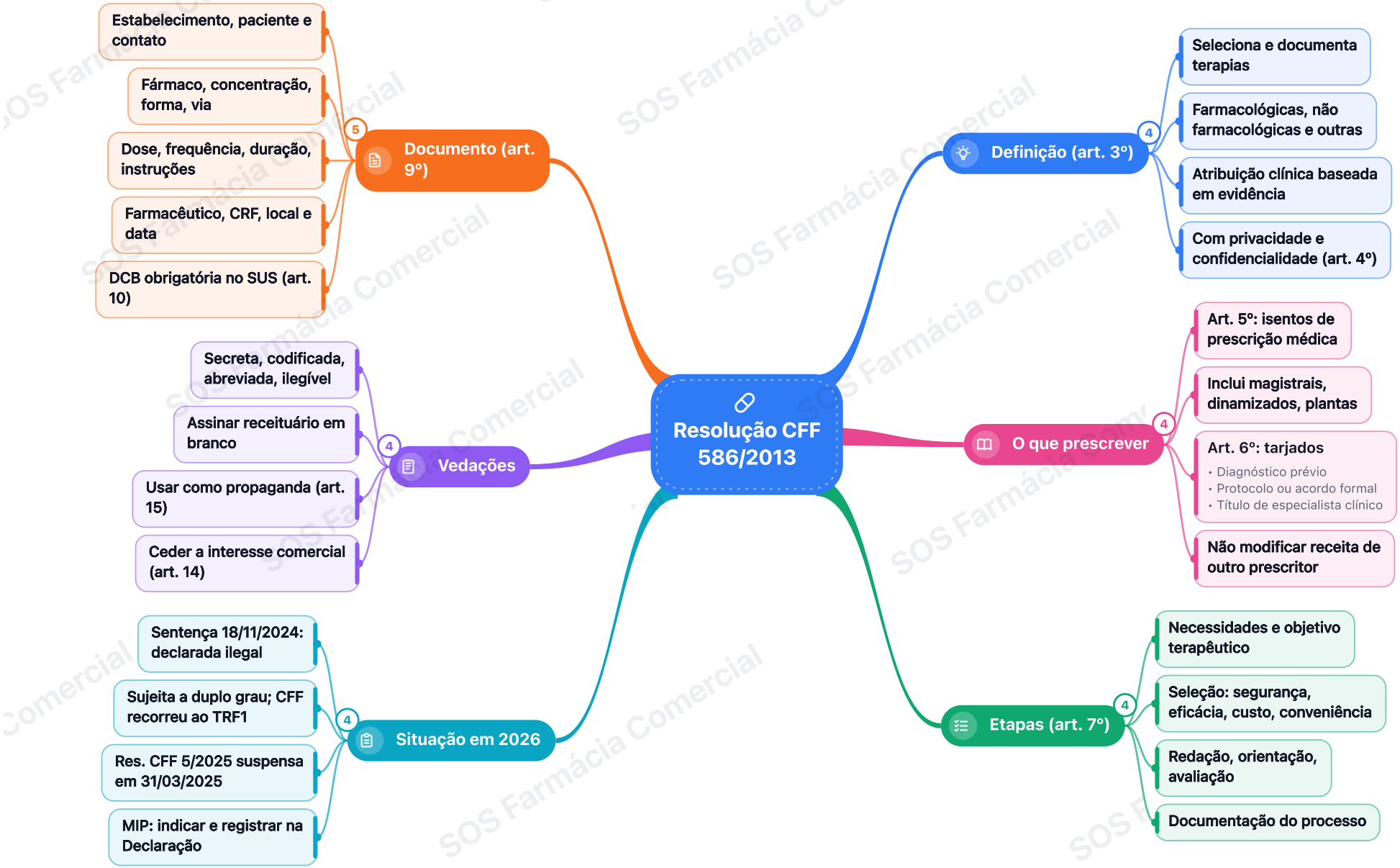
Atendimento e sinais de alerta

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 12



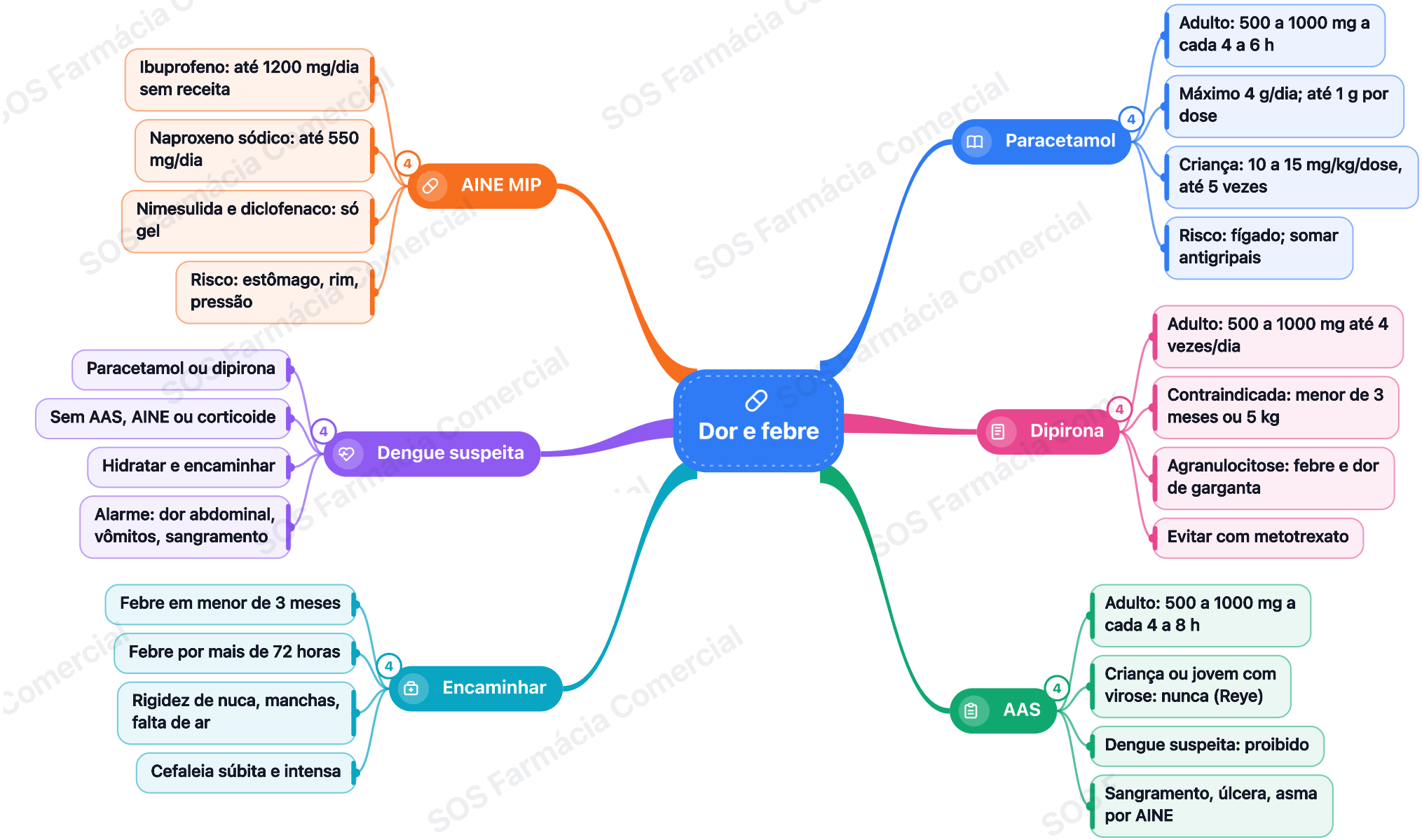
Prescrição farmacêutica (Resolução CFF nº 586/2013)

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 12



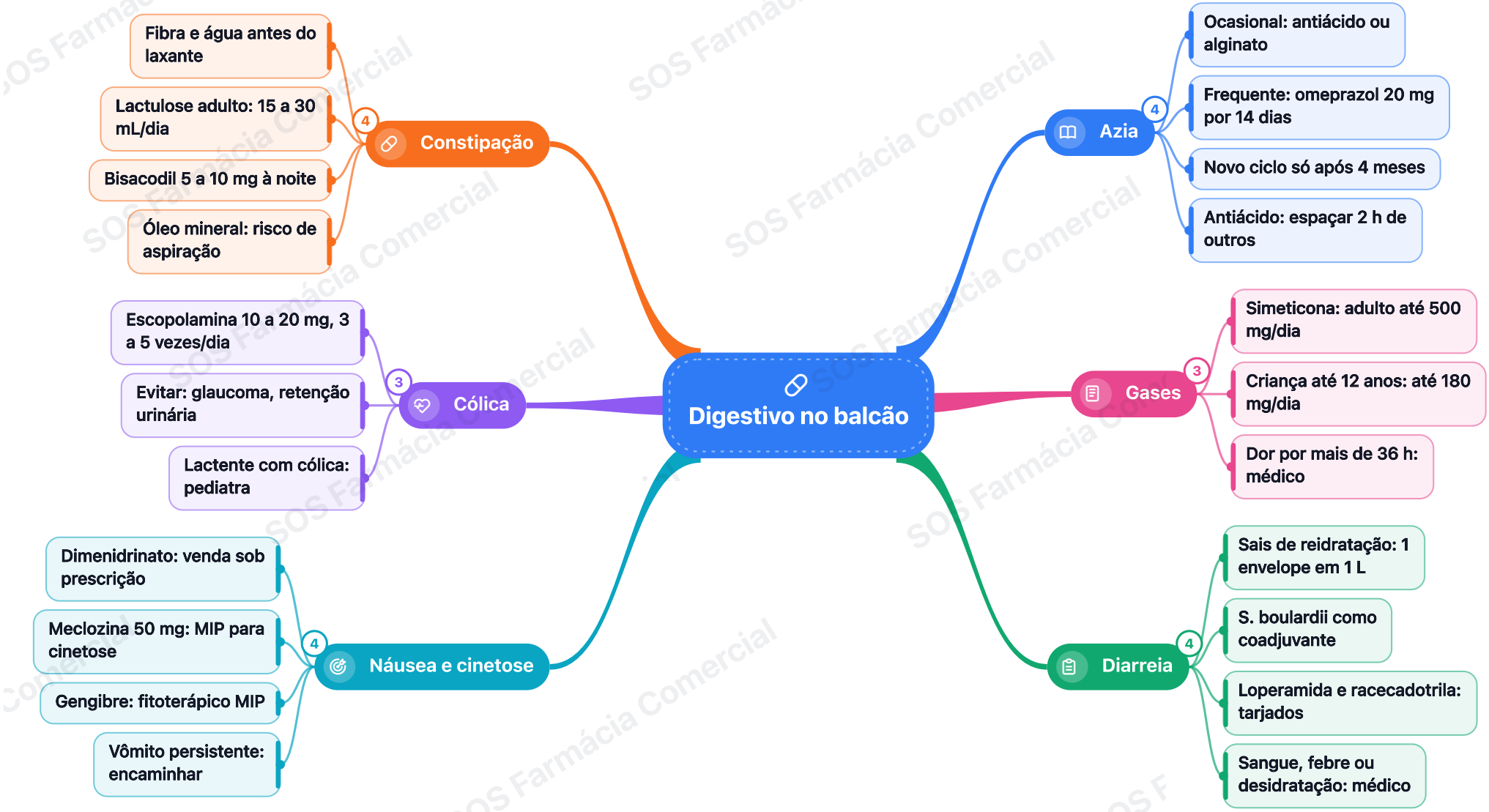
Dor e febre no balcão

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 12



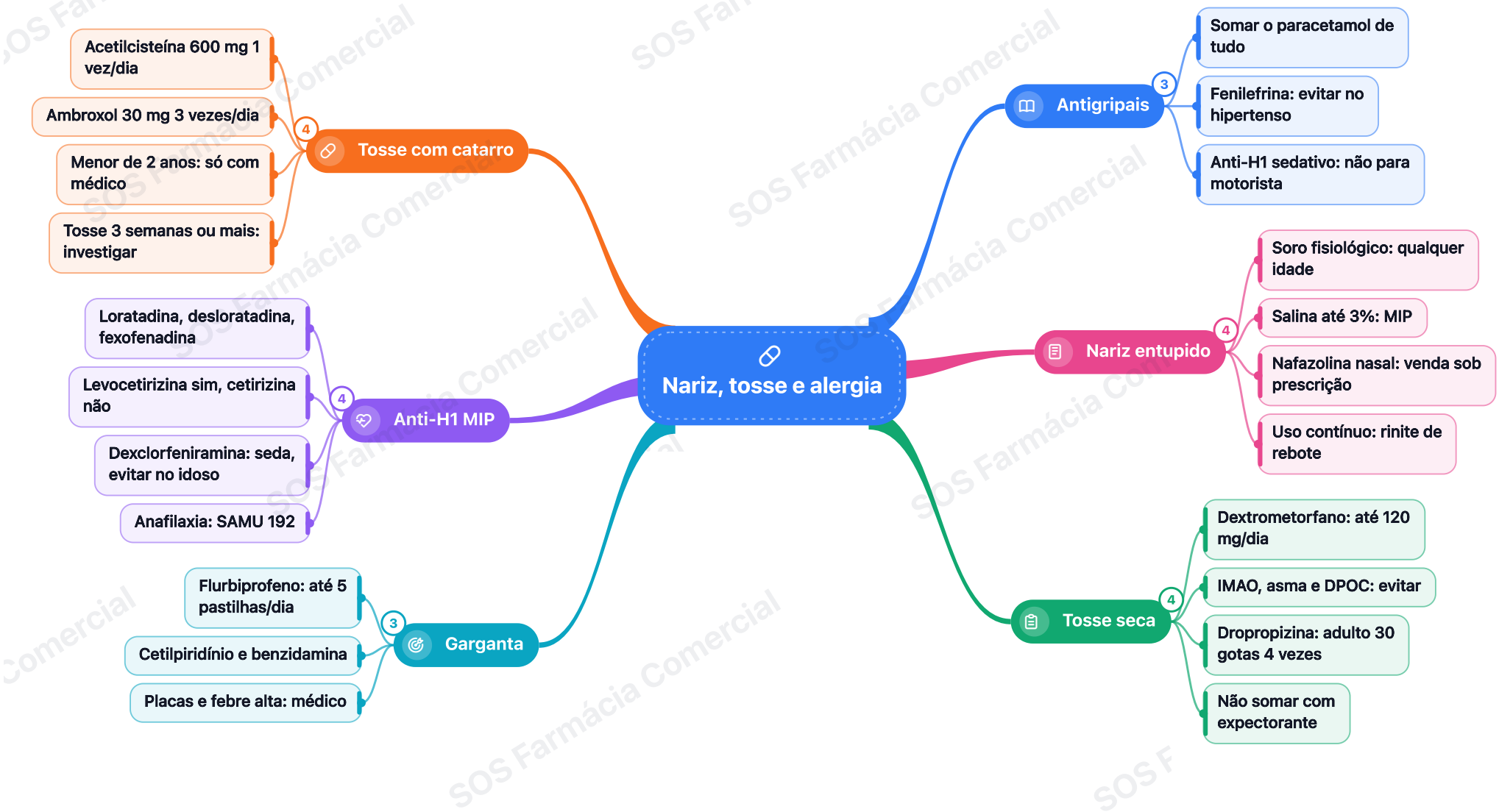
Sintomas digestivos

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 12



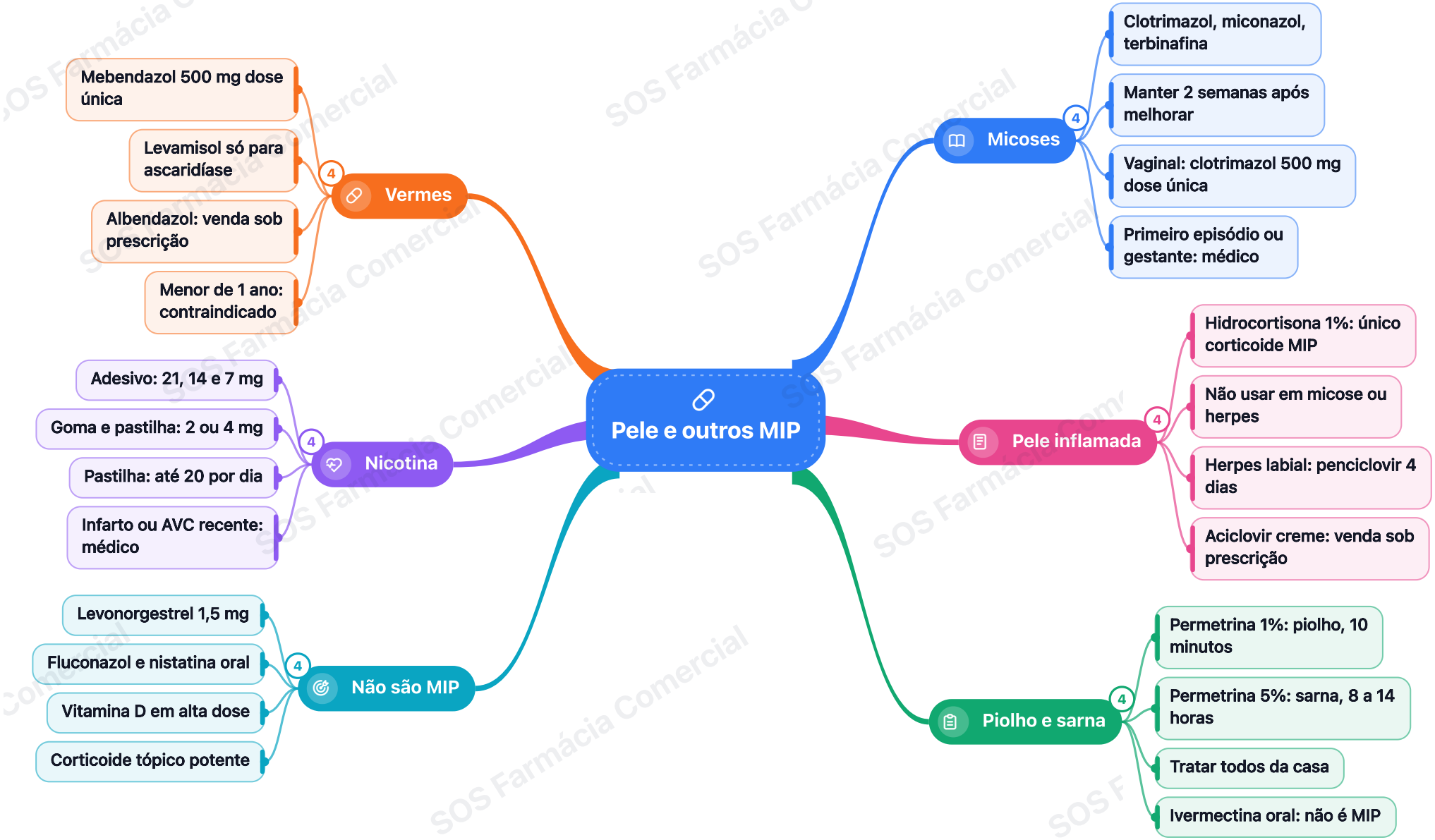
Respiratório alto e alergia

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 12



Pele, parasitas e outros MIP

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 12



Dispensação, indicação e prescrição farmacêutica

Aspecto	Dispensação	Indicação farmacêutica	Prescrição farmacêutica
Ponto de partida	Receita ou pedido de produto pelo nome	Queixa ou sintoma relatado	Necessidade de saúde identificada em consulta
Decisão do farmacêutico	Avaliar a receita, conferir o produto e orientar	Encaminhar ou tratar; escolher MIP ou medida não farmacológica	Selecionar, redigir, orientar e acompanhar a terapia
O que pode envolver	Qualquer medicamento, conforme receita e categoria de venda	Somente MIP e medidas não farmacológicas	MIP (art. 5º); tarjado só com diagnóstico prévio e protocolo ou acordo formal (art. 6º)
Base normativa	Lei 5.991/1973, art. 4º, XV; Lei 13.021/2014, arts. 13 e 14; RDC 44/2009, arts. 42 a 47	Res. CFF 585/2013, art. 7º, XXV; RDC 44/2009, art. 81, §2º, I, b	Res. CFF 586/2013 (sentença de 18/11/2024 declarou ilegal; recurso pendente)
Documento entregue	Receita devolvida ou retida conforme a regra do medicamento	Declaração de Serviço Farmacêutico, em duas vias	Documento de prescrição com os campos do art. 9º
Registro	Registros sanitários exigidos para o medicamento	Registro do serviço com consentimento (RDC 44/2009, art. 64)	Registro de todo o processo (Res. 586/2013, art. 16)
Erro típico	Entregar sem orientar ou sem avaliar a receita	Tratar sintoma com sinal de alerta	Prescrever tarjado sem protocolo ou modificar receita médica

A prescrição farmacêutica pela Resolução CFF nº 586/2013 está judicialmente contestada (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400). A indicação de MIP documentada na Declaração de Serviço Farmacêutico tem base na RDC nº 44/2009, vigente.

Modelo de documento de prescrição farmacêutica (campos do art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013)

Campo	Preenchimento	Base
Estabelecimento, consultório ou serviço	Nome, endereço, telefone (e CNPJ, se farmácia) _____	Art. 9º, I
Paciente	Nome completo _____ Contato (telefone) _____	Art. 9º, II

Campo	Preenchimento	Base
Terapia farmacológica	Medicamento pela DCB ou formulação _____ Concentração ou dinamização _____ Forma farmacêutica _____ Via _____	Art. 9º, III, a; arts. 10 e 11
Posologia	Dose _____ Frequência _____ Duração do tratamento _____	Art. 9º, III, b
Instruções adicionais	Como usar, o que evitar, quando parar _____	Art. 9º, III, c
Terapia não farmacológica ou outra intervenção	Medidas e, se houver, encaminhamento _____	Art. 9º, IV
Farmacêutico	Nome completo _____ CRF nº _____ Assinatura _____	Art. 9º, V
Local e data	_____, ____/____/_____	Art. 9º, VI

Regras de redação: em vernáculo, por extenso, legível, com nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras (art. 9º, caput). Vedado: documento sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e folhas assinadas em branco (art. 12). Vedado usar como propaganda (art. 15). O processo inteiro deve ser registrado (art. 16).

ATENÇÃO

O modelo reproduz os campos exigidos pela norma para fins de estudo. A Resolução nº 586/2013 foi declarada ilegal por sentença de 18/11/2024, ainda sujeita a recurso. Na drogaria, a indicação de MIP se documenta na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81), que pede, entre outros, o MIP indicado e a posologia, a orientação, data, assinatura e carimbo com CRF.

Sinais de alerta por queixa e prazo para reavaliar

Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Dor de cabeça	Início súbito e forte; mudança de padrão; febre com rigidez de nuca; déficit neurológico; início após 50 anos	Dor persistente por cerca de 15 dias	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de congestão nasal
Febre	Menor de 2 meses; menor de 6 meses com 38 °C retal; 40 °C acima de 6 meses; suspeita de arbovirose; exantema, dispneia, convulsão	Mais de 3 dias ou sem resposta ao antitérmico	CFF, guia de febre (2018)
Dor de garganta	Placas, febre e gânglios dolorosos sem tosse ou coriza; placas com disfagia	Sem melhora ou piora após melhora inicial	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de tosse
Tosse	Menor de 2 anos ou maior de 75; dispneia, chiado, dor torácica; escarro purulento ou com sangue; perda de peso	3 semanas, ou 7 dias de tratamento sem melhora	CFF, guia de tosse (2021)

Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Congestão e espirros	Obstrução unilateral; febre acima de 38 °C por mais de 24 h; secreção purulenta com dor facial	10 a 14 dias sem tratamento ou 7 dias com tratamento	CFF, guia de congestão nasal (2016)
Diarreia	Sangue ou muco; febre; desidratação; vômitos que impedem hidratação	Diarreia por 14 dias ou mais é persistente	MS, CAB 28 v. II
Azia e dispepsia	Disfagia, perda de peso, vômitos, sangramento, anemia; dor torácica com suor; até 12 anos	Mais de 7 dias apesar do antiácido	CFF, guia de azia (2020); MS, CAB 28 v. II
Dor lombar	Menor de 20 ou maior de 50 anos; dor noturna; câncer prévio; febre; fraqueza; alteração urinária ou intestinal; anestesia em sela	Dor refratária	MS, CAB 28 v. II
Sintomas urinários	Febre, dor no flanco; homem, gestante, criança; sangue na urina; corrimento	Toda suspeita de infecção deve ser avaliada	MS, CAB 28 v. II
Olho vermelho	Dor forte, baixa visual, fotofobia, pupila alterada, trauma ou produto químico	Irritação simples sem melhora	MS, CAB 28 v. II

Prazos de bula do MIP, quando menores, prevalecem. Constipação e lesões de pele seguem a prática clínica geral (ver tópico de sinais de alerta).

SOS Farmácia Comercial

Atendimento de uma queixa no balcão

Cliente relata sintoma ou pede um MIP pelo nome

Acolher e, se a queixa for íntima, levar a local reservado

Anamnese: para quem, idade e peso, sintoma, duração, o que já usou, doenças, medicamentos, gestação ou amamentação

Aferir pressão ou temperatura quando ajudar a decisão

DECISÃO

Há sinal de gravidade imediata?

SIM

Acionar SAMU (192) ou encaminhar ao pronto atendimento, sem oferecer MIP

NÃO

Seguir para a checagem de alertas

DECISÃO

Há sinal de alerta, prazo vencido ou dúvida?

SIM

Encaminhar por escrito à unidade de saúde ou ao médico assistente

NÃO

Problema autolimitado: montar plano de cuidado

Escolher medida não farmacológica e, se necessário, MIP adequado ao paciente (conferir LMIP, bula e interações)

Orientar dose, intervalo, dose máxima, duração, efeitos esperados e quando procurar atendimento; pedir que o paciente repita

ATENÇÃO

Não usar tarjado, não trocar receita, não indicar por comissão

Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico e registrar o atendimento com consentimento

Combinar retorno; registrar o resultado e encaminhar se não houver melhora no prazo

Checklist do atendimento de queixa com MIP

- ◯ Identificar para quem é o medicamento e se a pessoa está presente
- ◯ Perguntar idade e, em criança, o peso atual
- ◯ Perguntar sobre gestação ou amamentação
- ◯ Caracterizar o sintoma: local, intensidade, início e duração
- ◯ Perguntar sintomas associados e sinais de alerta da queixa
- ◯ Perguntar o que já usou, em que dose e com que resultado
- ◯ Listar doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo e alergias
- ◯ Decidir: urgência, encaminhamento ou manejo na farmácia
- ◯ Conferir na LMIP e na embalagem a forma, concentração e indicação
- ◯ Checar interações e contraindicações para aquele paciente
- ◯ Orientar dose, intervalo, dose máxima diária e duração
- ◯ Informar quando parar e quando procurar atendimento
- ◯ Confirmar o entendimento pedindo que o paciente repita
- ◯ Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico em duas vias
- ◯ Registrar o atendimento com consentimento do usuário
- ◯ Combinar retorno e registrar o desfecho

Declaração de Serviço Farmacêutico e documento de prescrição farmacêutica

Aspecto	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição farmacêutica
Norma	RDC nº 44/2009, art. 81 (Anvisa, vigente)	Resolução CFF nº 586/2013, art. 9º (contestada judicialmente)
Natureza	Registro sanitário do serviço prestado	Documento profissional no formato de receita
Quando emitir	Após qualquer serviço farmacêutico	Após o processo de prescrição
Conteúdo central	Estabelecimento com CNPJ, usuário, MIP indicado e posologia, parâmetros, orientação, plano, data, assinatura e CRF	Estabelecimento, paciente e contato, terapia com dose, frequência e duração, terapia não farmacológica, farmacêutico e CRF, local e data
Vias	Duas: usuário e arquivo	Não define número de vias; exige registro do processo
Proibições	Propaganda; indicar tarjado	Propaganda; forma secreta, codificada ou abreviada; folhas em branco

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma define hoje os critérios para enquadrar um medicamento como MIP?	RDC nº 882/2024 (vigente desde 1º/7/2024), que revogou a RDC nº 98/2016.
Qual instrução normativa traz a lista de MIP vigente?	IN nº 285/2024, com anexos alterados pela IN nº 388/2025 e pela IN nº 404/2025.
Quais formas nunca podem ser MIP?	Formas farmacêuticas injetáveis e produtos de terapia avançada (RDC nº 882/2024, art. 5º).
Associação de dois MIP é MIP automaticamente?	Não. A associação precisa cumprir os critérios do art. 4º; só o prazo de comercialização é dispensado (art. 10).
O que significa a coluna "concentração máxima" da LMIP?	Quantidade do fármaco na forma farmacêutica, e não a dose posológica (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, II).
MIP registrado antes da lista e ausente dela continua MIP?	Sim, até a Anvisa avaliar a pertinência do enquadramento (RDC nº 882/2024, art. 18).
Prazo para a empresa adequar o registro após inclusão na LMIP?	180 dias (RDC nº 882/2024, art. 13).
Qual MIP entrou na lista pela IN nº 404/2025?	Omeprazol 20 mg cápsula, para azia e queimação em dois ou mais dias na semana.
Diclofenaco é MIP?	Em gel e solução dermatológica, sim. Por via oral, não consta da LMIP.

Pergunta	Resposta
Frase do cartaz obrigatório na área de medicamentos?	Medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação: informe-se com o farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 41).
O que significa WWHAM?	Who, What, How long, Action, Medication: para quem, quais sintomas, há quanto tempo, o que já fez, que medicamentos usa.
Febre: depois de quantos dias encaminhar, pelo guia do CFF?	Mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico.
Tosse: quando encaminhar pelo tempo?	Tosse por 3 semanas ou mais, ou sem melhora após 7 dias de tratamento (guia de tosse do CFF).
Criança com menos de 2 meses e febre: conduta?	Avaliação hospitalar sempre (guia de febre do CFF). Não indicar antitérmico como substituto.
Etapas do processo de prescrição (art. 7º da Res. 586/2013)?	Necessidades, objetivo, seleção, redação, orientação, avaliação dos resultados e documentação.
Condições para o farmacêutico prescrever tarjado pela Res. 586/2013?	Diagnóstico prévio, previsão em programa, protocolo ou acordo de colaboração formal e título de especialista na área clínica.
O que decidiu a sentença de 18/11/2024 sobre a Res. 586/2013?	Declarou-a inconstitucional e ilegal e proibiu sua aplicação no país; está sujeita a duplo grau e o CFF recorreu.
Quantas vias tem a Declaração de Serviço Farmacêutico?	Duas: uma para o usuário e outra arquivada no estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 81, §4º).

Questões de fixação

1. Sobre o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição no Brasil, em outubro de 2026, assinale a correta.

A Os critérios estão na RDC nº 98/2016, e a lista na IN nº 86/2021.

B Os critérios estão na RDC nº 882/2024, e a lista na IN nº 285/2024.

C Os critérios estão na RDC nº 44/2009, e a lista na RDC nº 96/2008.

D Os critérios estão na Lei nº 13.021/2014, e a lista na IN nº 11/2016.

E Os critérios estão na RDC nº 138/2003, e a lista é a de grupos terapêuticos.

2. Um laboratório quer enquadrar como MIP uma associação em dose fixa de dois fármacos que já são MIP isoladamente. Pela RDC nº 882/2024:

A a associação é MIP automaticamente, porque cada componente já está na LMIP.

B a associação só pode ser MIP se for apresentada em forma injetável de dose única.

C a associação deve cumprir o art. 4º, dispensado só o prazo de comercialização.

D a associação nunca pode ser MIP, por proibição expressa de doses fixas na norma.

E basta a empresa notificar à Anvisa a alteração de rotulagem e de bula do produto.

3. Cliente pede ibuprofeno sem receita. Na prateleira há ibuprofeno 400 mg comprimido, ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata e ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL. Pela LMIP vigente:

A as três apresentações são MIP, porque o fármaco ibuprofeno consta da lista.

B nenhuma é MIP, porque todo anti-inflamatório oral exige receita no Brasil.

C 400 mg e suspensão (adulto) são MIP; o 600 mg imediato não consta.

D só a suspensão é MIP, porque a lista restringe o ibuprofeno ao uso pediátrico.

E o 600 mg é MIP, e o 400 mg exige receita por ser concentração menor que a da lista.

4. Em relação à exposição de MIP em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009), é correto afirmar:

A MIP ficam ao alcance do usuário, agrupados pela DCB e separados de outros produtos.

B MIP devem ficar sempre atrás do balcão, em área restrita, como os demais medicamentos.

C MIP podem ser expostos junto a cosméticos e alimentos, sem necessidade de separação.

D MIP podem ser expostos em supermercados, desde que haja farmacêutico no horário.

E o cartaz sobre automedicação é obrigatório apenas na área dos medicamentos tarjados.

5. Mãe relata que o filho de 7 semanas está com 38,3 °C desde a manhã, mamando menos. A conduta do farmacêutico, segundo o guia de febre do CFF, é:

A indicar paracetamol em gotas pelo peso e reavaliar a criança em 72 horas.

B indicar dipirona em gotas pelo peso e orientar banho morno se a febre subir.

C orientar compressas, roupas leves e observar a evolução por 24 horas.

D indicar ibuprofeno em suspensão pelo peso, alternando com paracetamol.

E não indicar antitérmico e encaminhar já para avaliação hospitalar.

6. Homem de 58 anos pede omeprazol 20 mg MIP para azia que começou há um mês e relata dificuldade para engolir e perda de 4 kg. A conduta adequada é:

A dispensar omeprazol 20 mg pelo prazo da bula e reavaliar o paciente no retorno.

B encaminhar ao médico, pois há sinais de alarme para azia.

C indicar antiácido com magnésio e alumínio por 7 dias e orientar dieta fracionada.

D dispensar omeprazol 40 mg, mais eficaz para sintomas que já duram um mês.

E indicar chá de espinheira-santa, elevar a cabeceira e reavaliar em 30 dias.

7. Pela Resolução CFF nº 586/2013, a prescrição de medicamento cuja dispensação exige prescrição médica pelo farmacêutico:

A é livre para o farmacêutico inscrito no CRF há mais de cinco anos, em qualquer local.

B é permitida em drogarias, desde que registrada na Declaração de Serviço Farmacêutico.

C exige diagnóstico prévio, protocolo ou acordo formal e título clínico.

D é permitida para renovar qualquer receita vencida de medicamento de uso contínuo.

E depende apenas de autorização verbal do médico que acompanha o paciente.

8. Entre os componentes mínimos do documento de prescrição farmacêutica previstos no art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013, NÃO consta:

A o diagnóstico nosológico do paciente com código da CID.

B o nome completo e o contato do paciente.

C a dose, a frequência e a duração do tratamento.

D o nome, a assinatura e o número de registro do farmacêutico no CRF.

E a identificação do estabelecimento, consultório ou serviço.

9. Sobre a situação da Resolução CFF nº 586/2013 em outubro de 2026, é correto afirmar:

A foi revogada expressamente pelo CFF e substituída pela Resolução nº 5/2025, em vigor.

B foi confirmada pelo STF, com efeito vinculante para todo o país.

C nunca foi questionada judicialmente.

D foi declarada ilegal por sentença de 2024, sujeita a duplo grau, com recurso do CFF.

E foi incorporada à RDC nº 44/2009 pela Anvisa.

10. Idosa de 80 anos, com insônia e rinite, pede um antialérgico "que dê sono". Considerando os Critérios de Beers 2023, a melhor conduta é:

A indicar dexclorfeniramina à noite, pois o mesmo comprimido trata os dois problemas.

B indicar prometazina, que é mais sedativa e tem efeito mais longo durante a noite.

C indicar antigripal com clorfeniramina, que também descongestiona o nariz.

D evitar anti-H1 de 1ª geração; para a rinite, um de 2ª geração.

E indicar dois anti-histamínicos diferentes ao mesmo tempo para somar os efeitos.

11. Sobre a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009), assinale a INCORRETA.

A É emitida em duas vias, uma entregue ao usuário e outra arquivada no estabelecimento.

B Pode registrar a indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia.

C Pode indicar tarjado se o farmacêutico for especialista.

D Deve conter data, assinatura e carimbo com a inscrição do farmacêutico no CRF.

E Leva frase de alerta quando há aferição de parâmetros fisiológicos ou exames.

12. Representante de laboratório oferece ao farmacêutico de uma drogaria um prêmio por caixa vendida de determinada marca de MIP. Do ponto de vista ético e normativo, é correto afirmar que:

A é permitido, desde que o prêmio recebido seja declarado no imposto de renda.

B é permitido para MIP, pois a restrição ética alcança apenas os tarjados.

C é permitido se o produto premiado for mais barato que o concorrente direto.

D é vedado apenas quando o farmacêutico for o responsável técnico da drogaria.

E é vedado: a vantagem comercial não pode guiar a indicação.

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **B**. A RDC nº 882/2024 revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27) e vige desde 1º/7/2024. A LMIP está na IN nº 285/2024, alterada pelas INs nº 388/2025 e nº 404/2025. A IN nº 86/2021 e a IN nº 11/2016 foram substituídas; a RDC nº 44/2009 trata de boas práticas em farmácias; a RDC nº 96/2008 trata de propaganda; a RDC nº 138/2003 é o modelo antigo.
2. **C**. O art. 10 diz que o enquadramento de fármacos isolados não garante o da associação, que deve cumprir o art. 4º; o parágrafo único dispensa os prazos do inciso I quando todos os componentes já fazem parte de MIP. Injetáveis não podem ser MIP (art. 5º). Não há proibição geral de associação MIP, e o enquadramento depende de decisão da Diretoria Colegiada pela atualização da LMIP (art. 11).
3. **C**. A isenção vale para o mesmo IFA, forma, indicação e concentração igual ou inferior à da linha (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º). A LMIP lista ibuprofeno 400 mg, suspensão 100 mg/mL e 200 mg/mL (esta com indicação em adultos) e 600 mg apenas em liberação prolongada (200 mg imediata e 400 mg prolongada). O 600 mg de liberação imediata não está na lista.
4. **A**. O art. 40, §2º permite o autosserviço de MIP; o art. 41, §1º exige agrupamento por princípio ativo com identificação pela DCB e o §2º, separação dos demais produtos. O cartaz do art. 41 é obrigatório na área de medicamentos. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto e dispensário (Lei nº 5.991/1973, art. 6º).
5. **E**. O guia de febre do CFF (2018) estabelece que crianças menores de 2 meses com febre devem sempre ser avaliadas em hospital, e que o antitérmico pode descaracterizar sinais de doença grave. As demais alternativas tratam ou adiam a avaliação de um lactente de alto risco.
6. **B**. O guia de azia do CFF e o CAB 28 v. II tratam disfagia, perda de peso e idade acima de 50 anos com sintoma novo como sinais de alarme, que exigem encaminhamento. A inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP (IN nº 404/2025) vale para azia frequente sem alarme. Omeprazol 40 mg não consta da LMIP, e tratar o sintoma atrasaria o diagnóstico.
7. **C**. O art. 6º condiciona a prescrição de tarjados a diagnóstico prévio e a programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados em instituições de saúde, ou a acordos de colaboração formais; o §1º exige título de especialista na área clínica. A Declaração não pode ser usada para indicar tarjado (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º). Acordo de colaboração é parceria formal, não verbal (glossário).
8. **A**. O art. 9º exige identificação do estabelecimento (I), nome e contato do paciente (II), descrição da terapia farmacológica com dose, frequência e duração (III), terapia não farmacológica (IV), identificação do farmacêutico com CRF (V) e local e data (VI). Diagnóstico com CID não é componente previsto.
9. **D**. A sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400) declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da norma, proibiu sua aplicação e ficou sujeita ao duplo grau obrigatório; o CFF recorreu. A Resolução nº 5/2025 foi suspensa por liminar em 31/03/2025. Não houve decisão do STF localizada nem incorporação pela Anvisa.
10. **D**. Os Critérios de Beers 2023 recomendam evitar anti-histamínicos de primeira geração em idosos (altamente anticolinérgicos, risco de confusão e queda). Dexclorfeniramina, prometazina e clorfeniramina são de primeira geração. Para rinite, há anti-histamínicos de segunda geração na LMIP; insônia pede abordagem não farmacológica e, se persistente, avaliação.
11. **C**. O art. 81, §3º proíbe usar a Declaração para propaganda ou para indicar medicamento que exige prescrição, sem exceção por titulação. As demais alternativas reproduzem o art. 81: duas vias (§4º), indicação de MIP e posologia (§2º, I, b), data, assinatura e carimbo com CRF (§2º, I, h) e frase de alerta (§2º, I, d).
12. **E**. O Código de Ética (Resolução CFF nº 724/2022) proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia em relação a interesses comerciais (art. 14). A regra vale para MIP e para qualquer farmacêutico, responsável técnico ou não.

Tabela-mestra de posologia de MIP

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Paracetamol	Comprimido 500 e 750 mg; gotas 200 mg/mL	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 h	4 g	10 a 15 mg/kg/dose, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg: médico	Hepatotoxicidade; somar antigripais
Dipirona	Comprimido até 1 g; gotas 500 mg/mL	500 a 1000 mg até 4 vezes/dia	4 g	Gotas por faixa de peso (bula); contraindicada abaixo de 3 meses ou 5 kg	Agranulocitose; hipotensão
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg	500 a 1000 mg a cada 4 a 8 h	4 g (8 comprimidos)	A partir de 12 anos: 500 mg, até 3/dia; nunca em virose	Reye; dengue; sangramento
Ibuprofeno	Comprimido 400 mg; suspensão 100 e 200 mg/mL	400 mg a cada 4 a 6 h, com alimento	1200 mg sem prescrição	A partir de 6 meses: 5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 h, até 4 doses	Estômago, rim, pressão; dengue
Naproxeno sódico	Comprimido 275 e 550 mg	275 mg 1 a 2 vezes/dia ou 550 mg 1 vez/dia	550 mg; até 10 dias	Não indicado abaixo de 12 anos	Estômago, rim, pressão
Diclofenaco gel	Gel 10 e 23,2 mg/g	Aplicar 3 a 4 vezes/dia ou conforme bula	Conforme bula	Aerossol: a partir de 14 anos	Pele íntegra; lavar as mãos
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	1 pastilha a cada 3 a 6 h	5 pastilhas; até 3 dias	Não usar abaixo de 12 anos	Restrições de AINE
Butilescopolamina	Comprimido 10 mg; gotas 10 mg/mL	10 a 20 mg, 3 a 5 vezes/dia	100 mg	1 a 6 anos: 5 a 10 mg 3 vezes/dia; lactente: pediatra	Glaucoma; retenção urinária

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Simeticona	Comprimido 40 mg; emulsão 75 mg/mL	40 a 125 mg a cada 6 h	500 mg	2 a 12 anos: 15 a 30 mg/dose; até 180 mg/dia	Dor por mais de 36 h: médico
Alumínio + magnésio + simeticona	Suspensão oral	10 a 20 mL entre refeições e ao deitar	12 colheres-medida; até 2 semanas	A partir de 12 anos	Espaçar 2 h de outros fármacos
Omeprazol MIP	Cápsula 20 mg, caixa de 7 ou 14	20 mg em jejum 1 vez/dia	20 mg; 14 dias; ciclo a cada 4 meses	Uso adulto	Sinais de alarme; clopidogrel
Sais de reidratação oral	Envelope para 1 L	75 mL/kg em 4 a 6 h na reidratação	Até 4 L nessa fase	Todas as idades; manter o aleitamento	Descartar após 24 h
Saccharomyces boulardii	Cápsula até 250 mg	200 mg 2 vezes/dia (Floratil®)	Conforme bula	Conforme bula	Mais de 5 dias: médico
Lactulose	Xarope 667 mg/mL	15 a 30 mL/dia	Ajustar para 2 a 3 evacuações/dia	1 a 5 anos 5 a 10 mL; 6 a 12 anos 10 a 15 mL	Gases no início
Bisacodil	Comprimido 5 mg	5 a 10 mg à noite	10 mg	Acima de 10 anos: 5 a 10 mg; 4 a 10 anos: 5 mg	Não tomar com leite, antiácido ou omeprazol
Óleo mineral	Líquido (LMN)	15 mL à noite	45 mL (30 à noite e 15 de manhã)	Acima de 6 anos: 1 a 2 mL/kg	Pneumonia lipoídica; até 1 semana
Loratadina	Comprimido 10 mg; xarope 1 mg/mL	10 mg 1 vez/dia	10 mg	2 a 12 anos abaixo de 30 kg: 5 mg	Pouca sedação
Desloratadina	Comprimido 5 mg; solução oral	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 11 meses 1 mg; 1 a 5 anos 1,25 mg; 6 a 11 anos 2,5 mg	Dose maior não melhora
Fexofenadina	Comprimido até 180 mg; suspensão 6 mg/mL	120 a 180 mg 1 vez/dia	180 mg	2 a 11 anos: 30 mg a cada 12 h	Antiácido e suco de fruta reduzem absorção

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Levocetirizina	Comprimido 5 mg	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez/dia	Ajustar em doença renal
Dexclorfeniramina	Comprimido 2 mg; solução	2 mg 3 a 4 vezes/dia	12 mg	6 a 12 anos até 6 mg/dia; 2 a 6 anos até 3 mg/dia; abaixo de 2 anos contraindicada	Sedação; evitar em idoso
Dextrometorfano	Solução até 3 mg/mL	10 a 20 mg a cada 4 h ou 30 mg a cada 6 a 8 h	120 mg	Conforme bula do produto	IMAO; asma; DPOC
Dropropizina	Gotas 30 mg/mL	30 gotas 4 vezes/dia	120 gotas	Acima de 3 anos: 15 gotas 4 vezes/dia	Só tosse seca
Acetilcisteína	Granulado 600 mg; xarope 20 e 40 mg/mL	600 mg 1 vez/dia por 5 a 10 dias	600 mg sem prescrição	2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes/dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Ambroxol	Xarope 6 mg/mL; pediátrico 3 mg/mL; cápsula LP 75 mg	30 mg 3 vezes/dia ou 75 mg 1 vez/dia	90 mg	2 a 5 anos 7,5 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 15 mg 3 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Bromexina	Xarope 0,8 e 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes/dia	24 mg	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes/dia	Hidratação junto
Mebendazol	Comprimido 500 mg; suspensão 20 mg/mL	500 mg dose única ou 100 mg 2 vezes/dia por 3 dias	Conforme esquema	Acima de 1 ano: mesma dose; 1 a 2 anos só se justificado	Evitar com metronidazol
Levamisol	Comprimido até 150 mg	150 mg dose única ao deitar	Dose única	Até 1 ano 40 mg; 1 a 7 anos 80 mg	Somente ascaridíase

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Permetrina 5%	Loção cremosa 50 mg/mL	Pescoço aos pés, remover após 8 a 14 h	30 g por aplicação (até 60 g)	6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g	Tratar todos os contatos
Permetrina 1%	Xampu ou loção 10 mg/mL	10 minutos no cabelo; repetir em 7 a 14 dias se preciso	1 aplicação por vez	Conforme bula	Pente fino
Deltametrina	Xampu ou loção 0,2 mg/mL	5 minutos no banho por 4 dias; repetir 7 dias depois	Conforme bula	Conforme bula	Irritação local
Clotrimazol vaginal	Comprimido 500 mg; creme 20 mg/g	500 mg dose única ou creme por 3 noites	Dose única	Não se aplica: menor de idade vai ao médico	Primeiro episódio e gestante: médico
Acetato de hidrocortisona	Creme ou pomada 1%	Camada fina 2 a 3 vezes/dia	Conforme bula	Até 4 anos: no máximo 3 semanas	Não usar em micose ou herpes
Penciclovir	Creme 10 mg/g	A cada 2 h acordado, por 4 dias	4 dias	Não recomendado abaixo de 12 anos	Iniciar no formigamento
Nicotina adesivo	7, 14 e 21 mg/24 h	21 mg/dia se mais de 10 cigarros/dia	1 adesivo/dia	NiQuitin®: contraindicado abaixo de 12 anos	Infarto ou AVC recentes: médico
Nicotina pastilha	2 e 4 mg	1 a cada 1 a 2 h nas semanas 1 a 6	20 pastilhas	Conforme bula	Não mastigar nem engolir
Sulfato ferroso	40 ou 60 mg de ferro; solução 25 mg/mL	1 comprimido ao dia em jejum	1 comprimido	6 a 18 meses 1 mL/semana; 18 meses a 6 anos 1 mL/dia; 6 a 12 anos 2 mL/dia	Intoxicação infantil; espaçar de levotiroxina
Ácido fólico	Solução 0,2 mg/mL	0,4 mg/dia (2 mL) na prevenção	1 mg (5 mL)	Conforme bula	Pode mascarar anemia perniciosa

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Fenazopiridina	Comprimido 200 mg	200 mg a cada 8 h após refeições	600 mg; até 2 dias	Não indicar	Não trata infecção urinária
Hidroxiquinolina + trolamina	Solução otológica	5 gotas 3 vezes/dia	Conforme bula	Conforme bula	Suspeita de perfuração: não usar
Nafazolina (colírio associado)	Solução oftálmica	1 a 2 gotas até 4 vezes/dia	4 aplicações	Conforme bula	Rebote; glaucoma

Doses conferidas na LMN (IN 106/2021), no guia de dengue do Ministério da Saúde (2024) e em bulas de referência citadas nos tópicos. Concentrações isentas conforme a LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025). A bula do produto entregue prevalece: limites e gotas por mL variam entre marcas.

Evitar ou ter cautela: grupos especiais

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Gestante	AAS e AINE orais (contraindicados no 3º trimestre); dipirona (bula da Novalgina®); antigripal com fenilefrina; óleo mineral; mebendazol; tiabendazol tópico; anti-H1 sem pré-natal	Qualquer MIP sem conhecimento do pré-natal; antiácido com bicarbonato de sódio	Paracetamol na menor dose e pelo menor tempo; soro nasal; medidas não farmacológicas; encaminhar ao pré-natal
Lactante	Anti-H1 de primeira geração (sedação do bebê, menos leite); dipirona (bula); uso prolongado de laxante estimulante	AAS; descongestionantes orais; fitoterápicos sem dados	Paracetamol; ibuprofeno em dose usual; anti-H1 de segunda geração com orientação
Idoso	Anti-H1 de primeira geração; antigripal com anti-H1 e fenilefrina; AINE oral contínuo; óleo mineral (aspiração)	Dipirona (hipotensão); escopolamina; antiácido com magnésio ou alumínio se rim comprometido; bisacodil crônico	Paracetamol; AINE tópico; loratadina ou fexofenadina; laxante formador de massa ou osmótico
Hipertenso	Fenilefrina oral; isometepteno; AINE oral regular; sal de fruta (bicarbonato de sódio); alcaçuz	Cafeína em associações; guaraná e ginseng; vasoconstritor ocular frequente	Paracetamol; soro nasal; anti-H1 de segunda geração isolado; AINE tópico

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Anticoagulado	AAS; AINE orais; salicilato de metila em área extensa; guaco; *Salix alba*	Paracetamol regular com varfarina (eleva o INR); omeprazol com varfarina; gengibre em dose alta	Paracetamol em uso pontual; AINE tópico em área pequena; orientar sinais de sangramento
Asmático	AAS e AINE se já houve crise com analgésico; dextrometorfano (bula); dropropizina	Dipirona (reação cruzada possível); anti-H1 sedativo	Paracetamol; encaminhar tosse com chiado
Doença renal	AINE oral; antiácidos com magnésio ou alumínio de uso contínuo; fenazopiridina	Levocetirizina (ajuste); dipirona em dose alta	Paracetamol; encaminhar qualquer uso prolongado

Quadro de triagem para o balcão. Gestantes, lactantes e pessoas com doença crônica devem ter o uso de qualquer MIP comunicado ao médico assistente.

Pedidos comuns que não são MIP

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Dimenidrinato (Dramin®, Dramin B6®)	Venda sob prescrição (bula)	Cinetose: meclozina 50 mg ou gengibre, se MIP na embalagem; vômito: sais de reidratação e encaminhar
Metoclopramida, bromoprida, ondansetrona	Venda sob prescrição	Encaminhar
Loperamida (Imosec®)	Venda sob prescrição (bula)	Sais de reidratação; *S. boulardii*; encaminhar se sinal de alarme
Racecadotrila (Tiorfan®)	Venda sob prescrição (bula)	Idem
Famotidina e demais anti-H2	Fora da LMIP	Antiácido, alginato ou omeprazol 20 mg MIP
Nafazolina e oximetazolina nasais	Venda sob prescrição (Neosoro®, Sorine®, Afrin®)	Soro fisiológico ou salina hipertônica
Cetirizina (Zyrtec®)	Venda sob prescrição (bula)	Levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina
Nimesulida oral, cetoprofeno, diclofenaco oral	Fora da LMIP	Ibuprofeno ou naproxeno em dose MIP; nimesulida ou diclofenaco gel
Aciclovir creme (Zovirax®)	Venda sob prescrição (bula)	Penciclovir creme 10 mg/g

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Albendazol (Zentel®)	Venda sob prescrição (bula)	Mebendazol, quando indicado
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Permetrina ou deltametrina tópicas; encaminhar
Fluconazol	Fora da LMIP	Clotrimazol ou miconazol vaginal, com critérios
Levonorgestrel 1,5 mg (Postinor Uno®)	Venda sob prescrição (bula)	Encaminhar com urgência à UBS ou UPA, que fornecem gratuitamente
Corticoides tópicos de média e alta potência	Fora da LMIP	Acetato de hidrocortisona 1%
Vitamina D em alta dose, ferro polimaltosado, complexo B em alta dose	Venda sob prescrição nos produtos conferidos	Carbonato de cálcio + vitamina D3 e sulfato ferroso da LMN, com critério
Minoxidil tópico	Fora da LMIP	Alfaestradiol solução capilar; dermatologista

Status conferido na LMIP vigente e nas bulas dos produtos citados (outubro de 2026). Tarja vermelha sem retenção de receita continua exigindo prescrição.

Orientação na entrega do MIP

- ◯ Identificar quem vai usar: idade, peso (criança), gestação e amamentação
- ◯ Conferir na embalagem se o produto é MIP (sem tarja) e a concentração
- ◯ Perguntar sobre doenças de fígado, rim, estômago, pressão, asma, glaucoma e próstata
- ◯ Revisar medicamentos em uso, inclusive outros MIP, chás e fitoterápicos
- ◯ Checar duplicidade de princípio ativo (paracetamol em antigripal)
- ◯ Informar a dose na unidade que o cliente vai medir (comprimido, mL, gotas)
- ◯ Mostrar o dosador do frasco e conferir quantas gotas tem cada mL
- ◯ Informar o intervalo entre doses e a dose máxima em 24 horas
- ◯ Informar por quantos dias usar sem reavaliação
- ◯ Explicar o efeito adverso mais comum e o que fazer se ocorrer

- ◯ Explicar os sinais de alarme que exigem procurar atendimento
- ◯ Orientar armazenamento e manter fora do alcance de crianças
- ◯ Entregar a orientação por escrito quando houver cálculo de dose
- ◯ Em suspeita de dengue: sem AAS e sem AINE, hidratar e encaminhar
- ◯ Registrar a indicação farmacêutica e combinar retorno ou acompanhamento

SOS Farmácia Comercial

Escolha do analgésico ou antitérmico

Cliente com febre ou dor leve a moderada pede analgésico ou antitérmico

DECISÃO

Há sinal de gravidade? (febre em menor de 3 meses, rigidez de nuca, manchas, falta de ar, sonolência, dor súbita e intensa)

SIM

Não dispensar como autocuidado: encaminhar para atendimento de urgência

NÃO

Seguir para a avaliação de dengue

DECISÃO

Pode ser dengue? (época de transmissão, febre com dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas)

SIM

Paracetamol ou dipirona, nada de AAS, AINE ou corticoide; hidratação oral; encaminhar para avaliação e notificação

NÃO

Seguir

DECISÃO

É criança ou adolescente com gripe, catapora ou outra virose?

SIM

Paracetamol ou dipirona com dose pelo peso; AAS proibido (síndrome de Reye)

NÃO

Seguir

DECISÃO

Há contraindicação a AINE? (úlcera ou sangramento, anticoagulante, doença renal, hipertensão ou cardiopatia, asma por AINE, gestação)

SIM

Paracetamol ou dipirona; AINE tópico se a dor for localizada

NÃO

Seguir

DECISÃO

A dor tem componente inflamatório? (cólica menstrual, dor muscular, dor de dente, entorse)

SIM

Ibuprofeno ou naproxeno em dose MIP, com alimento, pelo menor tempo

NÃO

Paracetamol ou dipirona

Checar doença hepática, etilismo, G6PD, alergia a pirazolonas e produtos em uso com o mesmo ativo

Calcular a dose pelo peso na criança e conferir as gotas por mL do frasco entregue

Orientar intervalo, dose máxima, um antitérmico só (sem alternar) e hidratação

ATENÇÃO

Procurar atendimento se a febre passar de 72 horas, se houver piora ou sinal de alarme

Registrar a indicação e a orientação dada

Cartões: classes de MIP

Pergunta	Resposta
Qual norma traz hoje a lista de MIP?	IN 285/2024 (Anexo I sintéticos, Anexo II fitoterápicos), com Anexo I republicado pela IN 404/2025.
A concentração máxima da LMIP é dose diária?	Não. É a quantidade do insumo na forma farmacêutica (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).
Dose máxima diária de paracetamol no adulto?	4 g em 24 horas, até 1 g por dose (LMN).
Dose pediátrica de paracetamol?	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg, médico.
Idade e peso mínimos para dipirona?	3 meses e 5 kg (bula da Novalgina®).
Antitérmicos indicados na dengue suspeita?	Paracetamol e dipirona (MS, 2024). Sem AAS, AINE ou corticoide.
Por que não dar AAS a criança com gripe?	Risco de síndrome de Reye (bula da Aspirina®).

Pergunta	Resposta
Dose máxima de ibuprofeno sem prescrição no adulto?	1200 mg/dia (bula do Advil® 400 mg).
Nimesulida comprimido é MIP?	Não. Só a nimesulida gel 20 mg/g consta da LMIP.
Condições do omeprazol MIP?	20 mg, caixas de 7 ou 14, azia 2 ou mais dias/semana, até 14 dias, intervalo de 4 meses.
Dimenidrinato é MIP?	Não. Dramin® e Dramin B6® têm venda sob prescrição; meclozina 50 mg consta da LMIP para cinetose.
Loperamida e racecadotrila são MIP?	Não. Imosec® e Tiorfan® têm venda sob prescrição.
Nafazolina nasal é MIP?	Não. Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP; soro fisiológico é a opção isenta.
Cetirizina ou levocetirizina: qual é MIP?	Levocetirizina 5 mg. Cetirizina não consta da LMIP.
Antiviral tópico MIP para herpes labial?	Penciclovir creme 10 mg/g, a cada 2 h acordado por 4 dias. Aciclovir creme não é MIP.
Permetrina 5%: quanto tempo na pele?	Remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação.
Antiparasitários orais da LMIP?	Mebendazol (500 mg e 20 mg/mL) e levamisol (até 150 mg). Albendazol não.
Esquema do adesivo de nicotina para quem fuma mais de 10 cigarros/dia?	21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas.
Levonorgestrel 1,5 mg é MIP?	Não. Venda sob prescrição; usar até 72 h; repetir se vomitar em 4 h.
Sulfato ferroso e ácido fólico 0,2 mg/mL são isentos por quê?	São medicamentos de notificação simplificada da LMN (IN 106/2021), de venda isenta por definição.

Questões: casos de balcão com MIP

1. Durante surto de dengue, mulher de 30 anos chega com febre de 39 °C há 2 dias, dor no corpo e dor atrás dos olhos, sem sinais de alarme. Pede ibuprofeno porque "funciona melhor". Qual a conduta adequada?

A Dispensar ibuprofeno 400 mg a cada 6 horas por ser MIP

B Indicar paracetamol ou dipirona, hidratação oral e encaminhar para avaliação

C Indicar AAS 500 mg, que tem efeito antitérmico mais duradouro

D Indicar naproxeno 550 mg 1 vez ao dia para reduzir o número de doses

E Alternar ibuprofeno e paracetamol a cada 3 horas

2. Cliente pede "Dramin" para enjoo em viagem de ônibus amanhã. Sobre o enquadramento regulatório, assinale a correta.

A Dimenidrinato consta da LMIP e pode ser indicado livremente

B Todos os antieméticos orais são MIP desde a IN 285/2024

C Dimenidrinato é MIP apenas quando associado à piridoxina

D Dimenidrinato não consta da LMIP; a meclozina 50 mg consta, para cinetose

E A metoclopramida é a alternativa MIP ao dimenidrinato

3. Criança de 4 anos e 16 kg com febre de 38,8 °C. A mãe tem dipirona gotas 500 mg/mL (20 gotas = 1 mL). Pela bula da Novalgina®, qual faixa de dose por tomada é adequada?

A 5 a 15 gotas por dose, até 4 vezes ao dia

B 20 a 40 gotas por dose, até 4 vezes ao dia

C 1 gota por kg, até 6 vezes ao dia

D 2 a 5 gotas por dose, no máximo 20 gotas ao dia

E 40 gotas em dose única diária

4. Homem de 70 anos, em uso de losartana, hidroclorotiazida e varfarina, pede ibuprofeno para dor no joelho após caminhada. Qual a melhor conduta farmacêutica?

A Ibuprofeno 400 mg 3 vezes ao dia por 10 dias

B Naproxeno 550 mg 1 vez ao dia por ser de dose única

C AAS 500 mg, por ter menor risco renal que o ibuprofeno

D Nimesulida comprimido, que é mais seletiva

E AINE tópico no joelho e, se preciso, paracetamol em uso pontual

5. Sobre o omeprazol incluído na LMIP pela IN 404/2025, é correto afirmar:

A Qualquer apresentação de 20 mg passou a ser isenta, inclusive caixas de 28

B A isenção abrange 40 mg em uso contínuo para refluxo

C Vale para 20 mg em caixas de até 14 unidades, por até 14 dias, para azia frequente

D A isenção depende de retenção de receita do farmacêutico

E O ciclo pode ser repetido livremente após 7 dias de pausa

6. Adolescente de 13 anos com catapora e febre. O pai quer "aspirina infantil". Qual o principal motivo para recusar e orientar outro antitérmico?

A Hepatotoxicidade dose-dependente do AAS

B Risco de síndrome de Reye com AAS em virose na infância e adolescência

C AAS não tem efeito antitérmico em crianças

D AAS infantil foi retirado da LMIP em 2025

E Risco de agranulocitose idiossincrásica

7. Cliente pede "Neosoro" para nariz entupido por resfriado. Assinale a afirmação correta.

A Nafazolina nasal é MIP por ser de uso tópico

B O uso por mais de 15 dias é seguro em adultos

C Pode ser indicada para bebês por ter baixa concentração

D É indicada como primeira escolha em hipertensos

E Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP e causam rebote

8. Motorista de ônibus de 45 anos com rinite alérgica intermitente pede um antialérgico. Qual opção é MIP e mais adequada?

A Fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia

B Dexclorfeniramina 2 mg 4 vezes ao dia

C Cetirizina 10 mg 1 vez ao dia

D Hidroxizina 25 mg à noite

E Prometazina 25 mg comprimido

9. Mulher de 25 anos relata prurido vulvar intenso e corrimento branco grumoso sem odor, igual a episódio diagnosticado pelo ginecologista no ano anterior. Não está grávida e não tem outros sintomas. Qual conduta é compatível com a LMIP?

A Fluconazol 150 mg oral em dose única, que é MIP

B Metronidazol gel vaginal à noite por 7 noites seguidas

C Clotrimazol 500 mg vaginal em dose única, com orientação de retorno

D Creme vaginal com corticoide e antibiótico

E Nistatina suspensão oral por 7 dias, com bochecho

10. Mãe pede albendazol para os dois filhos (5 e 8 anos) com coceira anal noturna. Qual a conduta mais adequada?

A Dispensar albendazol 400 mg, que é MIP desde 2024

B Indicar levamisol, que trata oxiuríase em dose única

C Recusar qualquer antiparasitário e encaminhar ao pronto-socorro

D Indicar ivermectina em dose única para toda a família

E Mebendazol 500 mg em dose única para a família, higiene e repetição combinada

11. Fumante de 30 cigarros por dia, que acende o primeiro logo ao acordar, quer iniciar reposição de nicotina com pastilhas. Pela bula do NiQuitin® pastilha, qual a concentração e o limite diário?

A 2 mg, sem limite diário

B 4 mg, no máximo 20 pastilhas por dia

C 4 mg, no máximo 5 pastilhas por dia

D 2 mg, no máximo 9 pastilhas por dia

E 1 mg, a cada 30 minutos

12. Jovem de 19 anos pede "pílula do dia seguinte" sem receita, 20 horas após relação desprotegida. Qual a orientação correta sobre o levonorgestrel 1,5 mg?

A É MIP e pode ser prescrito pelo farmacêutico pela CFF 586/2013

B Só tem efeito se usado até 12 horas após a relação

C Atua interrompendo gravidez já implantada

D É tarjado, depende de prescrição e o SUS fornece gratuitamente

E Protege contra infecções sexualmente transmissíveis

Gabarito comentado

1. **B**. O guia do Ministério da Saúde (Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024) orienta paracetamol e/ou dipirona e proíbe salicilatos, AINE e corticoides pelo risco de sangramento. Ibuprofeno, naproxeno e AAS estão errados pelo mesmo motivo, e a alternância é desaconselhada e ainda inclui um AINE.
2. **D**. A conferência do Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025) não encontra dimenidrinato, e as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem venda sob prescrição médica. A lista inclui dicloridrato de meclozina 50 mg com indicação de cinetose e o fitoterápico *Zingiber officinale*. Metoclopramida também é tarjada.
3. **A**. Na tabela da bula, 16 a 23 kg (4 a 6 anos) recebe 5 a 15 gotas por dose, máximo 60 gotas/dia (4 tomadas de 15). A dose de 20 a 40 gotas é para maiores de 15 anos; 2 a 5 gotas é para 5 a 8 kg; as demais não constam da bula.
4. **E**. AINE oral com diurético e BRA aumenta o risco de lesão renal aguda, e com varfarina aumenta o risco de sangramento. AAS soma risco hemorrágico. Nimesulida oral não é MIP. O AINE tópico tem baixa exposição sistêmica; o paracetamol pontual é aceitável, lembrando que o uso regular pode elevar o INR.
5. **C**. A IN 404/2025 incluiu omeprazol 20 mg em cápsula dura e de liberação retardada, para sintomas de azia em 2 ou mais dias por semana. O voto da Diretoria Colegiada prevê apresentações de 7 a 14 unidades, uso por até 14 dias e intervalo de 4 meses entre ciclos; caixas maiores seguem sob prescrição (coexistência permitida pela RDC 882/2024, art. 14).
6. **B**. A bula da Aspirina® determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta, pelo risco de síndrome de Reye. Hepatotoxicidade dose-dependente é característica do paracetamol; agranulocitose, da dipirona. O AAS 500 mg segue na LMIP.
7. **E**. Nafazolina e oximetazolina nasais não constam da LMIP e as bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem venda sob prescrição. O uso prolongado causa rinite medicamentosa; a ingestão por crianças pequenas pode causar intoxicação grave; hipertensos devem evitar. A alternativa isenta é o soro fisiológico ou a salina hipertônica.
8. **A**. Fexofenadina até 180 mg consta da LMIP e quase não causa sedação (bula do Allegra®). Dexclorfeniramina é MIP, mas seda e prejudica a direção. Cetirizina, hidroxizina e prometazina oral não constam da LMIP.
9. **C**. Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal consta da LMIP para candidíase vaginal (bula do Gino-Canesten®: dose única). Fluconazol, metronidazol vaginal, associações com corticoide e nistatina oral não constam da lista. O caso preenche os critérios de tratamento no balcão: episódio recorrente com diagnóstico prévio, sem sinais de alarme.
10. **E**. Albendazol (bula do Zentel®) e ivermectina não são MIP. Levamisol é indicado só para ascaridíase. O mebendazol 500 mg (LMIP) trata *Enterobius* em dose única acima de 1 ano; por reinfecção, todos os moradores são tratados, com higiene e repetição após 2 semanas conforme orientação clínica. Pronto-socorro não é necessário sem sinal de alarme.
11. **B**. A bula orienta 4 mg para quem fuma nos primeiros 30 minutos após acordar e 2 mg para quem fuma depois; o máximo é 20 pastilhas por dia, com pelo menos 9 por dia nas semanas 1 a 6. Não existe pastilha de 1 mg na LMIP, cujo limite é 4 mg.
12. **D**. O levonorgestrel 1,5 mg não consta da LMIP e a bula do Postinor Uno® traz venda sob prescrição; por isso não entra na prescrição farmacêutica de MIP. Deve ser usado o quanto antes, até 72 horas, age principalmente sobre a ovulação, não interrompe gravidez implantada e não protege contra IST. O farmacêutico deve orientar o acesso rápido na UBS ou UPA.